

CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire | Régulation | Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

4.1 Compétences mobilisées 4

4.2 Croisement référentiel × précisions × indications 4

4.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 5

4.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 5

4.3 Cours 6

4.3.1 Les rôles de l'acte alimentaire 7

4.3.2 Le comportement alimentaire : besoin, oralité, pulsion 9

4.3.3 La régulation et la dérégulation du comportement alimentaire 10

4.3.4 Les déterminants du comportement alimentaire 18

4.3.5 L'évolution des pratiques alimentaires et le syncrétisme culinaire 22

4.3.6 Les principales pratiques alimentaires actuelles 25

4.3.7 Accompagner l'évolution des pratiques alimentaires 31

4.3.8 Les rythmes et la structure des prises alimentaires 33

4.3.9 Le développement du comportement alimentaire de l'enfant 37

4.3.10 Les comportements alimentaires selon les âges de la vie 41

4.3.11 Observer et mesurer les comportements alimentaires 46

4.3.12 Vers une alimentation durable : santé et environnement 50

4.3.13 Les troubles du comportement alimentaire : comprendre pour prévenir et orienter 54

4.3.14 Les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité 57

4.3.15 Les pratiques alimentaires religieuses en détail 60

4.3.16 La dégustation et l'analyse sensorielle au service de l'éducation 63

4.3.17 Repères sur quelques cultures culinaires 63

4.3.18 Fil rouge : les pratiques alimentaires des familles des Tilleuls 65

4.3.19 Six cas guidés pour s'entraîner à l'analyse d'un comportement alimentaire 66

4.4 Approfondissements 70

4.4.1 Le goût : un apprentissage 70

4.4.2 Manger en pleine conscience et approches non restrictives 72

4.4.3 La dimension sociale du repas et la santé 72

4.4.4 Le gaspillage alimentaire 72

4.4.5 Alimentation et ultra-transformation : comprendre le débat 72

4.4.6 Nouveaux aliments et acceptabilité : insectes et substituts végétaux 74

4.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 76

4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78

4.6.1 Préparer l'oral : défendre une analyse de comportement alimentaire 79

4.6.2 Préparer l'atelier culinaire : lire le contexte imposé avec les notions du chapitre 80

4.6.3 Dix questions d'entretien pour s'entraîner 81

4.7 L'essentiel à retenir 83

4.8 Entraînement 83

4.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 83

4.8.2 Exercices 85

4.8.3 Questions de réflexion 88

4.8.4 Étude de cas 89

4.8.5 Mises en situation express 89

4.8.6 Exercices complémentaires 92

4.8.7 Exercices d'approfondissement 93

4.9 Glossaire 94

4.10 Renvois bibliographiques par notion 95

4.12 Bibliographie numérotée..... 95

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- décrire les rôles de l'acte alimentaire (biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique) ;
- définir le comportement alimentaire et les notions de besoin, d'oralité et de pulsion ;
- expliquer la régulation du comportement alimentaire (faim, rassasiement, satiété ; régulation homéostatique et hédonique) et ses dérégulations (restriction cognitive, alimentation émotionnelle, troubles du comportement alimentaire) ;
- identifier les déterminants du comportement alimentaire d'un individu pour construire analyses, conseils et actions éducatives (objectif du guide 2025) ;
- décrire l'évolution des pratiques alimentaires en France et le syncrétisme culinaire ;
- présenter les principales pratiques alimentaires actuelles (végétarisme, flexitarisme, végétalisme, pratiques religieuses, régimes d'exclusion, alimentation durable) et leurs points de vigilance ;
- accompagner l'évolution des pratiques alimentaires sans jugement et en sécurité nutritionnelle.

4.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Comprendre les comportements d'un public pour concevoir des actions éducatives pertinentes	Analyse et diagnostic de situation ; priorités adaptées au contexte
C3.2	Adapter un atelier culinaire aux pratiques du public (végétarisme, religions, budget) et à la régulation (faim, plaisir)	Besoins et spécificités du public identifiés ; qualité organoleptique adaptée
C3.3	Interpréter les données de consommation (INCA, Albane)	Contexte et problématique identifiés
C3.5	Communiquer sans culpabiliser, respecter les choix	Posture professionnelle adaptée

4.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Rôles de l'acte alimentaire	Citer et illustrer les différents rôles	Approche pluridisciplinaire
Définition du comportement alimentaire ; besoin, oralité, pulsion	Définir ; distinguer besoin et envie	Pas de développement psychanalytique
Régulation et dérégulation	Expliquer faim, rassasiement, satiété ; restriction cognitive, alimentation émotionnelle	Physiologie détaillée en BPADN ; TCA : repérage et orientation (BC1)
Déterminants du comportement alimentaire	Analyser les déterminants d'un individu ou d'un groupe	Lien avec le chapitre 2
Évolution des pratiques, syncrétisme culinaire	Décrire les grandes évolutions	S'appuyer sur des données datées (Insee, Crédoc, CNA)
Principales pratiques actuelles	Présenter, repérer les points de vigilance nutritionnelle	Végétarisme, flexitarisme, religions, « sans », durable

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Accompagnement de l'évolution des pratiques	Adopter une posture non jugeante, sécuriser	Recommandations officielles

4.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Pratiques et comportements alimentaires ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 61). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les corrections sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 4.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 61	Rôles de l'acte alimentaire ; définition du comportement alimentaire	4.3.1 et 4.3.2
Guide 2025, p. 61	Besoin, oralité, pulsion	4.3.2 (dont l'encadré de vocabulaire)
Guide 2025, p. 61	Régulation et dérégulation des comportements alimentaires	4.3.3 ; 4.3.13 (repérage des TCA)
Guide 2025, p. 61	Déterminants du comportement alimentaire	4.3.4 (société, industrie, médias, genre, PCS) ; 4.3.14 (précarité)
Guide 2025, p. 61	Évolution des pratiques et syncrétisme culinaire ; principales pratiques actuelles	4.3.5 et 4.3.6 ; 4.3.15 et 4.3.17
Guide 2025, p. 61	Accompagnement de l'évolution des pratiques alimentaires	4.3.7 ; 4.3.12 (alimentation durable)
Référentiel, C3.1, C3.2, C3.3, C3.5	Diagnostic, adaptation de l'atelier, données datées, posture	4.3.8 à 4.3.18 ; 4.6

4.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport au fascicule *Environnement professionnel – Synthèse du cours en bref*, 1re année (CNED 3-6123-AN-WT-00-21), module 2 « Comportements et pratiques alimentaires : déterminants et évolutions » (p. 8 à 24). La psychologie du développement et la sociologie générale (module 5) sont traitées au chapitre 3.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M2 S1 §1 (p. 8)	Rôles de l'alimentation : points de vue alimentaire, santé, socio-économique	4.3.1
M2 S1 §2 (p. 9 à 11)	Facteurs du comportement : genre (INCA 3), famille, CSP, communication, qualités sensorielles, psychologie	4.3.4 (dont genre et catégorie sociale)
M2 S1 §3 (p. 12)	Prises alimentaires ; faim et satiété ; déterminants de la prise	4.3.3
M2 S1 §4 (p. 13)	Pulsion, besoins nutritionnels, oralité (Abadie)	4.3.2
M2 S2 §1 à §3 (p. 14 à 16)	Famille ; société traditionnelle et société moderne ; mythes et rites	4.3.4 (mangeur hypermoderne, mythes, rites) ; 4.3.5
M2 S2 §4 (p. 16 et 17)	Industrie agroalimentaire, grande distribution, médias	4.3.4 (industrie, distribution, médias)
M2 S2 §5 et §6 (p. 18 et 19)	CSP et classes sociales ; précarité (Wresinski), formes de pauvreté, aide alimentaire, pauvreté et obésité	4.3.4 ; 4.3.14 (précarité, pauvreté, aide alimentaire)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M2 S3 §1 (p. 20 et 21)	L'enfant : besoins affectifs, aptitudes motrices, sens, faim et satiété	4.3.9
M2 S3 §2 et §3 (p. 22 et 23)	L'adolescent ; l'adulte (identité, corps, émotions)	4.3.10
M2 S3 §4 (p. 24)	La personne âgée : évolutions physique, sociale, psychique ; syndrome de glissement	4.3.10 (la personne âgée) ; 4.3.11 (dénutrition)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Groupes d'aliments** (p. 8) : le fascicule parle de « 10 groupes et 32 sous-groupes » sans source. La table **Ciqual 2025** (ANSES) classe les aliments en **11 groupes** et plus de 60 sous-groupes ; pour l'éducation, on utilise les repères de Santé publique France (2019).
- **Part de l'alimentation dans les dépenses** (p. 10) : l'étude Insee de 2006 est dépassée. En **2025**, les produits alimentaires et boissons non alcoolisées représentent **12,5 %** de la dépense de consommation des ménages (Insee, 29 mai 2026).
- **Pulsion** (p. 13) : la dopamine et la sérotonine sont des **neurotransmetteurs**, pas des hormones.
- **Grande distribution** (p. 17) : le premier magasin en libre-service a ouvert en France en **1948**, et non en 1950 ; la loi Royer date de 1973 et la crise de la vache folle de 1996.
- **Définition de la précarité** (p. 18) : la citation exacte de Wresinski parle d'« obligations professionnelles, familiales et sociales », et non de « responsabilités élémentaires ».
- **Aide alimentaire** (p. 18) : le PEAD de 1987 a été remplacé par le **FEAD** (2014-2020) puis par le **FSE+** (2021-2027). Les diététiciens interviennent dans de nombreuses structures, pas seulement dans les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé.
- **Pauvreté et obésité** (p. 18 et 19) : présenter la nourriture comme une « récompense » propre aux « classes défavorisées » est stigmatisant. Le lien s'explique par les prix, l'offre, le temps, le stress et l'environnement : ce sont des **inégalités sociales de santé**.
- **Lait maternel** (p. 21) : son sucre est le **lactose** (glucose + galactose), pas le glucose seul. Les odeurs de l'alimentation de la mère passent dans le **liquide amniotique**, et non une « barrière plasmatique ».
- **Personne âgée** (p. 24) : l'âge de la retraite (« 62 ans ») n'est pas une définition et a changé depuis ; on retient 60 ou 65 ans selon les sources (OMS, Insee) et 70 ans pour la dénutrition (HAS, 2021).

4.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Repères alimentaires** : les repères en vigueur pour les adultes sont ceux de Santé publique France (2019), fondés sur l'actualisation de l'ANSES (2016) ; l'avis du HCSP de juin 2025 pour le PNNS 5 recommande un seuil maximal pour l'ensemble des viandes (volaille comprise) et des seuils plus bas pour la viande rouge et la charcuterie ; le PNNS 5 (avril 2026) annonce de nouvelles recommandations, pas encore publiées au 26 octobre 2026.
- **Aliments ultra-transformés** : l'ANSES (30 janvier 2025) constate qu'il n'existe pas de définition consensuelle et que les liens avec la santé reposent sur des preuves encore faibles ; le PNNS 5 poursuit l'expertise pour aboutir à une définition opérationnelle et vise à réduire leur consommation de 20 %.
- **Végétarisme et flexitarisme** : l'enquête Ifop pour FranceAgriMer (données 2020, publiée en 2021, 15 000 personnes) reste la plus large enquête publiée ; le CNA (avis n° 90, 2022) a analysé ces nouveaux comportements.

- **Troubles du comportement alimentaire** : les recommandations HAS en vigueur datent de 2010 (anorexie mentale) et de 2019 (boulimie et hyperphagie boulimique).

4.3.1 Les rôles de l'acte alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §1 (p. 8)

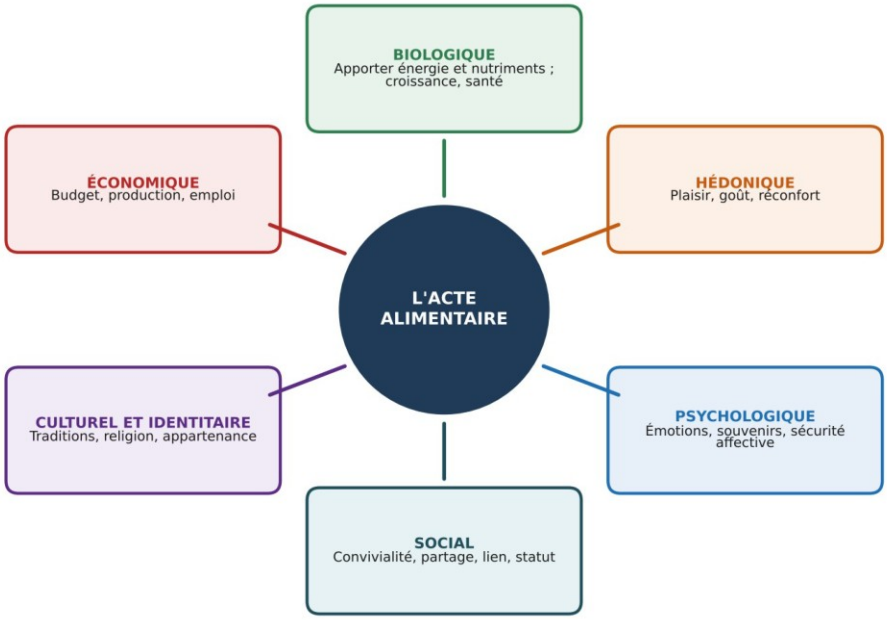


Figure 4.1 – Les rôles de l'acte alimentaire

Comprendre le schéma – Figure 4.1

1. Biologique : couvrir les besoins en énergie, en eau et en nutriments pour la croissance, l'entretien de l'organisme et la santé (BPADN).

2. Hédonique : procurer du **plaisir** par le goût, l'odeur, la texture ; le plaisir n'est pas un « bonus », il participe à la régulation et à l'adhésion aux conseils.

3. Psychologique : réconfort, sécurité affective, souvenirs (« madeleine de Proust »), gestion des émotions.

4. Social : le repas crée et entretient le **lien** (convivialité, partage, hospitalité), structure le temps familial, marque les événements.

5. Culturel et identitaire : l'alimentation exprime l'appartenance à un groupe (région, pays, religion, génération) ; le « repas gastronomique des Français » est inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO).

6. Économique : budget des ménages, production, emploi, commerce.

7. Conseil professionnel : un message qui ne tient compte que du rôle biologique (« mangez ceci, pas cela ») ignore les cinq autres et a peu de chances d'être suivi.

Repérer les rôles de l'acte alimentaire dans la parole d'un public

Les six rôles ne sont pas une liste à réciter : ils servent à **comprendre** ce que l'alimentation représente pour un public avant de proposer une action. Dans un entretien ou un groupe de parole, chaque phrase révèle souvent un ou deux rôles dominants. Le chapitre 3 (section 3.3.1) présente les regards disciplinaires sur le mangeur ; ici, on apprend à les utiliser pour construire une action.

Ce que l'on entend	Rôle dominant	Ce que cela change pour l'action
« Je mange ce qui me tient au corps jusqu'au soir. »	Biologique	Proposer des repas rassasiants (fibres, protéines), pas des « petites portions »
« Le samedi, c'est pizza devant un film, c'est notre plaisir. »	Hédonique et social	Garder le rituel, l'améliorer (pizza maison, salade) plutôt que l'interdire
« Quand je suis seule, je ne fais pas à manger pour moi. »	Social et psychologique	Travailler sur la convivialité (repas partagés) avant le contenu de l'assiette
« Chez nous, on reçoit avec beaucoup de plats, sinon c'est la honte. »	Culturel et identitaire	Respecter la générosité ; jouer sur la composition des plats, pas sur l'abondance
« Les fruits, c'est trop cher pour nous. »	Économique	Agir sur l'accès et sur des choix à petit prix (fruits de saison, surgelés, compotes)
« Quand je stresse, il me faut du chocolat. »	Psychologique	Ne pas culpabiliser ; travailler la gestion du stress et le plaisir conscient

Méthode pas à pas – Partir des rôles pour construire une action

1. Recueillir la parole du public (entretiens, groupe de parole, questionnaire avec questions ouvertes).

2. Classer chaque élément dans un ou deux rôles ; repérer le ou les rôles **dominants** pour ce public.

3. Repérer les tensions entre rôles : par exemple, le rôle économique (petit budget) peut s'opposer au rôle hédonique (envie de produits de marque pour les enfants).

4. Choisir des actions qui s'appuient sur les rôles dominants au lieu de les combattre : une action qui respecte le plaisir et la convivialité a plus de chances d'être suivie.

5. Vérifier que le rôle biologique reste couvert : l'objectif de santé n'est pas abandonné, il est atteint par un autre chemin.

Exemple – Un même aliment, plusieurs rôles : le gâteau d'anniversaire en crèche

Une crèche veut supprimer les gâteaux d'anniversaire apportés par les familles, jugés trop sucrés. Les rôles en jeu : **social** (fêter ensemble), **culturel** (gâteaux de familles d'origines différentes), **psychologique** (fierté de l'enfant et du parent), **hédonique** (plaisir), **économique** (achat pour le groupe) et **biologique** (sucres). La suppression ne tient compte que du dernier. Une solution respectueuse : garder la fête, une fois par mois pour tous les enfants nés ce mois-là, avec un gâteau maison préparé avec les enfants ou un gâteau apporté par une famille, servi au goûter en part adaptée, avec un fruit.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.1

Dans un foyer de jeunes mères, vous entendez : a) « Je prends des petits pots pour être sûre qu'il ne manque de rien. » b) « Ma grand-mère disait qu'un bébé bien nourri, c'est un bébé bien rond. » c) « Le soir, je mange un paquet de gâteaux quand il s'endort enfin. » d) « On fait un repas toutes ensemble le dimanche, c'est le meilleur moment. » Identifiez le rôle dominant de chaque phrase et indiquez ce qu'il change pour l'atelier que vous préparez.

Corrigé

a) Rôle **biologique** associé à l'anxiété de bien faire (psychologique) : rassurer sur la qualité des repas faits maison, montrer qu'ils couvrent les besoins, sans dévaloriser les petits pots. **b)** Rôle **culturel** (représentation transmise : le poids comme signe de bonne santé) : en parler avec respect et expliquer la régulation de l'enfant (partage des responsabilités, 4.3.9). **c)** Rôle **psychologique** (détente, récompense après une journée difficile) : ne pas juger ; aborder la fatigue et des moments de pause qui ne passent pas uniquement par la nourriture. **d)** Rôle **social** : c'est le levier principal ; l'atelier peut s'appuyer sur ce repas du dimanche pour

cuisiner ensemble.

4.3.2 Le comportement alimentaire : besoin, oralité, pulsion

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §4 (p. 13)

Définition – Comportement alimentaire

Ensemble des **conduites** d'un individu vis-à-vis de l'alimentation : choix des aliments, préparation, nombre et horaires des prises, quantités, lieux et conditions des repas, manière de manger. Il résulte de l'interaction de facteurs **physiologiques** (régulation de la faim et de la satiété), **psychologiques** (émotions, apprentissages, cognition) et **socioculturels** (normes, habitudes, environnement).

Notion	Définition	Exemple
Besoin	Nécessité physiologique d'apports en énergie, en eau et en nutriments ; il se traduit par la faim et la soif	Avoir faim à 12 h après un petit-déjeuner léger
Envie (appétit)	Désir de manger un aliment particulier, orienté par le plaisir, même sans faim	Envie de chocolat en passant devant une boulangerie
Oralité	Ensemble des fonctions de la bouche (succion, déglutition, mastication, goût, langage) ; l'oralité alimentaire se construit de la vie fœtale à l'enfance (tétée, cuillère, morceaux)	Passage aux morceaux vers 8-10 mois ; troubles de l'oralité chez certains enfants prématurés ou en situation de handicap
Pulsion	Poussée interne, peu contrôlée, vers la prise alimentaire, souvent liée à une tension émotionnelle	Manger rapidement de grandes quantités après une journée stressante

L'oralité alimentaire : un développement en plusieurs étapes

L'oralité alimentaire se construit très tôt. On distingue l'**oralité primaire**, réflexe, et l'**oralité secondaire**, volontaire.

Étape	Période	Ce qui se passe
Oralité fœtale	Grossesse	Le fœtus déglutit du liquide amniotique dès la fin du premier trimestre et en perçoit les arômes ; la succion apparaît ensuite
Oralité primaire	Naissance à 4-6 mois environ	Succion-déglutition réflexe, coordonnée avec la respiration ; tétée au sein ou au biberon
Passage à l'oralité secondaire	4 à 8 mois environ	Contrôle volontaire de la bouche ; prise à la cuillère, aliments lisses, puis épais
Mastication	À partir de 8-10 mois, s'affine jusqu'à 3-4 ans	Mouvements de la langue et de la mâchoire, petits morceaux fondants, puis aliments plus fermes

Un **trouble de l'oralité alimentaire** est une difficulté durable à accepter, à manipuler ou à avaler les aliments : haut-le-cœur, refus des morceaux, temps de repas très longs, sélectivité extrême. Il est plus fréquent chez les enfants nés prématurément, ceux qui ont été nourris par sonde ou qui ont des troubles du neurodéveloppement. Le diététicien de santé publique **repère** les signes et **oriente** vers le médecin, qui peut adresser à une équipe spécialisée (orthophoniste formé à l'oralité, psychomotricien).

Attention – Ne pas confondre

- La **néophobie** (refus de l'aliment nouveau, normal entre 2 et 6 ans) se règle avec le temps et l'exposition

répétée (chapitre 3, section 3.4.1).

- Le **trouble de l'oralité** porte sur la capacité à manger (texture, déglutition), pas seulement sur le goût ; il nécessite une prise en charge.
- Le trouble d'évitement et de restriction de l'apport alimentaire (**ARFID**, DSM-5, 2013) associe un évitement important à des conséquences sur la croissance, la nutrition ou la vie sociale (4.5).

Besoin, envie, plaisir : trois moteurs qui se complètent

Le besoin et l'envie ne s'opposent pas : chez une personne en bonne santé, le **plaisir** guide souvent vers ce dont le corps a besoin (envie de salé après un effort, de sucré quand l'énergie baisse). Le plaisir participe aussi à la **régulation** : on s'arrête de manger un plat quand il devient moins agréable (rassasiement sensoriel spécifique, 4.3.3). Le problème apparaît quand l'envie est déclenchée **en permanence** par l'environnement (publicité, disponibilité, portions), sans lien avec la faim, ou quand la **pulsion** sert à apaiser une tension.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.2

Une assistante maternelle vous décrit trois enfants : a) Lina, 9 mois, accepte les purées lisses mais vomit dès qu'il y a un petit grumeau, depuis trois mois. b) Sami, 3 ans, refuse toute nouveauté mais mange volontiers ses plats habituels, variés, et grandit bien. c) Eva, 2 ans, mange avec appétit, puis repousse son assiette au milieu du plat et réclame son yaourt. Pour chaque enfant, indiquez la notion en jeu et la conduite à tenir.

Corrigé

a) Possible **trouble de l'oralité** (réaction aux textures persistante) : en parler aux parents pour qu'ils consultent le médecin, sans forcer les morceaux. **b) Néophobie** normale à cet âge : continuer à proposer les nouveaux aliments sans pression, plusieurs fois, à côté de plats connus. **c) Rassasiement sensoriel spécifique** et écoute de sa faim : comportement normal ; on peut proposer le dessert prévu sans en faire une récompense ni exiger qu'elle finisse le plat.

Attention – Deux précisions de vocabulaire

- L'**oralité** désigne « l'ensemble des fonctions dévolues à la bouche » (Véronique Abadie, pédiatre) : téter, mastiquer, avaler, mais aussi crier, babiller et parler. L'oralité alimentaire et l'oralité verbale se développent ensemble ; un trouble de l'une retentit souvent sur l'autre.
- La **dopamine** (circuit de la récompense) et la **sérotonine** (humeur, satiété) sont des **neurotransmetteurs**, et non des hormones. Une pulsion alimentaire n'est pas un simple « manque de volonté » : elle répond souvent à un besoin de soulagement (ennui, solitude, tension).

4.3.3 La régulation et la dérégulation du comportement alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §3 (p. 12)

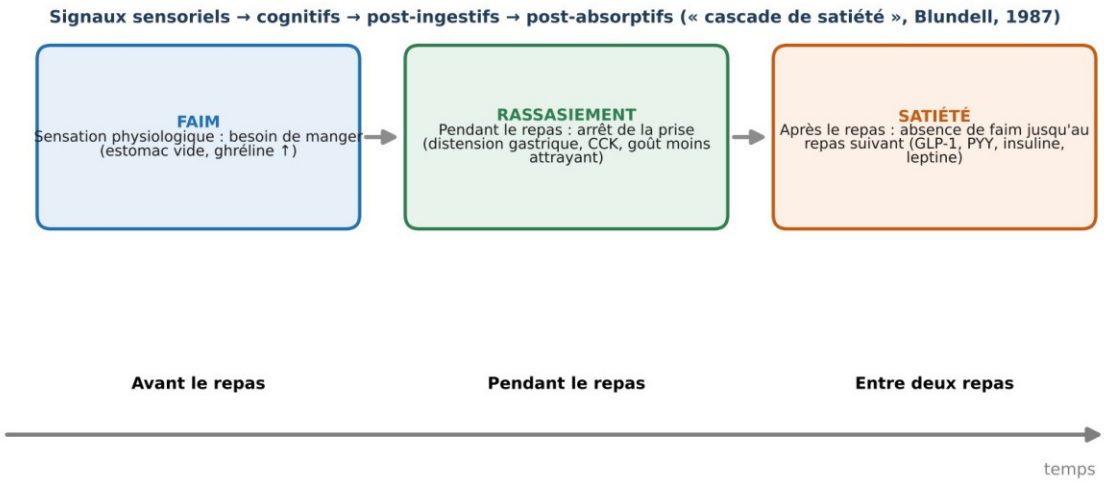


Figure 4.2 – Faim, rassasiement et satiété

Comprendre le schéma – Figure 4.2

1. Faim : sensation physiologique qui pousse à rechercher de la nourriture ; elle s'accompagne de signaux corporels (creux gastrique, baisse d'énergie) et de la sécrétion de **ghréline** par l'estomac.

2. Rassasiement : processus qui se développe **pendant** le repas et conduit à l'**arrêt** de la prise ; il dépend de la distension gastrique, d'hormones intestinales (cholécystokinine, CCK) et de la baisse du plaisir pour un aliment consommé (rassasiement sensoriel spécifique).

3. Satiété : état d'absence de faim **après** le repas, qui détermine le délai jusqu'au repas suivant ; elle dépend des hormones intestinales (GLP-1, PYY), de l'insuline et, à long terme, de la **leptine** sécrétée par le tissu adipeux.

4. Repères temporels : avant, pendant, entre deux repas. Le modèle de la « cascade de satiété » (Blundell, 1987) décrit la succession des signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs et post-absorptifs.

5. Lien diététique : manger **lentement**, des aliments riches en **fibres** et en **protéines**, sans distraction, favorise le rassasiement et la satiété ; les boissons sucrées rassasient peu.

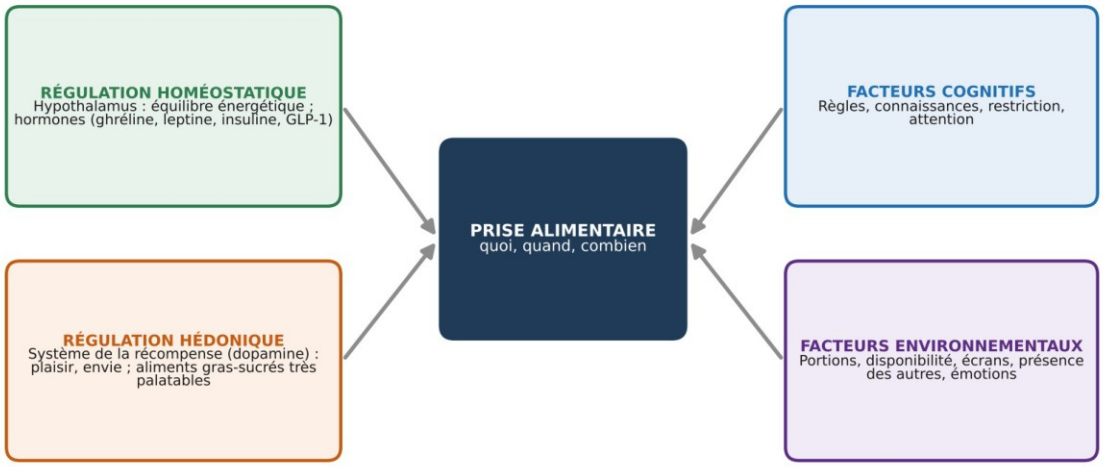


Figure 4.3 – Les systèmes de régulation de la prise alimentaire

Comprendre le schéma – Figure 4.3

1. Régulation homéostatique : l'hypothalamus intègre les signaux hormonaux et nerveux pour maintenir

l'équilibre énergétique (« manger pour vivre »).

2. Régulation hédonique : le système de la récompense (dopamine) pousse à manger pour le **plaisir** ; les aliments très gras et sucrés, très palatables, peuvent prendre le dessus sur les signaux de satiété.

3. Facteurs cognitifs : règles alimentaires, connaissances, attention portée au repas, restriction.

4. Facteurs environnementaux : taille des portions, disponibilité, écrans, présence d'autres personnes, émotions.

5. La prise alimentaire réelle (quoi, quand, combien) résulte de l'**équilibre** entre ces systèmes ; dans un environnement d'abondance, la régulation hédonique et environnementale l'emporte souvent sur les signaux internes.

La cascade de satiété et le pouvoir rassasiant des aliments

John Blundell (1987) a décrit la **cascade de satiété** : après le début d'un repas, plusieurs familles de signaux se succèdent et se superposent pour arrêter la prise puis retarder la suivante.

Signaux	Moment	Exemples	Ce que l'on peut en tirer en éducation
Sensoriels	Pendant le repas, dès les premières bouchées	Goût, odeur, texture ; baisse du plaisir pour l'aliment consommé	Manger lentement, varier les légumes, mastiquer
Cognitifs	Avant et pendant le repas	Ce que l'on croit de l'aliment (« c'est léger », « c'est copieux »), taille perçue de la portion	Un plat présenté comme « copieux » rassasie davantage ; l'attention au repas compte
Post-ingestifs	Dans les minutes qui suivent	Distension de l'estomac, hormones intestinales (CCK, GLP-1, PYY)	Volume, eau et fibres des aliments ; boissons sucrées peu rassasiantes
Post-absorptifs	Dans les heures qui suivent	Nutriments absorbés (glucose, acides aminés), insuline	Les protéines et les fibres prolongent la satiété

Exemple – L'indice de satiété de Holt et collaborateurs (1995)

Des adultes ont mangé des portions de **240 kcal** de 38 aliments, puis ont noté leur faim pendant deux heures. Le pain blanc servait de référence (indice 100). Quelques résultats : pomme de terre bouillie **323**, poisson **225**, porridge **209**, orange **202**, pomme **197**, croissant **47**. À énergie égale, la pomme de terre bouillie a rassasié près de sept fois plus que le croissant (323 / 47 = 6,9).

Leçon : les aliments riches en eau, en fibres ou en protéines, et pauvres en matières grasses, rassasient beaucoup pour peu de calories ; les aliments secs, gras et sucrés rassasient peu. Ces valeurs sont des ordres de grandeur obtenus sur un petit groupe d'adultes.

Définition – Densité énergétique

Quantité d'énergie apportée par 100 g d'un aliment ou d'un repas (kcal pour 100 g). Elle dépend surtout de la teneur en **eau** (qui n'apporte pas d'énergie) et en **lipides** (9 kcal par gramme). Les légumes, les fruits et les soupes ont une faible densité énergétique ; les biscuits, les chips et les produits frits une densité élevée. Les travaux de Barbara Rolls ont montré qu'à volume servi égal, on mange une **masse** d'aliments assez stable : baisser la densité énergétique d'un repas fait baisser l'énergie consommée sans augmenter la faim.

Calcul détaillé – Ce que représentent 100 kcal (Ciqual 2025)

Masse d'aliment qui apporte 100 kcal = 100 / énergie pour 100 g × 100.

- Chips (532 kcal pour 100 g) : 100 / 532 × 100 = **18,8 g** (une petite poignée).

- Biscuit sec (438 kcal) : **22,8 g** (trois à quatre biscuits).
- Pain blanc (287 kcal) : **34,8 g** (une tranche de baguette d'environ 7 cm).
- Pâtes cuites (167 kcal) : **59,9 g** (quelques cuillères).
- Pomme (54 kcal) : **185,2 g** (une grosse pomme).
- Soupe de légumes préemballée (36,8 kcal) : **271,7 g** (un grand bol).
- Carotte crue (30,2 kcal) : **331,1 g** (trois à quatre carottes).

Fibres apportées par ces 100 kcal : chips 18,8 × 4,7 / 100 = **0,88 g** ; carotte 331,1 × 2,9 / 100 = **9,6 g**, soit près de onze fois plus.

Usage en atelier : présenter côte à côte, sur des assiettes, les quantités qui apportent 100 kcal fait comprendre la densité énergétique sans aucun interdit.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.3

Un salarié hésite pour sa collation de 16 h entre un paquet de 30 g de chips (532 kcal pour 100 g), deux biscuits secs de 10 g (438 kcal pour 100 g) et une pomme de 180 g (54 kcal pour 100 g). a) Calculez l'énergie de chaque collation. b) Laquelle rassasiera probablement le plus ? Justifiez avec la cascade de satiété. c) Proposez une collation qui associe plaisir et satiété.

Corrigé

a) Chips : 30 × 532 / 100 = **159,6 kcal** ; biscuits : 20 × 438 / 100 = **87,6 kcal** ; pomme : 180 × 54 / 100 = **97,2 kcal**. **b)** La pomme : pour une énergie voisine de celle des biscuits, elle pèse neuf fois plus (180 g contre 20 g), de l'eau et des fibres ; elle se mâche longtemps (signaux sensoriels) et distend l'estomac (signaux post-ingestifs). Les chips, plus caloriques, rassasient peu. **c)** Par exemple une pomme et un carré de fromage ou une poignée d'amandes (protéines et plaisir), ou un yaourt nature avec un fruit.

Écouter ses sensations : l'échelle de la faim et de la satiété en atelier

L'**échelle de la faim et de la satiété** (fiche-outil O4.2) aide les participants à mettre des mots sur leurs sensations. Une version courante va de **0** (affamé, faible) à **10** (trop plein, inconfort) ; la zone de confort se situe entre 3 (faim nette) et 7 (rassasié, satisfait).

Méthode pas à pas – Animer une séance « faim et satiété »

1. **Introduire** sans parler de poids : « Nous allons apprendre à écouter notre corps pendant un repas. »
2. **Noter** sa faim sur l'échelle avant de commencer (par écrit, de façon individuelle).
3. **Manger lentement** une première moitié du repas, en posant ses couverts, en décrivant les goûts.
4. **Faire une pause** et noter à nouveau : où en suis-je ? ai-je encore faim ou est-ce le plaisir qui me pousse ?
5. **Finir ou s'arrêter** selon la sensation, sans obligation de finir ; noter à la fin.
6. **Échanger** en groupe sur ce que chacun a remarqué, sans juger ce qui a été mangé.

Calcul détaillé – Résultats d'une séance dans un centre social (données fictives)

Douze participants notent leur faim avant le repas, à mi-repas et à la fin. Moyennes : avant **2,5** ; à mi-repas **5,5** ; à la fin **7,0**. Sept participants sur douze ont laissé une partie de leur assiette parce qu'ils étaient « bien », soit 7 / 12 × 100 = **58,3 %**. Avant la séance, au questionnaire d'accueil, 9 sur 12 (**75,0 %**) déclaraient « toujours finir leur assiette ».

- Progression entre l'avant et la fin : 7,0 − 2,5 = **4,5 points**, dont 5,5 − 2,5 = **3,0 points** dès la première moitié du repas, soit 3,0 / 4,5 × 100 = **66,7 %** de la progression.

Lecture : les deux tiers du rassasiement ressenti sont atteints à mi-repas ; la pause permet à plusieurs participants de s'arrêter sans frustration. Ce sont des résultats d'un seul groupe, sans comparaison : ils montrent une prise de conscience, pas un changement durable.

Attention – Un outil d'écoute, pas un outil de contrôle

L'échelle ne doit pas devenir une nouvelle règle (« je n'ai pas le droit de dépasser 6 ») : ce serait une autre forme de restriction cognitive. Elle est déconseillée en groupe avec des personnes qui présentent des signes de TCA, pour qui le travail sur les sensations relève d'un accompagnement individuel spécialisé.

Sommeil, écrans et distraction : trois influences sur la régulation

La régulation de la prise alimentaire (faim, rassasiement, satiété) ne dépend pas seulement de ce que l'on mange. Le **sommeil** et l'**attention** portée au repas modifient aussi les signaux de faim et la quantité consommée.

Influence	Ce que montrent les études	Conséquence pour l'éducation
Manque de sommeil	Chez de jeunes hommes en bonne santé, deux nuits de 4 heures, comparées à deux nuits de 10 heures, ont fait baisser la leptine d'environ 18 %, augmenter la ghréline d'environ 28 % et la faim d'environ 24 %, avec une envie accrue d'aliments riches en glucides (Spiegel et collaborateurs, 2004)	Parler du sommeil dans une action sur l'alimentation, surtout chez les adolescents et les travailleurs de nuit
Repas devant un écran	Une méta-analyse (Robinson et collaborateurs, 2013) montre que manger en étant distrait augmente un peu la quantité mangée pendant le repas, et davantage celle mangée **plus tard** ; à l'inverse, se souvenir de son repas diminue la prise suivante	Encourager le repas sans écran, non comme une règle, mais comme un moyen de mieux sentir sa faim et son plaisir
Repas rapide	Manger vite laisse moins de temps aux signaux de rassasiement (4.3.3)	Prévoir un temps de repas suffisant (au moins 20 à 30 minutes assis en restauration scolaire)

À retenir – Les durées de sommeil recommandées

La National Sleep Foundation (Hirshkowitz et collaborateurs, 2015) recommande **9 à 11 heures** de sommeil de 6 à 13 ans, **8 à 10 heures** de 14 à 17 ans et **7 à 9 heures** de 18 à 64 ans. Chez l'adolescent, l'endormissement se décale naturellement plus tard le soir, alors que les horaires scolaires restent fixes : le manque de sommeil en semaine est fréquent.

Calcul détaillé – La dette de sommeil d'un lycéen (données fictives)

Un lycéen de 16 ans s'endort vers 0 h 20 en semaine et se lève à 6 h 30.

- Durée de sommeil : de 0 h 20 à 6 h 30 = **6 h 10** par nuit.
- Écart avec la recommandation (8 à 10 heures) : 8 h − 6 h 10 = **1 h 50** au minimum, et jusqu'à 10 h − 6 h 10 = **3 h 50**.
- Sur cinq nuits de semaine : 1 h 50 × 5 = 9 h 10, soit **plus de 9 heures** de sommeil en moins au minimum, l'équivalent d'une nuit complète.

Interprétation : ce lycéen risque d'avoir plus faim, surtout d'aliments sucrés et gras, et moins faim le matin ; il saute souvent le petit-déjeuner (4.3.8). Une action sur les rythmes alimentaires des lycéens gagne à aborder aussi le sommeil et les écrans le soir, sans culpabiliser.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.4

Une mère explique : « Mon fils de 11 ans mange son goûter devant sa console, puis il réclame encore à manger avant le dîner et il n'a plus faim à table. » a) Quelles notions du chapitre expliquent cette situation ? b) Proposez trois conseils à la famille. c) Formulez un conseil sans interdiction.

Corrigé

a) La **distraction** pendant le goûter empêche de percevoir le rassasiement et fait manger plus ensuite (Robinson et collaborateurs, 2013) ; le goûter est devenu un **grignotage** prolongé, sans heure fixe ; l'enfant arrive au dîner sans faim, ce qui perturbe le **rythme** des prises (4.3.8). **b)** Un goûter à heure fixe, assis à table, composé par exemple de pain, d'un produit laitier et d'un fruit ; la console seulement après le goûter ; un dîner à heure régulière, sans écran, avec des plats qu'il aime. **c)** « Et si on prenait le goûter ensemble dans la cuisine avant la console ? Tu profiteras mieux de ton jeu ensuite, et tu auras faim pour le dîner. »

Les dérégulations

Définition – Restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975)

Intention de **contrôler** son alimentation par des règles mentales (interdits, calculs, horaires imposés) plutôt que par les **sensations** de faim et de satiété, dans le but de maigrir ou de ne pas grossir. Elle fragilise la régulation : la personne perd ses repères internes, alterne contrôle et « craquages » (effet de **désinhibition**) et s'expose à une prise de poids à long terme.

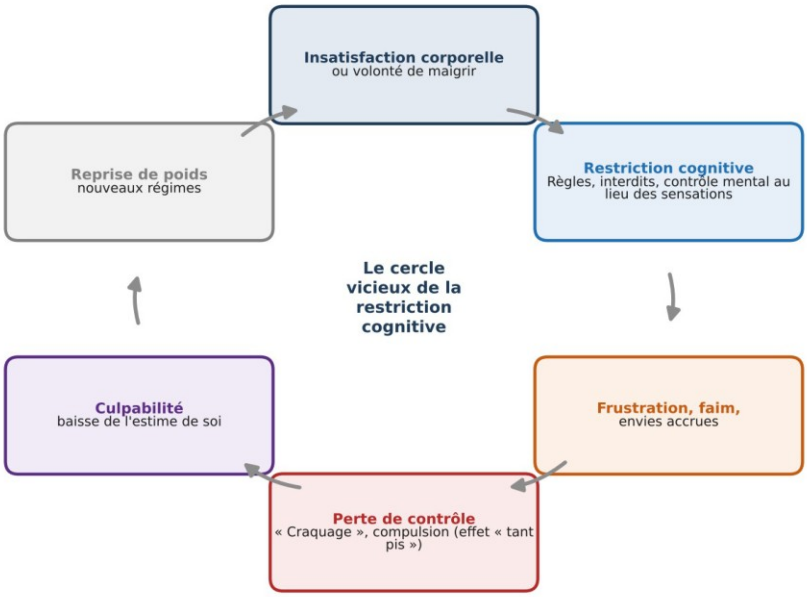


Figure 4.4 – Le cercle vicieux de la restriction cognitive

Comprendre le schéma – Figure 4.4

1. Le point de départ est souvent l'**insatisfaction corporelle** ou une volonté de maigrir (normes de minceur, conseils d'entourage, réseaux sociaux).
2. La **restriction cognitive** remplace les sensations par des règles (« pas de pain le soir », « pas plus de 1 200 kcal »).
3. Elle génère **frustration**, faim et envies accrues pour les aliments interdits.
4. Survient une **perte de contrôle** (« craquage », effet « tant pis, j'ai craqué, autant tout manger »).

5. Elle entraîne **culpabilité** et baisse de l'estime de soi.
6. Puis une **reprise de poids** et de nouveaux régimes, qui relancent le cycle (« effet yo-yo »).
7. Prévention : ne pas prescrire de régimes restrictifs non justifiés, réhabiliter les sensations alimentaires et le plaisir, ne pas classer les aliments en « interdits » (prévention quaternaire, chapitre 1).

Dérégulation	Description
Alimentation émotionnelle	Manger en réponse à des émotions (stress, tristesse, ennui, joie) plutôt qu'à la faim
Externalité (Schachter, 1968)	Manger en réponse à des signaux extérieurs (vue, odeur, heure, portion servie) plutôt qu'aux signaux internes
Grignotage	Prises répétées, hors repas, de petites quantités, sans faim, souvent automatiques
Compulsion	Envie irrésistible de manger un aliment, suivie d'une prise rapide, souvent associée à la culpabilité
Troubles du comportement alimentaire (TCA)	Troubles psychiatriques définis par des critères diagnostiques (DSM-5) : anorexie mentale (restriction, peur de grossir, poids bas), boulimie (crises suivies de comportements compensatoires), hyperphagie boulimique (crises sans compensation), ARFID (restriction ou évitement sans préoccupation pour le poids)

Attention – Le rôle du diététicien face aux TCA en santé publique

En action collective, le diététicien ne **diagnostique** pas et ne prend pas en charge un TCA. Il **prévient** (messages non stigmatisants, pas de régimes, valorisation des sensations et du plaisir), **repère** des signes d'alerte et **oriente** (médecin, structures spécialisées, lignes d'écoute). La prise en charge est pluridisciplinaire (médecin, psychiatre ou psychologue, diététicien formé) et relève du soin (BC1). La HAS a publié des recommandations sur l'anorexie mentale (2010) et sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique (2019).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.5

Identifiez le phénomène décrit : a) « Je mange toujours tout ce qu'on me sert, même si je n'ai plus faim. » b) « Quand je suis stressée par le travail, je finis le paquet de biscuits. » c) « Je ne mange jamais de pain ni de pâtes, puis le week-end je craque sur tout. » d) « Au bout de quelques cuillères, le gâteau m'a semblé moins bon et j'ai eu envie de fromage. »

Corrigé

a) Externalité (réponse à la portion servie, signal extérieur) et faible écoute du **rassasiement**. **b) Alimentation émotionnelle** (réponse au stress). **c) Restriction cognitive** suivie de **désinhibition** (cercle vicieux). **d) Rassasiement sensoriel spécifique** : le plaisir diminue pour l'aliment consommé, mais reste intact pour un autre aliment ; c'est un mécanisme normal qui favorise la variété (et qui explique qu'on ait « encore de la place pour le dessert »).

Trois styles alimentaires : restreint, émotionnel, externe

Le questionnaire néerlandais du comportement alimentaire (*Dutch Eating Behaviour Questionnaire*, **DEBQ**, van Strien et collaborateurs, 1986) mesure trois styles alimentaires issus de trois théories. Il est utilisé en recherche et en soin ; il ne sert pas à « classer » les participants d'un atelier, mais il aide à comprendre les mécanismes.

Style	Théorie d'origine	Ce qui déclenche la prise	Piste éducative
Restreint	Restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975)	Les règles, puis leur rupture (désinhibition)	Réhabiliter les sensations et le plaisir, sortir des interdits
Émotionnel	Théorie psychosomatique (Hilde Bruch, années 1960-1970) : confusion entre faim et émotions apprise tôt	Les émotions négatives (stress, tristesse, colère, ennui), parfois positives	Reconnaître ses émotions, trouver d'autres réponses (CPS, chapitre 3, section 3.3.5)
Externe	Théorie de l'externalité (Schachter, 1968)	Les signaux extérieurs : vue, odeur, heure, portion, publicité	Aménager l'environnement : portions, rangement, écrans, courses

Exemple – L'expérience de l'horloge truquée (Schachter et Gross, 1968)

Des étudiants restent dans une pièce avec une horloge qui avance ou retarde. Quand l'horloge indique faussement l'heure du dîner, les étudiants en surpoids mangent davantage de biscuits mis à disposition que lorsqu'elle indique une heure plus précoce ; les étudiants de poids normal sont moins influencés. Cette expérience a fondé la notion d'**externalité**. Les travaux ultérieurs ont montré que la sensibilité aux signaux externes existe à tous les poids : c'est un mécanisme général, renforcé par un environnement d'abondance.

Attention – Le débat sur l'« addiction alimentaire »

Certains aliments très gras et très sucrés activent fortement le système de la récompense, et certaines personnes décrivent une perte de contrôle proche d'une dépendance. Une échelle de recherche a été construite (*Yale Food Addiction Scale*, Gearhardt et collaborateurs, 2009). Mais l'« addiction alimentaire » n'est **pas** un diagnostic reconnu par le DSM-5 et son existence fait débat. En santé publique, on évite de présenter un aliment comme une « drogue » : cela renforce la peur, la culpabilité et les interdits, donc la restriction.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.6

Pour chaque situation, indiquez le style alimentaire dominant et une piste d'action : a) « Je ne mange jamais de pâtes le soir, mais le week-end, je me rattrape. » b) « Dès que je passe devant la boulangerie, j'achète un croissant. » c) « Les soirs de dispute, je vide le placard. » d) « Au cinéma, je prends le grand pot de pop-corn parce qu'il est en promotion. »

Corrigé

a) Restreint (règle puis désinhibition) : réintroduire les pâtes le soir en quantité adaptée, sans interdit. **b) Externe** (signal visuel) : changer d'itinéraire ou prévoir une collation à emporter si c'est la faim ; sinon, accepter le croissant de temps en temps, sans culpabilité. **c) Émotionnel** : reconnaître l'émotion, chercher une autre réponse (sortir marcher, appeler quelqu'un), en parler si cela devient fréquent. **d) Externe** (taille de portion et prix) : choisir le petit pot, ou partager le grand ; c'est aussi un argument pour réglementer les promotions sur les grandes portions.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.1 à 4.3.3 – Rôles, comportement, régulation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six rôles de l'acte alimentaire.
2. Distinguez besoin et envie.
3. Placez dans le temps la faim, le rassasiement et la satiété, avec une hormone pour chacun.
4. Qu'est-ce que le rassasiement sensoriel spécifique ?

5. Définissez la restriction cognitive en citant les auteurs.

6. Pourquoi une pomme de terre bouillie rassasie-t-elle plus qu'un croissant à énergie égale ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.1 à 4.3.3

1. Biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique.

2. Le besoin est une nécessité physiologique qui se traduit par la faim et la soif ; l'envie est le désir d'un aliment particulier, orienté par le plaisir, même sans faim.

3. Faim avant le repas (ghréline) ; rassasiement pendant le repas (CCK, distension gastrique) ; satiété après le repas (GLP-1, PYY, insuline ; leptine à long terme).

4. La baisse du plaisir pour un aliment que l'on mange, alors que le plaisir reste intact pour un autre aliment.

5. Herman et Polivy (1975) : intention de contrôler son alimentation par des règles mentales plutôt que par les sensations, pour maigrir ou ne pas grossir.

6. Elle contient beaucoup d'eau et d'amidon et peu de lipides : sa densité énergétique est faible, son volume grand ; indice de satiété 323 contre 47 (Holt et collaborateurs, 1995).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.4 Les déterminants du comportement alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §2 (p. 9 à 11) ; Synthèse M2 S2 §1 à §3 (p. 14 à 16) ; Synthèse M2 S2 §4 (p. 16 et 17) ; Synthèse M2 S2 §5 et §6 (p. 18 et 19)

Déterminant	Exemples	Levier éducatif
Biologiques et sensoriels	Préférence innée pour le sucré et le salé, aversion initiale pour l'amer ; âge ; génétique (sensibilité à l'amertume) ; état de santé ; médicaments	Exposition répétée, éducation sensorielle, adaptation des textures
Psychologiques	Émotions, stress, apprentissages (conditionnement : aliment associé à une maladie ou à une fête), représentations, image du corps	Gestion des émotions, CPS, déculpabilisation
Cognitifs	Connaissances, croyances, règles, attention, littératie	Information adaptée, pensée critique
Sociaux et culturels	Famille, pairs, normes, religion, culture d'origine, genre	Implication de la famille, valorisation des cultures
Économiques	Revenus, prix, budget alimentaire	Recettes à petit prix, accès aux aides
Environnementaux	Offre disponible, taille des portions, marketing, écrans, temps disponible, équipement	Nudges, aménagement de l'environnement, recettes rapides

Définition – Environnement obésogène

Environnement qui favorise la consommation excessive d'énergie et la sédentarité : grande disponibilité d'aliments très palatables et bon marché, portions de grande taille, marketing omniprésent, déplacements motorisés, écrans. Dans cet environnement, maintenir un poids stable demande un effort constant : c'est un

argument pour agir sur l'environnement et non sur la seule responsabilité individuelle.

Exemple – L'effet de la taille des portions

De nombreuses expériences montrent que plus la portion servie (ou le contenant) est grande, plus on mange, sans augmentation proportionnelle de la sensation de satiété. En restauration collective et en atelier, servir des portions adaptées, utiliser des assiettes de taille raisonnable et permettre de se resservir à la demande respecte mieux la régulation que l'obligation de finir l'assiette.

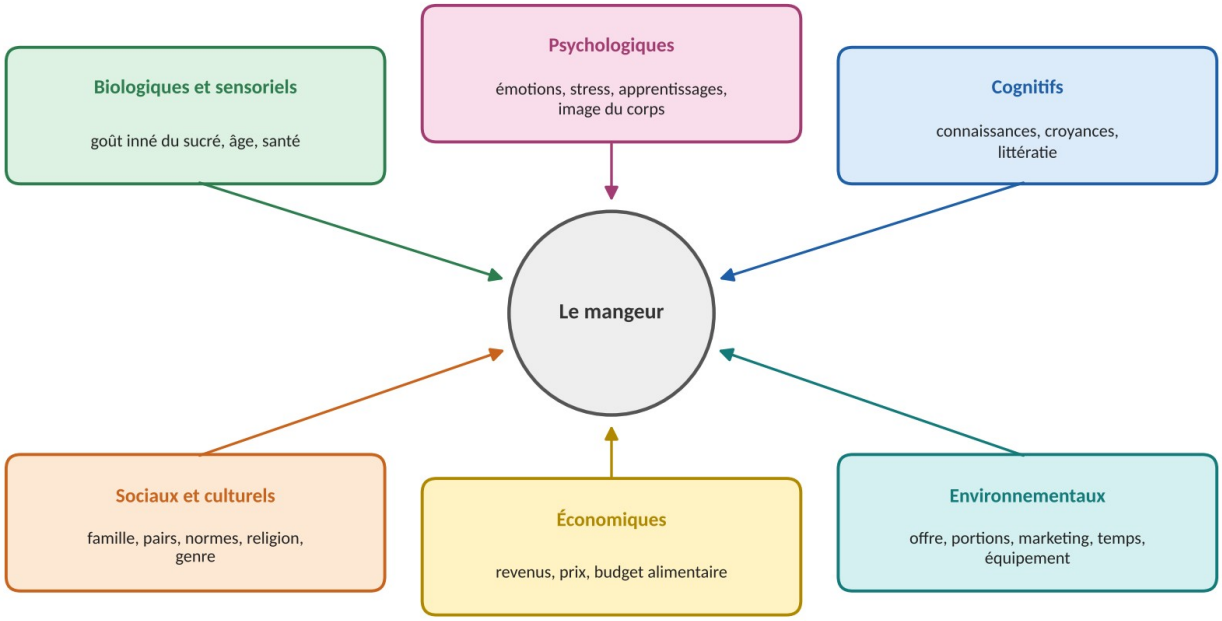


Figure 4.4 bis – Les six familles de déterminants du comportement alimentaire

Comprendre le schéma – Figure 4.4 bis

1. Au centre, **le mangeur** : ses choix résultent de six familles de déterminants qui agissent en même temps.
2. En haut, les déterminants **individuels** : biologiques et sensoriels (goût inné du sucré, âge, santé), psychologiques (émotions, stress, apprentissages, image du corps), cognitifs (connaissances, croyances, littératie).
3. En bas, les déterminants **collectifs** : sociaux et culturels (famille, pairs, normes, religion, genre), économiques (revenus, prix, budget alimentaire), environnementaux (offre, portions, marketing, temps, équipement).
4. Une action qui ne vise que les connaissances (cognitifs) agit sur une seule des six familles : c'est pourquoi l'information seule change peu les comportements.

Du mangeur à son environnement : le modèle socio-écologique

Mary Story et ses collaborateurs (2008) ont proposé un **modèle socio-écologique** des choix alimentaires, qui range les déterminants en quatre niveaux emboîtés. Il prolonge, pour l'alimentation, le modèle des déterminants de la santé de Dahlgren et Whitehead (chapitre 2, section 2.3.1).

Niveau	Exemples de déterminants	Exemples d'actions
Individuel	Goûts, connaissances, compétences culinaires, motivation, revenus, temps	Ateliers culinaires, éducation sensorielle, développement des CPS
Environnement social	Famille, amis, collègues, normes du groupe, modèles	Repas partagés, implication des familles, pair-éducation

Niveau	Exemples de déterminants	Exemples d'actions
Environnement physique	Offre à la maison, à l'école, au travail, dans le quartier ; prix ; portions	Menus de la restauration collective, fontaines à eau, aménagement des selfs, épiceries solidaires
Macro-environnement	Normes culturelles, marketing, politiques agricoles et alimentaires, réglementation	Encadrement de la publicité pour les enfants, loi EGalim, Nutri-Score, taxes sur les boissons sucrées

Lien diététique – Agir à plusieurs niveaux à la fois

Les actions les plus efficaces combinent plusieurs niveaux : un atelier culinaire (individuel) a plus d'effet si les participants repartent avec un panier de légumes à petit prix (environnement physique) et si leurs proches sont invités à la dégustation (environnement social). Les déterminants commerciaux (marketing, prix, formulation des produits) sont présentés au chapitre 2 ; les leviers psychosociaux (normes, engagement, nudges) au chapitre 3.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.7

Classez dans les quatre niveaux du modèle socio-écologique les éléments suivants, relevés pour des collégiens : a) le distributeur de boissons de la piscine municipale ; b) l'envie d'imiter un influenceur sportif ; c) le goût pour les frites ; d) la publicité pour des céréales pendant un dessin animé ; e) les amis qui vont à la boulangerie à la sortie ; f) le menu végétarien hebdomadaire de la cantine. Proposez une action pour le niveau le moins pris en compte par les projets scolaires habituels.

Corrigé

Individuel : c) le goût pour les frites ; b) l'envie d'imiter un influenceur (motivation individuelle, influencée par le macro-environnement des réseaux sociaux). **Environnement social** : e) les amis. **Environnement physique** : a) le distributeur ; f) le menu de la cantine. **Macro-environnement** : d) la publicité, et le cadre des réseaux sociaux. Le niveau le moins travaillé est souvent l'environnement physique hors de l'école : on peut proposer à la mairie d'installer une fontaine à eau et de remplacer une partie des produits du distributeur de la piscine par des fruits secs, des compotes et de l'eau.

Le temps, l'équipement et les compétences : des déterminants souvent oubliés

Les messages nutritionnels supposent souvent que chacun dispose d'une cuisine équipée, de temps et de savoir-faire. Ce n'est pas le cas de nombreux publics : personnes hébergées à l'hôtel social ou chez un tiers, étudiants en studio avec une seule plaque, travailleurs aux horaires morcelés, personnes âgées qui ne peuvent plus se tenir debout longtemps. Ces contraintes relèvent des déterminants **environnementaux** (équipement, temps) et **cognitifs** (compétences culinaires).

Contrainte	Conséquence fréquente	Adaptation d'un conseil
Pas de four, une seule plaque	Plats en une casserole, peu de légumes cuisinés	Recettes « une casserole » ou sans cuisson : pâtes et légumes cuits ensemble, salades composées, légumineuses en conserve
Pas de réfrigérateur ou très petit	Achats au jour le jour, produits secs ou en conserve	Conserves de légumes et de poisson, fruits qui se gardent (pommes, bananes), lait UHT
Peu de temps après le travail	Plats préparés, livraisons	Cuisine en avance le week-end, congélation en portions, recettes de moins de 20 minutes

Contrainte	Conséquence fréquente	Adaptation d'un conseil
Compétences culinaires limitées	Répertoire de quelques plats	Ateliers progressifs, recettes illustrées en images, gestes de base (éplucher, cuire un légume, faire une sauce)

Calcul détaillé – Le temps de la cuisine dans une semaine (données fictives)

Une mère seule qui travaille de 8 h à 17 h 30 dispose, d'après son agenda, de 45 minutes par soir en semaine et de 2 heures le dimanche pour la cuisine.

- Temps disponible par semaine : 5 × 45 + 120 = 225 + 120 = **345 minutes**, soit 345 / 60 = **5 h 45**.
- Si elle prépare le dimanche, en 2 heures, une grande soupe et un plat de légumineuses pour 3 soirs, il lui reste 3 soirs × 45 min = 135 minutes en semaine pour des plats rapides, et deux soirs libres.
- Si chaque dîner « tout maison » demande 60 minutes, il lui faudrait 5 × 60 = **300 minutes** en semaine, alors qu'elle n'en a que 225 : l'objectif est **irréaliste** de 75 minutes.

Lecture : un conseil réaliste s'appuie sur l'organisation (cuisine en avance, portions congelées) plutôt que sur l'injonction à « tout faire maison ».

De la société traditionnelle au mangeur hypermoderne

	Société traditionnelle (avant l'industrialisation)	Société hypermoderne
Priorité	Le groupe : on reproduit ce que faisaient les parents	L'individu : on choisit, et on est responsable de ses choix
Temps	Rythmé par les saisons, les cloches, l'école, l'usine	Contrôlé par chacun, vécu dans l'urgence
Alimentation	Locale, de saison, choix limité ; le surplus est réservé aux fêtes ; l'enfant mange le menu de la famille	Offre abondante toute l'année ; plats préparés, restauration rapide, repas devant les écrans ; produits spécifiques pour chaque âge
Rôle de l'État	Assurer l'approvisionnement et aider les démunis	L'alimentation devient un enjeu de **santé publique** (PNNS)

Le sociologue François Ascher (*Le Mangeur hypermoderne*, 2005) décrit ce mangeur qui doit sans cesse choisir, avec des règles moins fortes : c'est la **gastro-anomie** de Claude Fischler.

- Un **mythe** est un ensemble de croyances et de représentations idéalisées (« la soupe fait grandir », « les carottes rendent aimable », le « bon vieux temps » des plats mijotés). La publicité utilise souvent ces mythes d'authenticité.
- Un **rite** est une manière d'agir propre à un groupe, qui suit une règle et se répète : l'apéritif ouvre le repas, le café prépare la séparation ; le beurre salé en Bretagne ou l'huile d'olive en Provence sont aussi des rites régionaux. Avant d'écarter un aliment, le diététicien tient compte de l'attachement de la personne à ses rites.

L'industrie, la distribution et les médias

- L'**industrie agroalimentaire** réunit la transformation des matières premières agricoles ; avec la production et la distribution, elle forme une filière majeure de l'emploi et des exportations françaises. Elle conçoit des produits très attirants sur le plan sensoriel, qui favorisent l'achat d'impulsion.
- **Repères de la grande distribution** : premier magasin en libre-service en France en 1948 ; premier hypermarché en 1963 ; loi Royer de 1973 pour encadrer l'ouverture des grandes surfaces ; crise de la « vache folle » en 1996, qui renforce l'intérêt pour l'origine, le bio et les labels.
- Les **médias** et la **publicité** poussent à l'achat : répétition, arguments pseudo-scientifiques, ciblage (notamment des enfants), association du produit à des émotions ou à un statut social. Les émissions culinaires donnent aussi envie de cuisiner.

Genre et catégorie sociale

- **Genre** : selon l'étude INCA 3 (ANSES, 2017), les hommes consomment davantage de viande, de charcuterie et de boissons alcoolisées ; les femmes davantage de fruits, de légumes et de produits laitiers frais, et elles déclarent plus souvent suivre un régime. Les hommes vivant seuls mangent moins de fruits et légumes et plus de produits prêts à consommer.
- **Catégorie sociale** : l'Insee classe les personnes selon la nomenclature des **professions et catégories socioprofessionnelles** (PCS 2020), en six groupes : agriculteurs exploitants ; artisans, commerçants et chefs d'entreprise ; cadres et professions intellectuelles supérieures ; professions intermédiaires ; employés ; ouvriers. Le milieu social influence le budget, les lieux d'achat, le temps consacré aux courses et à la cuisine, et les goûts (Bourdieu, chapitre 3).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.4 – Les déterminants

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six familles de déterminants du comportement alimentaire.
2. Définissez l'environnement obésogène.
3. Citez les quatre niveaux du modèle socio-écologique de Story et collaborateurs (2008).
4. Classez « la publicité pour des céréales pendant un dessin animé » dans ce modèle.
5. Pourquoi l'information seule change-t-elle peu les comportements ?
6. Donnez un exemple de déterminant environnemental souvent oublié par les messages nutritionnels.

Corrigé – Point d'étape 4.3.4

1. Biologiques et sensoriels, psychologiques, cognitifs, sociaux et culturels, économiques, environnementaux.
2. Un environnement qui favorise la consommation excessive d'énergie et la sédentarité (offre abondante d'aliments palatables et bon marché, grandes portions, marketing, écrans, déplacements motorisés).
3. Individuel, environnement social, environnement physique, macro-environnement.
4. Macro-environnement (marketing et réglementation).
5. Elle n'agit que sur une famille de déterminants (cognitifs), alors que les choix dépendent aussi du prix, de l'offre, des normes, des émotions et des goûts.
6. Le temps disponible, l'équipement de cuisine (une seule plaque, pas de four), ou l'absence de réfrigérateur.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.5 L'évolution des pratiques alimentaires et le syncrétisme culinaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S2 §1 à §3 (p. 14 à 16)

Le modèle alimentaire français et ses transformations

Le modèle français se caractérise traditionnellement par **trois repas** à heures régulières, pris **à table**, en **commun**, structurés (entrée, plat, fromage ou dessert), avec un temps consacré au repas parmi les plus longs d'Europe (plus de 2 heures par jour en moyenne selon l'enquête Emploi du temps de l'Insee, 2010). Ce modèle reste vivace, mais il se transforme :

- **Baisse de la part de l'alimentation** dans le budget : de 35 % de la consommation des ménages en 1960 à 20 % en 2014 (alimentation, boissons et restauration ; Insee Première n° 1568, 2015). En 2025, les seuls produits alimentaires et boissons non alcoolisées représentent **12,5 %** de la dépense de consommation des ménages (Insee, comptes nationaux, 29 mai 2026).
- **Hausse des produits transformés et des plats préparés**, recul de certains produits bruts (pain, pommes de terre, sucre en morceaux), hausse des produits laitiers frais, des boissons sucrées puis de l'eau en bouteille.
- **Développement de la restauration hors foyer** (restauration collective, restauration rapide, livraison de repas à domicile par plateformes).
- **Individualisation** des prises (repas devant les écrans, horaires décalés, repas pris seul), **snacking** et grignotage, sans disparition du repas familial, qui reste valorisé.
- **Nouvelles attentes** : santé, naturalité (« sans additifs »), origine, bien-être animal, environnement, prix ; défiance envers l'industrie ; recherche de praticité.
- **Inégalités** : ces évolutions touchent différemment les groupes sociaux ; l'inflation alimentaire de 2022-2023 a accentué les arbitrages des ménages modestes.

Le Conseil national de l'alimentation (avis n° 90, 2022) a analysé ces « nouveaux comportements alimentaires » et proposé des actions pour les rendre compatibles avec des systèmes alimentaires durables.

Définition – Syncrétisme culinaire

Combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments issus de **cultures culinaires différentes** : techniques, ingrédients, manières de manger. Il résulte de la mondialisation, des migrations et des échanges (pizza, couscous, sushis, burgers « revisités », cuisine fusion) et de l'acculturation (chapitre 3). Il montre que les cultures alimentaires sont **vivantes** et **en mouvement**.

Lien diététique – Utiliser le syncrétisme en atelier

Proposer des recettes « métissées » (tajine de légumes de saison, dahl aux lentilles vertes du Puy, galettes de sarrasin garnies de légumes rôtis aux épices) permet de valoriser les cultures des participants tout en introduisant des produits locaux et de saison.

Où trouver des données datées sur les pratiques alimentaires

Le guide du BTS demande de décrire les évolutions à partir de **données datées et sourcées**. Le tableau suivant présente les principales sources françaises ; les études nationales elles-mêmes sont présentées au chapitre 17.

Source	Producteur	Ce qu'elle permet de décrire
Enquête Emploi du temps (édition 2010 ; vérifiez la publication d'une édition plus récente)	Insee	Le temps passé à manger et à cuisiner, les horaires, les repas à domicile ou à l'extérieur ; en 2010, 2 h 22 par jour consacrées aux repas (Insee Première n° 1417, 2012)
Enquête Budget de famille ; comptes nationaux	Insee	La part de l'alimentation dans les dépenses des ménages selon le revenu, l'âge, le type de ménage
Étude INCA 3 (2014-2015, publiée en 2017)	ANSES	Les consommations alimentaires et les apports nutritionnels des enfants et des adultes, les lieux et les rythmes des prises
Étude Esteban (2014-2016)	Santé publique France	Les consommations rapportées aux repères, l'état nutritionnel (avec examens)
Enquête sur les comportements et consommations alimentaires en France (CCAF)	Crédoc	Les attitudes, les représentations, les pratiques de consommation et leur évolution

Source	Producteur	Ce qu'elle permet de décrire
Avis n° 90 « Nouveaux comportements alimentaires » (2022)	Conseil national de l'alimentation (CNA)	Une synthèse des évolutions (individualisation, numérique, hors foyer, attentes de durabilité)
Panels de consommateurs	Sociétés d'études privées	Les achats réels des ménages (quantités, prix, lieux d'achat) ; données souvent payantes

Méthode pas à pas – Citer une donnée sur les pratiques alimentaires

1. Le chiffre avec son unité et la population concernée (« 24 % des 15-70 ans »).

2. L'année du recueil des données, qui n'est pas toujours celle de la publication (INCA 3 : recueil 2014-2015, publication 2017).

3. Le producteur et le nom de l'étude (Ifop pour FranceAgriMer, ANSES, Insee).

4. La méthode en quelques mots si elle change l'interprétation (déclaratif ou mesuré, échantillon national ou local).

5. La limite : une donnée de 2010 sur le temps des repas ne dit rien des effets du télétravail et des plateformes de livraison apparus depuis.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.8

Un support d'atelier affirme : « Les Français ne prennent plus le temps de manger, ils mangent tous devant les écrans. » a) Relevez ce qui pose problème dans cette phrase. b) Indiquez la source qui permettrait de vérifier le temps consacré aux repas, et ce qu'elle indiquait en 2010. c) Réécrivez la phrase de façon rigoureuse.

Corrigé

a) Généralisation (« tous ») sans chiffre, sans source ni date ; confusion entre une tendance et une règle. **b)** L'enquête Emploi du temps de l'Insee : en 2010, les Français consacraient **2 h 22** par jour aux repas (Insee Première n° 1417, 2012), ce qui reste élevé par rapport à d'autres pays. **c)** « Selon l'Insee, les Français consacraient en 2010 environ 2 h 20 par jour aux repas ; le repas reste un moment important, même si les repas pris devant un écran ou seuls se développent, surtout chez les jeunes adultes (CNA, avis n° 90, 2022). »

Manger hors du foyer : restauration collective, restauration rapide, livraison

Une part croissante des repas est prise **hors du domicile** ou préparée **hors du domicile** : restauration scolaire et d'entreprise, restauration rapide, vente à emporter, livraison par plateformes. Cette évolution modifie le comportement alimentaire de plusieurs façons.

Évolution	Conséquences possibles	Leviers de santé publique
Restauration collective (école, travail, établissements de santé)	Repas structuré et équilibré si l'offre est de qualité ; dépend des choix et du temps de repas	Grammages et fréquences des plats, menus végétariens, loi EGalim, éducation au goût au restaurant scolaire
Restauration rapide et vente à emporter	Repas souvent denses en énergie, riches en sel et en sucres, pris vite, parfois en marchant	Offre de qualité aux abords des établissements, information sur les menus, partenariats avec les commerçants
Livraison par plateformes	Moins de cuisine à domicile, grandes portions, coût élevé, repas pris seul devant un écran	Compétences culinaires rapides, recettes « aussi rapides qu'une livraison »

Évolution	Conséquences possibles	Leviers de santé publique
Repas pris sur le lieu de travail, au poste	Repas court, peu de pause, grignotage	Salles de pause conviviales, temps de pause protégé

Calcul détaillé – La part des repas hors foyer dans une semaine (données fictives)

Un apprenti de 19 ans note ses 14 déjeuners et dîners d'une semaine : 4 au restaurant d'entreprise, 3 en restauration rapide, 2 livrés au domicile, 5 cuisinés chez lui.

- Repas préparés hors du foyer : 4 + 3 + 2 = **9 sur 14**, soit 9 / 14 × 100 = **64,3 %**.
- Repas cuisinés à domicile : 5 / 14 × 100 = **35,7 %**.
- Dépense : restaurant d'entreprise 4 × 4,20 € = 16,80 € ; restauration rapide 3 × 9,50 € = 28,50 € ; livraison 2 × 16,00 € = 32,00 € ; repas maison 5 × 2,50 € = 12,50 € ; total **89,80 €**. La livraison représente 2 repas sur 14 (14,3 %) mais 32,00 / 89,80 × 100 = **35,6 %** de la dépense.

Lecture : remplacer les 2 livraisons par 2 repas maison ferait économiser 2 × (16,00 − 2,50) = **27,00 €** par semaine, soit environ 108 € sur 4 semaines : un argument concret pour un atelier « plus rapide qu'une livraison ».

Lien diététique – La restauration collective, levier majeur

La restauration collective sert chaque jour plusieurs millions de repas dans les écoles, les entreprises, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. Elle touche tous les milieux sociaux : améliorer son offre est une action de santé publique **universelle**, qui réduit les inégalités (chapitre 1, universalisme proportionné). Le diététicien y intervient en BC2 (élaboration des menus) et en BC3 (éducation des convives, animations).

4.3.6 Les principales pratiques alimentaires actuelles

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

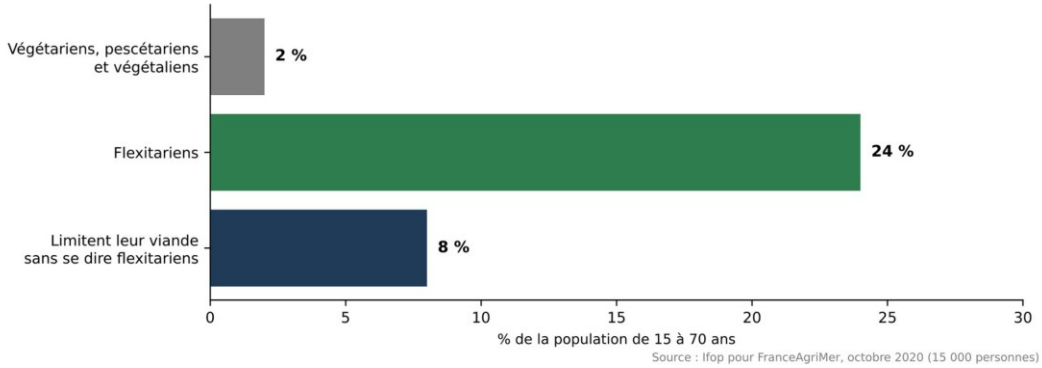


Figure 4.5 – Végétariens et flexitariens en France (2020)

Comprendre le schéma – Figure 4.5

1. Les régimes **sans viande** (végétariens, pescétariens, végétaliens) restent **minoritaires** : environ **2 %** de la population de 15 à 70 ans en 2020.
2. Les **flexitariens** (personnes qui réduisent volontairement leur consommation de viande sans l'exclure) représentent **24 %**.
3. **8 %** limitent leur consommation de viande sans se déclarer flexitariens.
4. Une large majorité déclare penser que l'on consomme trop de viande en France (68 %) ; la réduction de la viande est donc une tendance de fond, en cohérence avec les repères de 2019 et l'avis du HCSP de juin 2025 (seuil maximal pour l'ensemble des viandes, seuils plus bas pour la viande rouge et la charcuterie).

Pratique	Définition	Points de vigilance nutritionnelle
Flexitarisme	Réduction volontaire de la viande, sans exclusion	Peu de risques ; veiller aux apports en fer chez les femmes et adolescentes ; valoriser les légumineuses
Végétarisme (lacto-ovo)	Exclusion de la viande et du poisson ; consommation d'œufs et de produits laitiers	Fer (favoriser la vitamine C au repas), zinc, oméga-3 à longue chaîne, iode ; associer légumineuses et céréales
Pescétarisme	Exclusion de la viande, consommation de poisson	Peu de risques ; attention aux poissons prédateurs (méthylmercure) chez la femme enceinte
Végétalisme / véganisme	Exclusion de tous les produits animaux (le véganisme étend ce refus aux autres usages : cuir, cosmétiques…)	Supplémentation obligatoire en vitamine B12 ; calcium, vitamine D, iode, zinc, fer, oméga-3, protéines ; accompagnement diététique recommandé chez l'enfant, la femme enceinte et la personne âgée
Pratiques religieuses	Halal (islam), casher (judaïsme), interdits ou restrictions (porc, alcool, viande le vendredi, vaches dans l'hindouisme), jeûnes (Ramadan, Carême, jeûnes orthodoxes)	Respect des interdits en restauration collective et en atelier ; adaptation des horaires pendant le Ramadan (hydratation, repas de rupture équilibré) ; exemptions pour les personnes malades
Régimes « sans »	Sans gluten, sans lactose… justifiés médicalement (maladie cœliaque, allergie, intolérance) ou par choix	Hors diagnostic, l'éviction n'apporte pas de bénéfice démontré et peut entraîner des déséquilibres et un surcoût (prévention quaternaire)
Jeûne intermittent, régimes à la mode	Restriction dans le temps ou exclusion de familles d'aliments (cétogène, hyperprotéiné)	Peu de preuves de supériorité à long terme ; risque de restriction cognitive, de carences et de TCA
Alimentation durable	Produits de saison, locaux, bio, moins de viande, moins de gaspillage, moins d'emballages	Cohérente avec la santé ; attention au coût et à l'accessibilité pour les ménages modestes
Aliments ultra- transformés	Formulations industrielles (classification NOVA)	Ils représentent une part importante des apports des Français ; à limiter selon les repères de 2019

Attention – Le Ramadan en pratique

Pendant le mois de Ramadan, les personnes pratiquantes ne mangent et ne boivent pas du lever au coucher du soleil. En atelier ou en restauration collective, on peut proposer des repas à emporter pour la rupture du jeûne, conseiller une **hydratation** suffisante la nuit, un repas d'avant l'aube (suhur) riche en féculents complets et en protéines, et une rupture progressive. Les personnes malades, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées fragiles sont généralement dispensés selon la religion elle-même : le diététicien n'a pas à juger la pratique, mais à aider à la vivre en sécurité et à orienter en cas de pathologie (diabète : avis médical).

Composer un repas végétarien équilibré

Un repas végétarien équilibré associe, comme tout repas, une **source de protéines**, un **féculent**, des **légumes**, une **matière grasse de qualité** et, selon le repas, un **produit laitier** et un **fruit**. Sans viande ni poisson, deux points demandent une attention particulière : la **qualité des protéines** et l'**absorption du fer**.

Définition – La complémentarité des protéines végétales

Les protéines des **légumineuses** (lentilles, pois chiches, haricots) sont pauvres en acides aminés soufrés

(méthionine) mais riches en lysine ; celles des **céréales** (blé, riz, maïs) sont pauvres en lysine mais mieux pourvues en acides aminés soufrés. Associées dans la journée, elles se complètent et apportent tous les acides aminés indispensables. Les associations traditionnelles l'illustrent : couscous et pois chiches, riz et lentilles (dal), maïs et haricots rouges, pain et houmous.

Calcul détaillé – Un couscous végétarien (Ciqual 2025, une portion)

Composition : semoule cuite 150 g, pois chiches cuits 100 g, carottes cuites 100 g, courgettes cuites 100 g, navets cuits 80 g, huile d'olive 10 g ; dessert : yaourt nature 125 g et une clémentine de 100 g.

- **Énergie** : semoule 246,0 + pois chiches 148,0 + carottes 33,0 + courgettes 15,5 + navets 20,0 + huile 89,9 + yaourt 62,6 + clémentine 45,5 = **660,5 kcal**.
- **Protéines** : semoule 8,71 + pois chiches 8,31 + légumes 2,02 + yaourt 4,79 + clémentine 0,81 + huile 0,03 = **24,7 g**, soit 24,67 × 4 / 660,5 × 100 = **14,9 %** de l'énergie ; la semoule et les pois chiches en apportent ensemble 17,0 g, en association céréale et légumineuse.
- **Fibres** : **20,8 g** (dont 8,2 g pour les pois chiches) ; **calcium** : **365 mg** (dont 171 mg pour le yaourt) ; **fer** : **3,14 mg**, avec **57,3 mg** de vitamine C (dont 49,2 mg pour la clémentine) qui en améliore l'absorption.
- **Lipides** : 17,2 g, soit 17,2 × 9 / 660,5 × 100 = **23,4 %** de l'énergie ; **sel** : 0,48 g sans sel ajouté à la cuisson (il faut ajouter le sel de cuisson et du bouillon).

Lecture : le repas est rassasiant (beaucoup de fibres), apporte des protéines de bonne qualité grâce à l'association semoule et pois chiches, et reste peu coûteux. Le fer est surtout non héminique : la clémentine en fin de repas n'est pas un détail.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.9

Un restaurant scolaire propose comme plat végétarien « pâtes à la sauce tomate et fromage râpé ». a) Ce plat est-il végétarien ? Est-il équilibré ? b) Proposez deux modifications qui en font un plat végétarien complet. c) Citez deux autres associations céréale et légumineuse issues de cuisines du monde.

Corrigé

a) Il est végétarien (sans viande ni poisson), mais pauvre en protéines (le fromage en apporte un peu), en fer et en fibres : c'est un plat « sans viande » plutôt qu'un plat végétarien équilibré. **b)** Ajouter une légumineuse (sauce tomate aux lentilles corail ou haricots rouges) et des légumes (courgettes, poivrons, carottes) ; servir un fruit cru en dessert pour la vitamine C. **c)** Chili sin carne (haricots rouges et riz ou galettes de maïs), dal et riz (Inde), houmous et pain pita (Proche-Orient), riz et pois rouges (Antilles).

Le végétalisme aux périodes sensibles de la vie

Le végétalisme exclut tous les produits animaux. Chez l'adulte en bonne santé, une alimentation végétalienne bien planifiée, avec une **supplémentation en vitamine B12**, peut couvrir les besoins. Aux périodes où les besoins sont élevés ou les réserves faibles, le risque de carences augmente.

Période	Risques principaux	Ce qui est recommandé
Grossesse et allaitement	Carence en vitamine B12 chez la mère et l'enfant allaité (troubles neurologiques du nourrisson), apports en iode, fer, oméga-3 à longue chaîne (DHA), calcium	Suivi médical et diététique, supplémentation en vitamine B12, et selon l'avis médical en iode, DHA, fer, vitamine D

Période	Risques principaux	Ce qui est recommandé
Petite enfance et enfance	Besoins élevés pour la croissance ; carences en vitamine B12, calcium, vitamine D, fer, zinc, iode, DHA ; faible densité énergétique des repas	Le Groupe francophone d'hépatologie, gastroentérologie et nutrition pédiatriques (Lemale et collaborateurs, 2019) souligne ces risques et recommande, si ce régime est choisi, des supplémentations et un suivi médical et diététique régulier ; l'Académie royale de médecine de Belgique (2019) l'a jugé inadapté à l'enfant
Adolescence	Besoins élevés en calcium et en fer ; régimes parfois utilisés pour masquer une restriction (TCA)	Vérifier les motivations sans juger ; suivi, supplémentation en vitamine B12
Personne âgée	Risque de dénutrition protéino-énergétique, sarcopénie, carence en vitamine B12 (absorption déjà diminuée)	Vérifier les apports en protéines et en énergie, supplémentation, suivi

Attention – La place du diététicien de santé publique

Le diététicien ne cherche pas à faire renoncer une famille à ses convictions. Il **informe** sur les risques et les supplémentations indispensables, **sécurise** (repères pratiques, recettes riches en énergie et en protéines végétales) et **oriente** vers le médecin et une consultation diététique individuelle pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Un régime d'exclusion qui apparaît brutalement chez un adolescent, associé à une perte de poids, doit faire rechercher un TCA (4.3.13).

Les régimes d'éviction et les régimes à la mode : faire le point

Pratique	Quand elle est justifiée	Ce que l'on sait quand elle ne l'est pas
Sans gluten	**Maladie cœliaque** (environ 1 % de la population en Europe, diagnostic par le médecin, avec prise de sang et biopsie, **avant** toute éviction) ; allergie au blé ; sensibilité au gluten non cœliaque, encore discutée	Pas de bénéfice démontré pour la santé ou le poids ; produits plus chers, parfois plus gras et sucrés, moins de fibres ; une éviction avant le diagnostic rend celui-ci difficile
Sans lactose	Intolérance au lactose (fréquente chez l'adulte dans le monde, en lien avec la baisse de la lactase)	La plupart des personnes intolérantes supportent environ 12 g de lactose en une prise, soit l'équivalent d'un grand verre de lait, et mieux encore au cours d'un repas (EFSA, 2010) ; les fromages affinés et les yaourts sont souvent bien tolérés ; l'éviction totale réduit les apports en calcium
Jeûne intermittent	Choix personnel ; jeûnes religieux	Les essais comparant la restriction du temps des repas à une alimentation habituelle ou à une simple restriction calorique ne montrent pas de supériorité nette pour la perte de poids (Lowe et collaborateurs, 2020 ; Liu et collaborateurs, 2022) ; risque de restriction cognitive et de compulsions
Régimes cétogènes, hyperprotéinés	Indications médicales précises (certaines épilepsies de l'enfant, sous surveillance)	Peu de preuves à long terme ; exclusion de familles entières d'aliments ; difficiles à tenir ; effet yo-yo

Pratique	Quand elle est justifiée	Ce que l'on sait quand elle ne l'est pas
« Détox », monodiètes, cures de jus	Aucune	Pas de fondement scientifique (le foie et les reins éliminent les déchets) ; restriction sévère, perte d'eau et de muscle

Méthode pas à pas – Répondre à une personne qui suit un régime à la mode

1. **Demander** ce qu'elle en attend et ce qu'elle a remarqué (« Qu'est-ce qui vous a donné envie d'essayer ? »).
2. **Reconnaître** ce qui est positif (attention portée à l'alimentation, envie de cuisiner).
3. **Informer** de façon nuancée, avec des sources, sans ridiculiser.
4. **Vérifier** les risques : enfant, grossesse, maladie, signes de TCA, carences.
5. **Proposer** une alternative compatible avec ses objectifs (plus de légumes, moins de produits ultra-transformés, repas réguliers) et orienter si besoin.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.10

Une mère vous dit : « J'ai supprimé le gluten et le lait pour toute la famille, mes enfants de 4 et 9 ans compris, car j'ai lu que c'était inflammatoire. Personne n'a de maladie. » a) Quels risques nutritionnels pour les enfants ? b) Que lui répondez-vous, en suivant la méthode ? c) Vers qui l'orienter et pourquoi ?

Corrigé

a) Apports insuffisants en **calcium** et en vitamine D (produits laitiers supprimés), en fibres et en énergie si les céréales sont mal remplacées ; surcoût des produits « sans » ; risque de rendre difficile un diagnostic futur de maladie cœliaque. **b)** « Je comprends que vous vouliez protéger la santé de votre famille. Sans maladie diagnostiquée, supprimer le gluten et le lait n'a pas montré de bénéfice, et chez des enfants en croissance, le calcium du lait est important. On peut regarder ensemble comment garder des produits laitiers, par exemple des yaourts et du fromage, et varier les céréales avec du riz, du sarrasin ou du maïs. » **c)** Vers le médecin traitant ou le pédiatre, pour vérifier l'absence de maladie et l'état nutritionnel des enfants, et vers une consultation diététique individuelle si elle maintient l'éviction.

Le jeûne intermittent et les régimes à la mode

De nouvelles pratiques se diffusent rapidement par les réseaux sociaux et les livres grand public. Le diététicien doit pouvoir en parler **sans mépris et sans complaisance** : expliquer ce qu'elles sont, ce que l'on sait de leurs effets, et pour qui elles présentent des risques.

Pratique	Principe	Ce que disent les études	Vigilance
Jeûne intermittent « 16:8 » (alimentation limitée dans le temps)	Manger sur une plage de 8 heures, jeûner 16 heures	Dans un essai de 12 semaines (Lowe et collaborateurs, 2020), pas de perte de poids supérieure à un groupe mangeant sans contrainte horaire ; dans un essai de 12 mois (Liu et collaborateurs, 2022), associer une restriction horaire à une restriction calorique n'a pas fait mieux que la seule restriction calorique	Adolescents, antécédents de TCA, diabète traité, grossesse : à déconseiller ou à encadrer médicalement
Jeûne « 5:2 » ou un jour sur deux	Deux jours par semaine très restreints (environ 500 à 600 kcal), ou alternance	Perte de poids comparable à une restriction continue ; abandon fréquent	Fatigue, irritabilité, compensation les jours libres

Pratique	Principe	Ce que disent les études	Vigilance
Régime cétogène hors indication médicale	Très peu de glucides (moins de 50 g par jour)	Perte de poids rapide au début, en partie d'eau ; peu de données à long terme	Faibles apports en fibres, en fruits, en légumineuses ; utilisé en médecine pour certaines épilepsies, sous surveillance
Cures « détox »	Jus, tisanes, monodiètes	Aucune preuve d'une « élimination de toxines » : le foie et les reins assurent cette fonction	Apports insuffisants, coût élevé, culpabilisation

À retenir – Une position professionnelle

L'ANSES (rapport sur les pratiques alimentaires d'amaigrissement, 2010) a souligné les risques des régimes restrictifs : déséquilibres, perte de masse musculaire, reprise de poids fréquente et **restriction cognitive** (4.3.3). Face à une personne qui pratique un jeûne intermittent, on **écoute** sa motivation (perte de poids, simplicité, effet de groupe), on vérifie l'**absence de situation à risque**, on regarde la **qualité** de ce qui est mangé pendant la plage autorisée et l'impact sur la vie sociale (repas de famille sautés), puis on construit avec elle des repères durables.

Calcul détaillé – Calculer une plage de jeûne

Une étudiante dîne à 20 h 30 et prend son premier repas à 12 h 30 le lendemain.

- Jeûne : de 20 h 30 à minuit = 3 h 30 ; de minuit à 12 h 30 = 12 h 30 ; total : 3 h 30 + 12 h 30 = **16 heures**.
- Plage de prise alimentaire : 24 − 16 = **8 heures** (de 12 h 30 à 20 h 30).
- Comparaison : une personne qui dîne à 20 h et prend son petit-déjeuner à 7 h 30 jeûne déjà **11 h 30** chaque nuit.

Interprétation : la pratique « 16:8 » revient le plus souvent à **supprimer le petit-déjeuner**. Chez une étudiante qui a des cours le matin, il faut vérifier l'effet sur la concentration, le risque de grignotage l'après-midi, et la couverture des besoins en calcium (4.3.10).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.11

Un salarié de 45 ans, en bonne santé, vous dit pratiquer le jeûne 16:8 depuis trois mois : « Je me sens bien, et c'est plus simple pour moi. » Il a perdu 2 kg. Son repas de midi est un sandwich et un soda, le soir il mange beaucoup. a) Faut-il lui demander d'arrêter ? b) Que regardez-vous en priorité ? c) Proposez deux conseils qui respectent sa pratique.

Corrigé

a) Non : il est adulte, en bonne santé, la pratique lui convient et ne présente pas de risque identifié pour lui ; on respecte son choix (4.3.7) tout en lui donnant une information juste (pas d'effet supérieur démontré à long terme). **b)** La **qualité** et la **répartition** des apports pendant la plage de 8 heures : un déjeuner pauvre (sandwich et soda) puis un dîner très copieux. **c)** Composer un déjeuner plus complet et rassasiant (féculent, légumes, protéines, fruit, eau à la place du soda) ; prévoir une collation de fin d'après-midi (fruit, yaourt, pain) pour arriver au dîner sans faim excessive et dîner plus légèrement.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.5 et 4.3.6 – Évolutions et pratiques actuelles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Décrivez le modèle alimentaire français traditionnel en trois caractéristiques.
2. Quelle était la part de l'alimentation dans la consommation des ménages en 1960 et en 2014 ?

3. Définissez le syncrétisme culinaire.
4. Distinguez végétarisme, végétalisme et flexitarisme.
5. Quel supplément est obligatoire en cas de végétalisme ?
6. Pourquoi associer légumineuses et céréales ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.5 et 4.3.6

1. Trois repas à heures régulières, pris à table, en commun, structurés (entrée, plat, fromage ou dessert).
2. 35 % en 1960 et 20 % en 2014 (Insee, 2015).
3. La combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments issus de cultures culinaires différentes.
4. Végétarisme : ni viande ni poisson ; végétalisme : aucun produit animal ; flexitarisme : réduction volontaire de la viande sans exclusion.
5. La vitamine B12.
6. Leurs protéines se complètent : les légumineuses apportent la lysine qui manque aux céréales, les céréales des acides aminés soufrés qui manquent aux légumineuses.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.7 Accompagner l'évolution des pratiques alimentaires

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Méthode pas à pas – Cinq principes pour accompagner un changement de pratique

1. Comprendre avant de conseiller : demander à la personne ce qu'elle mange, pourquoi, ce qui compte pour elle (rôles de l'acte alimentaire, valeurs, contraintes).

2. Respecter les choix (végétarisme, religion, culture) et ne pas chercher à les « corriger » ; vérifier seulement la **sécurité nutritionnelle**.

3. Partir de l'existant : proposer de petits changements compatibles avec les habitudes (ajout plutôt que suppression ; remplacement plutôt qu'interdiction).

4. Préserver le plaisir et la convivialité : un conseil qui supprime le plaisir est rarement suivi.

5. S'appuyer sur des repères officiels à jour (Santé publique France, ANSES, HCSP) et sur des sources indépendantes, et orienter vers une consultation lorsque la situation le justifie (pathologie, régime d'exclusion chez l'enfant).

Exemple – Accompagner une famille qui devient végétarienne

Une famille avec deux enfants (6 et 10 ans) décide de devenir végétarienne pour des raisons éthiques. Le diététicien : respecte le choix ; vérifie la présence quotidienne de produits laitiers et d'œufs ; propose des légumineuses plusieurs fois par semaine associées à des céréales ; conseille des sources de fer (légumineuses, céréales complètes) avec de la vitamine C au repas ; recommande des poissons gras si la famille les accepte, sinon de l'huile de colza et des noix pour les oméga-3 ; signale qu'en cas de passage au végétalisme, une supplémentation en vitamine B12 est indispensable et un suivi médical et diététique recommandé pour les enfants.

Recueillir les pratiques sans juger : les questions utiles

Accompagner commence par **comprendre**. Les techniques de communication (questions ouvertes, reformulation, écoute active) sont présentées au chapitre 3 (sections 3.3.8 et 3.3.9) ; voici comment les appliquer aux pratiques alimentaires.

Ce que l'on veut savoir	Question ouverte possible	À éviter
Les habitudes	« Racontez-moi une journée habituelle de repas, du réveil au coucher. »	« Vous prenez bien un petit-déjeuner ? » (question fermée qui induit la réponse)
Le sens d'une pratique	« Qu'est-ce qui compte pour vous dans cette façon de manger ? »	« Pourquoi vous ne mangez pas de viande ? » (le « pourquoi » met sur la défensive)
Les règles religieuses ou culturelles	« Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ou des périodes particulières ? »	Supposer une pratique à partir du nom ou de l'origine
Les contraintes	« Qu'est-ce qui vous facilite ou vous complique les repas en ce moment ? »	« Il suffit de s'organiser. »
Les envies de changement	« Si vous pouviez changer une seule chose dans vos repas, ce serait quoi ? »	Proposer une liste de changements avant d'avoir écouté

Méthode pas à pas – Vérifier la sécurité nutritionnelle d'une pratique

1. Identifier ce qui est exclu (familles d'aliments, périodes de jeûne).

2. Repérer les nutriments que ces aliments apportent (viande : fer, zinc, B12 ; produits laitiers : calcium ; céréales complètes : fibres, fer).

3. Vérifier si d'autres aliments les remplacent (légumineuses, boissons végétales enrichies, œufs).

4. Évaluer le contexte : âge, grossesse, maladie, budget, signes d'alerte.

5. Décider : conseils collectifs suffisants, ou orientation vers un médecin ou une consultation diététique individuelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.12

Transformez en questions ouvertes et non jugeantes : a) « Vous mangez assez de légumes ? » b) « Pourquoi vous donnez des sodas à vos enfants ? » c) « Vous êtes musulman, donc vous ne mangez pas de porc ? » d) « Vous savez qu'il ne faut pas sauter de repas ? »

Corrigé

a) « Quels légumes aimez-vous, et comment les préparez-vous à la maison ? » **b)** « Quelles boissons vos enfants prennent-ils pendant la journée ? Qu'est-ce qu'ils aiment boire ? » **c)** « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ? » (posée à tous les participants). **d)** « Comment se passent vos repas dans la journée ? Y a-t-il des moments où vous n'avez pas le temps de manger ? »

Un accompagnement suivi sur trois rencontres

Les cinq principes de l'accompagnement (début de la section) prennent tout leur sens dans la durée. L'exemple suivant, fictif, montre comment un changement se construit **pas à pas**, à partir de ce que la personne veut et peut faire.

Exemple – Mme K., 38 ans, trois enfants, rencontrée dans un centre social (données fictives)

Rencontre 1 – Comprendre. Mme K. vient à la permanence parce que « les enfants mangent trop de gâteaux

». Le diététicien l'écoute : elle travaille en horaires décalés, fait les courses une fois par semaine au supermarché, achète des paquets de gâteaux pour les goûters « parce que c'est pratique », et le repas du soir est souvent pris devant la télévision. Elle tient à ce que les enfants « aient de quoi manger » et à leur faire plaisir. Questions ouvertes : « Comment se passent les goûters à la maison ? » ; « Qu'est-ce qui serait le plus facile à changer pour vous ? ». Elle choisit **un seul objectif** : remplacer les gâteaux du goûter deux jours par semaine.

Rencontre 2 (trois semaines plus tard) – Ajuster. Elle a remplacé les gâteaux le mercredi et le samedi par du pain, du chocolat en tablette et un fruit : « Les petits ont bien aimé, le grand a râlé. » Le diététicien **valorise** l'essai, et cherche avec elle une solution pour le grand (il prépare lui-même son goûter, avec du pain et une pâte à tartiner en petite quantité, ou une banane). Elle décide de passer à **quatre goûters sur sept** et d'essayer un dîner par semaine sans télévision.

Rencontre 3 (deux mois plus tard) – Consolider. Quatre goûters sur sept sont « maison » ; le dîner sans écran du dimanche est devenu « le moment où l'on se raconte la semaine ». Elle signale qu'elle dépense un peu moins en gâteaux. Le diététicien l'aide à anticiper les moments difficiles (vacances scolaires, semaines de nuit) et propose qu'elle témoigne à l'atelier goûters du centre social.

Calcul détaillé – Mesurer le changement

- Goûters « maison » : 0 sur 7 au départ ; 2 sur 7 à la rencontre 2, soit 2 / 7 × 100 = **28,6 %** ; 4 sur 7 à la rencontre 3, soit 4 / 7 × 100 = **57,1 %**.
- Dîners sans écran : 0 sur 7 au départ ; 1 sur 7 ensuite, soit **14,3 %**.

Interprétation : le changement paraît modeste en chiffres, mais il est **choisi**, **réaliste** et **durable** ; il touche aussi le rôle social du repas. Un objectif imposé (« plus aucun gâteau ») aurait sans doute été abandonné en quelques jours.

À retenir – Ce que montre cet exemple

- On part de la **demande** et des **contraintes** de la personne (horaires, budget, goûts des enfants), pas d'un modèle idéal.
- Un **seul objectif** à la fois, choisi par la personne, formulé de façon concrète et mesurable.
- On **valorise** chaque essai, même partiel, et l'on cherche des solutions aux difficultés plutôt que de rappeler la règle.
- On **mesure** avec des indicateurs simples (nombre de jours sur 7) qui parlent à la personne.
- Les techniques d'entretien (questions ouvertes, reformulation, entretien motivationnel) sont détaillées au chapitre 3.

4.3.8 Les rythmes et la structure des prises alimentaires

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Repas, collations et grignotage

Le **rythme alimentaire** désigne le nombre, les horaires et la régularité des prises alimentaires. En France, le modèle des **trois repas** (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), complété d'un **goûter** chez l'enfant, reste largement majoritaire, avec des horaires plus synchronisés qu'ailleurs en Europe : vers 13 heures, près de la moitié des Français sont à table (Insee, enquête Emploi du temps 2010).

Prise	Définition	Points de vigilance
Repas	Prise structurée, à heure régulière, souvent assise et partagée	Saut de repas (petit-déjeuner chez les adolescents, déjeuner chez les actifs pressés)

Prise	Définition	Points de vigilance
Collation	Prise prévue, en petite quantité, entre deux repas, répondant à une faim (goûter de l'enfant, collation de la personne âgée ou du sportif)	Collation matinale à l'école non recommandée si l'enfant a pris un petit-déjeuner (avis de l'AFSSA, 2004)
Grignotage	Prises répétées, non structurées, sans faim, souvent automatiques et associées aux écrans	Apport énergétique peu perçu, aliments denses en énergie
Prise nocturne	Prise alimentaire la nuit (travail posté, insomnie, trouble)	Désynchronisation des rythmes ; repérer un éventuel syndrome d'alimentation nocturne

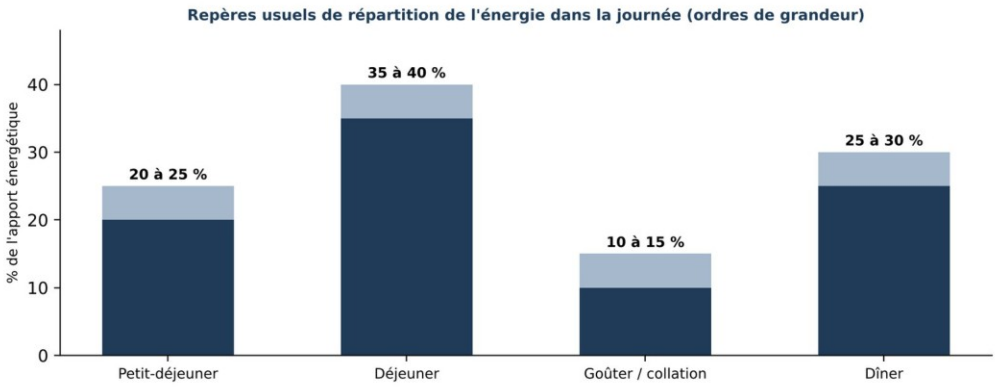


Figure 4.6 – Répartition usuelle de l'énergie dans la journée

Comprendre le schéma – Figure 4.6

1. Les fourchettes présentées sont des **ordres de grandeur** couramment utilisés en restauration collective et en éducation nutritionnelle ; elles ne sont pas des normes strictes et s'adaptent à l'âge, à l'activité, aux habitudes culturelles.
2. Le **petit-déjeuner** (20 à 25 %) et le **déjeuner** (35 à 40 %) apportent ensemble plus de la moitié de l'énergie de la journée.
3. Le **goûter** (10 à 15 %) est une vraie prise chez l'enfant et l'adolescent, en raison de l'écart entre déjeuner et dîner.
4. Le **dîner** (25 à 30 %) gagne à ne pas être le repas le plus copieux, surtout chez les personnes qui ont sauté des repas dans la journée.
5. La **régularité** compte autant que la répartition : elle facilite l'écoute de la faim et de la satiété (4.3.3).

Exemple – Calcul détaillé : répartition de l'énergie d'un adolescent

Un lycéen consomme sur une journée 2 700 kcal : petit-déjeuner 0 kcal (sauté), collation de 10 h (viennoiserie et soda) 520 kcal, déjeuner au self 950 kcal, grignotage de l'après-midi 480 kcal, dîner 750 kcal.

- Vérification : 0 + 520 + 950 + 480 + 750 = **2 700 kcal** . ✓
- Parts : collation de 10 h 520 / 2 700 × 100 = **19,3 %** ; déjeuner 950 / 2 700 = **35,2 %** ; grignotage 480 / 2 700 = **17,8 %** ; dîner 750 / 2 700 = **27,8 %**.
- Prises non structurées (collation de 10 h + grignotage) : 520 + 480 = 1 000 kcal, soit 1 000 / 2 700 × 100 = **37,0 %** de l'énergie.

Interprétation : plus d'un tiers de l'énergie est consommé hors repas, sous forme d'aliments denses en énergie et pauvres en fibres ; le petit-déjeuner sauté est « compensé » par la collation de 10 h. Piste : un petit- déjeuner rapide (lait ou yaourt, pain ou céréales, fruit) d'environ 500 kcal remplacerait la collation de 10 h, et un goûter structuré (pain, fromage, fruit) remplacerait le grignotage, sans augmenter l'apport total.

Le petit-déjeuner : des arguments à nuancer

Le petit-déjeuner est souvent présenté comme « le repas le plus important de la journée ». Les données justifient de le **recommander**, surtout chez l'enfant et l'adolescent, mais sans en faire une obligation.

Ce que l'on observe	Ce que l'on sait aujourd'hui
Dans les études d'observation, sauter le petit-déjeuner est associé à un surpoids plus fréquent et à une alimentation de moins bonne qualité	Une association n'est pas une preuve : les personnes qui sautent le petit-déjeuner ont souvent d'autres habitudes (sommeil court, grignotage, horaires irréguliers)
Chez l'adulte, des essais randomisés ont comparé « prendre » et « sauter » le petit-déjeuner	Pas d'effet net sur la perte de poids (Dhurandhar et collaborateurs, 2014 ; méta-analyse de Sievert et collaborateurs, 2019) ; le petit-déjeuner augmente un peu l'activité physique spontanée le matin (Betts et collaborateurs, 2014)
Chez l'enfant et l'adolescent	Un petit-déjeuner semble favoriser l'attention et la mémoire en fin de matinée, surtout chez les enfants dont l'alimentation est peu satisfaisante (revue d'Adolphus et collaborateurs, 2013) ; il aide à couvrir les besoins en calcium et en fibres

Lien diététique – Ce que l'on conseille

- Chez l'**enfant** et l'**adolescent** : un petit-déjeuner ou, à défaut, une **première prise structurée** avant 10 h (pain, produit laitier, fruit), sans collation sucrée en plus pour ceux qui ont déjeuné (avis de l'AFSSA, 2004).
- Chez l'**adulte** qui n'a pas faim le matin : il n'est pas utile de se forcer ; il vaut mieux prévoir une collation de qualité dans la matinée que d'arriver affamé au déjeuner.
- Partout : privilégier un petit-déjeuner **simple et peu coûteux**, plutôt que des produits très sucrés présentés comme « spécial petit-déjeuner ».

Calcul détaillé – Le coût d'un petit-déjeuner simple (prix fictifs, octobre 2026)

Pour un enfant : 50 g de pain (baguette à 1,10 € les 250 g), 10 g de beurre (2,40 € les 250 g), 200 mL de lait demi-écrémé (1,05 € le litre), une pomme de 150 g (2,40 € le kilo).

- Pain : 50 / 250 × 1,10 = **0,22 €** ; beurre : 10 / 250 × 2,40 = **0,10 €** ; lait : 0,2 × 1,05 = **0,21 €** ; pomme : 0,150 × 2,40 = **0,36 €**.
- Total : 0,22 + 0,10 + 0,21 + 0,36 = **0,89 €**. Avec un fruit de saison moins cher ou une demi-pomme pour un petit, on descend facilement sous 0,75 €.

Lecture : un petit-déjeuner équilibré n'est pas réservé aux familles aisées ; c'est un argument utile dans un atelier en quartier prioritaire.

Rythmes de vie et chrononutrition

L'horloge biologique (rythmes circadiens) influence l'appétit, la sensibilité à l'insuline et le métabolisme. Les travaux sur la **chrononutrition** suggèrent qu'une alimentation concentrée en journée et un dîner léger et pas trop tardif sont plus favorables, et que le **travail posté** ou de nuit augmente le risque de surpoids et de troubles métaboliques. Ces données relèvent encore en partie de la recherche ; en pratique, on conseille surtout **régularité**, **petit-déjeuner** ou première prise structurée, et organisation des repas adaptée aux horaires de travail (chapitre 3, étude de cas des salariés en 3 × 8).

Organiser les repas avec des horaires décalés

Le travail posté (2 × 8, 3 × 8), le travail de nuit et les horaires morcelés (aide à domicile, propreté, transport) désorganisent les rythmes alimentaires : repas sautés, grignotage la nuit, boissons sucrées et café pour tenir. Le principe est de garder **trois prises structurées** sur 24 heures, calées sur le **sommeil** plutôt que sur l'heure.

Poste	Organisation conseillée	Points d'attention
Matin (6 h – 14 h)	Petite collation au réveil (laitage, fruit) ; vraie collation vers 9 h-10 h (pain, fromage) ; déjeuner à la sortie ; dîner léger et pas trop tardif	Ne pas arriver au déjeuner de 14 h à jeun depuis la veille
Après-midi (14 h – 22 h)	Petit-déjeuner normal ; déjeuner complet avant 13 h 30 ; collation vers 18 h ; repas léger au retour	Éviter un repas copieux à 23 h juste avant le coucher
Nuit (22 h – 6 h)	Dîner complet avant la prise de poste (vers 20 h) ; collation légère vers 1 h-2 h (soupe, pain, laitage, fruit) ; petit-déjeuner léger au retour avant de dormir	Éviter les produits gras et très sucrés la nuit ; limiter le café en fin de poste pour préserver le sommeil

Exemple – Les salariés de nuit d'une plateforme logistique

Un service de santé au travail constate que les salariés de nuit grignotent au distributeur entre 2 h et 4 h. Plutôt que de distribuer des conseils écrits, le diététicien travaille avec l'entreprise : salle de pause équipée d'un four à micro-ondes et d'un réfrigérateur, distributeur proposant aussi des soupes, des yaourts et des fruits, pause repas protégée de 30 minutes, atelier « gamelles de nuit » animé sur le temps de travail. Les leviers sont **environnementaux** autant qu'individuels (chapitre 3, cas des salariés en 3 × 8).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.13

Une infirmière de nuit (21 h – 7 h) dîne à 19 h, ne mange rien pendant la nuit puis, en rentrant à 7 h 30, prend un grand petit-déjeuner avant de dormir jusqu'à 14 h ; elle déjeune à 15 h et grignote jusqu'à son départ. a) Repérez deux problèmes de rythme. b) Proposez une organisation sur 24 heures avec trois prises structurées et une collation.

Corrigé

a) Un jeûne de plus de 12 heures pendant la nuit de travail, ce qui favorise la fatigue et les malaises vers 3 h-4 h ; un repas copieux juste avant de dormir, qui gêne le sommeil ; un grignotage l'après-midi qui remplace un vrai repas. **b)** 15 h : premier repas complet au réveil ; 20 h : dîner complet avant de partir ; 1 h-2 h : collation légère pendant la pause (soupe, pain, fromage, fruit) ; 7 h 30 : petite prise avant de dormir (laitage et fruit, ou une tartine). La journée garde trois repas et une collation, adaptés au sommeil.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.7 et 4.3.8 – Accompagner, rythmes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq principes pour accompagner un changement de pratique.
2. Transformez en question ouverte : « Vous mangez des légumes ? »
3. Distinguez collation et grignotage.
4. Donnez la répartition usuelle de l'énergie entre les quatre prises de la journée.
5. Que montrent les essais randomisés sur le petit-déjeuner et le poids chez l'adulte ?
6. Pour un poste de nuit, où placer le dîner et la collation ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.7 et 4.3.8

1. Comprendre avant de conseiller ; respecter les choix ; partir de l'existant ; préserver le plaisir et la convivialité ; s'appuyer sur des repères officiels et orienter si besoin.
2. « Quels légumes aimez-vous et comment les préparez-vous ? »
3. La collation est prévue, en petite quantité, en réponse à une faim ; le grignotage est fait de prises répétées, non structurées, sans faim.
4. Petit-déjeuner 20 à 25 %, déjeuner 35 à 40 %, goûter 10 à 15 %, dîner 25 à 30 % (ordres de grandeur).
5. Pas d'effet net sur la perte de poids (Dhurandhar et collaborateurs, 2014 ; Sievert et collaborateurs, 2019).
6. Un dîner complet avant la prise de poste (vers 20 h) et une collation légère vers 1 h-2 h.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.9 Le développement du comportement alimentaire de l'enfant

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : Synthèse M2 S3 §1 (p. 20 et 21)

De la succion aux morceaux

Âge	Étapes	Rôle de l'entourage
0-6 mois	Succion-déglutition réflexes ; lait maternel ou infantile ; régulation à la demande	Repérer les signes de faim et de satiété ; soutenir l'allaitement
4-6 mois	Début de la diversification (entre 4 mois révolus et 6 mois selon les recommandations de Santé publique France, 2021), purées lisses ; introduction des allergènes sans retard	Proposer, varier, ne pas forcer
6-12 mois	Textures moulinées puis écrasées, petits morceaux fondants vers 8-10 mois ; mastication	Adapter les textures, laisser toucher, manger en famille
1-3 ans	Alimentation proche de celle de la famille (sans sel ajouté, textures adaptées) ; autonomie à la cuillère	Repas partagés, modèles, régularité
2-6 ans	Néophobie maximale (refus des aliments nouveaux), sélectivité	Exposition répétée (8 à 15 fois), sans pression ; goûter « un peu »
6-11 ans	Ouverture progressive, influence de l'école et des pairs	Cuisiner ensemble, éducation sensorielle, cantine

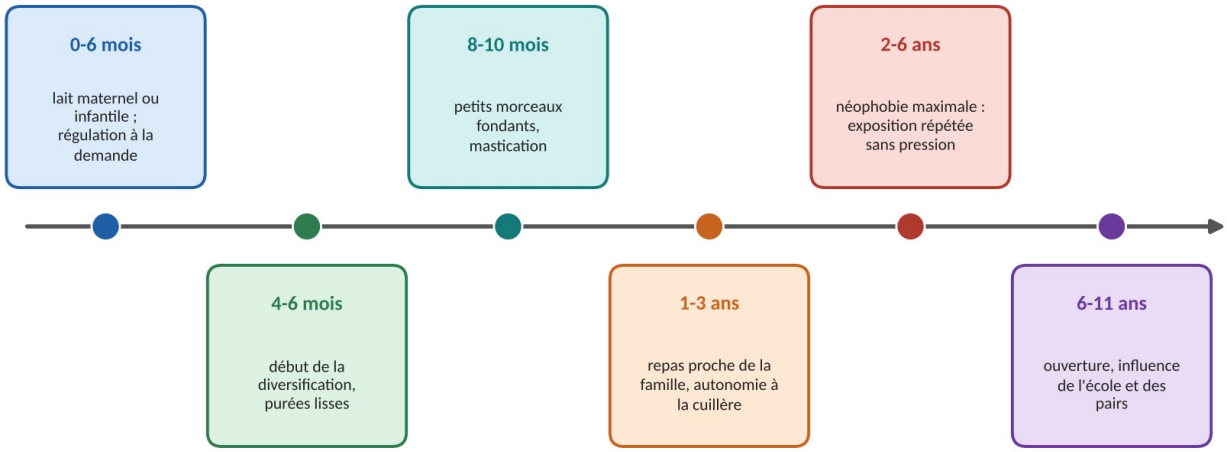


Figure 4.6 bis – Le développement du comportement alimentaire de l'enfant

Comprendre le schéma – Figure 4.6 bis

1. La frise se lit de gauche à droite ; les périodes se **chevauchent** : chaque enfant avance à son rythme.
2. **0-6 mois** : lait maternel ou infantile, à la demande ; le bébé régule seul sa prise selon sa faim.
3. **4-6 mois** : début de la diversification, avec des purées lisses et tous les groupes d'aliments, allergènes compris.
4. **8-10 mois** : petits morceaux fondants ; la mastication s'apprend en mangeant.
5. **1-3 ans** : l'enfant mange presque comme la famille (sans sel ajouté, textures adaptées) et devient autonome à la cuillère.
6. **2-6 ans** : la néophobie est maximale ; l'exposition répétée, sans pression, permet de l'atténuer (chapitre 3, section 3.4.1).
7. **6-11 ans** : ouverture progressive, sous l'influence de l'école, de la cantine et des pairs.

Pression, restriction, récompense : ce que montrent les études

Les recommandations de Satter (ci-dessous) s'appuient sur des expériences menées depuis les années 1980, surtout par l'équipe de Leann Birch, aux États-Unis.

Étude	Ce qui a été fait	Résultat
Birch et Marlin (1982)	Des enfants de 2 ans goûtent des fruits ou des fromages inconnus, de 0 à 20 fois	La préférence augmente avec le nombre d'expositions ; il en faut souvent une dizaine
Fisher et Birch (1999)	On place un aliment apprécié dans un bocal visible mais inaccessible pendant une partie de la séance	Quand le bocal est ouvert, les enfants en prennent davantage et en parlent plus : la **restriction** augmente l'attrait
Galloway et collaborateurs (2006), « Finis ta soupe »	Des enfants de 3 à 5 ans reçoivent une soupe, avec ou sans incitation à la finir	Avec la pression, ils en mangent **moins** et font davantage de remarques négatives sur la soupe
Birch et collaborateurs (1980 et 1984)	Un aliment est donné en récompense, ou l'on récompense le fait de manger un aliment	L'aliment donné en récompense devient plus apprécié ; l'aliment « récompensé » devient moins apprécié

À retenir – Trois règles tirées de ces études

- **Proposer souvent**, en petite quantité, sans obliger : l'exposition répétée fonctionne mieux que l'insistance.

- **Ne pas interdire** un aliment de façon absolue : on en fixe la fréquence et la quantité (c'est le rôle du parent, le « quoi »), sans en faire un fruit défendu.
- **Ne pas récompenser** avec la nourriture ni récompenser le fait de manger : on félicite la curiosité, pas l'assiette vide.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.14

Une maman dit : « Je cache les bonbons en haut du placard, et quand il mange ses légumes, il a droit à un bonbon. Pourtant, il ne pense qu'aux bonbons et déteste les légumes. » a) Expliquez ce comportement avec deux études du tableau. b) Proposez deux changements concrets.

Corrigé

a) La restriction (bonbons cachés) augmente leur attrait (Fisher et Birch, 1999) ; utiliser le bonbon comme récompense le valorise encore, et rend les légumes moins appréciés puisqu'ils deviennent une « épreuve » à passer (Birch et collaborateurs, 1980 et 1984 ; pression : Galloway et collaborateurs, 2006). **b)** Prévoir les bonbons à un moment fixe et en petite quantité (par exemple au goûter du mercredi), sans lien avec les légumes ; proposer les légumes sans condition, à côté d'aliments qu'il aime, et les manger devant lui avec plaisir ; le faire participer à leur préparation.

Le partage des responsabilités

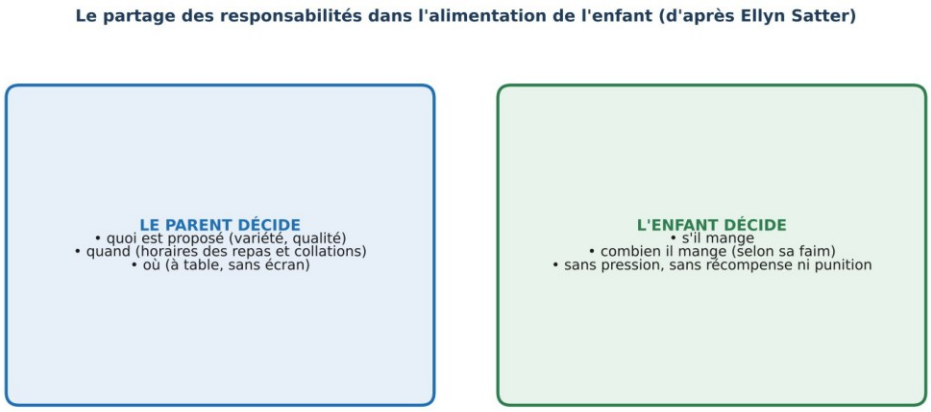


Figure 4.7 – Le partage des responsabilités (Satter)

Comprendre le schéma – Figure 4.7

1. Selon la diététicienne américaine Ellyn **Satter**, le parent est responsable du **quoi**, du **quand** et du **où** : il propose une offre variée, à des horaires réguliers, dans un cadre agréable.
2. L'enfant est responsable du **si** et du **combien** : il mange selon sa faim, sans être forcé, récompensé ni puni.
3. Ce partage protège la **régulation** naturelle de l'enfant (4.3.3) : la pression (« finis ton assiette ») et la restriction (« pas de dessert ») perturbent l'écoute des sensations et augmentent l'attrait des aliments interdits.
4. Pour le diététicien, ce modèle aide à **déculpabiliser** les parents (« ce n'est pas un échec si l'enfant ne mange pas tout ») et à recentrer leur action sur l'offre et l'ambiance.

Exemple – Calcul détaillé : programmer l'exposition répétée à un légume

Un centre de loisirs veut faire accepter le brocoli. Les études indiquent qu'il faut souvent **8 à 15 expositions**

pour qu'un enfant accepte un aliment nouveau. L'accueil a lieu 2 jours par semaine (mercredi et vendredi) ; le brocoli est proposé une fois par jour d'accueil, sous des formes variées.

- Pour 8 expositions : 8 / 2 = **4 semaines** ; pour 15 expositions : 15 / 2 = **7,5**, soit **8 semaines**.
- Sur une période de 7 semaines entre deux vacances scolaires : 7 × 2 = **14 expositions** possibles.
- **Résultat observé** (fictif) : 30 enfants ; à la 1re exposition, 6 goûtent (6 / 30 = **20 %**) ; à la 8e, 17 (17 / 30 = **56,7 %**) ; à la 14e, 22 (22 / 30 = **73,3 %**).

Leçon : la patience et la répétition sans pression sont plus efficaces que l'insistance ; il faut planifier l'exposition sur plusieurs semaines et associer les familles (même légume proposé à la maison).

Les styles parentaux en alimentation

Les psychologues distinguent quatre **styles parentaux alimentaires** selon deux dimensions : l'**exigence** (les attentes et le cadre posés par le parent) et la **sensibilité** (l'écoute de l'enfant et la chaleur de la relation) (Hughes et collaborateurs, 2005).

Style	Exigence	Sensibilité	Exemple à table	Effets observés
Démocratique (« faisant autorité »)	Élevée	Élevée	Le parent propose un repas varié, encourage à goûter, respecte la faim de l'enfant	Associé à une alimentation plus variée et à une meilleure régulation
Autoritaire	Élevée	Faible	« Tu finis ton assiette, point final. »	Pression, conflits, risque de perte de la régulation
Permissif (« indulgent »)	Faible	Élevée	L'enfant choisit ce qu'il veut, quand il veut ; plats à part	Associé à plus de produits sucrés et gras et à un risque de surpoids
Désengagé	Faible	Faible	Pas de repas organisé, l'enfant se sert seul	Le plus défavorable : irrégularité, grignotage

Le style démocratique correspond au **partage des responsabilités** : cadre clair (quoi, quand, où) et confiance dans la régulation de l'enfant (si et combien). Ces styles décrivent des tendances : un même parent peut changer de style selon la fatigue, le moment ou l'enfant. Le diététicien s'en sert pour **comprendre**, jamais pour étiqueter un parent.

La diversification alimentaire aujourd'hui

Les repères ont changé à la fin des années 2010. Le Haut Conseil de la santé publique (avis de 2020 sur les repères alimentaires des enfants de 0 à 3 ans) et Santé publique France (brochure « Pas à pas, votre enfant mange comme un grand », 2021) recommandent notamment :

- de commencer la diversification **entre 4 mois révolus et 6 mois**, pas avant 4 mois ;
- d'introduire **tous les groupes d'aliments** progressivement, y compris les **allergènes majeurs** (œuf, arachide sous forme de poudre ou de purée, gluten, poisson), sans retard, même dans les familles allergiques : retarder ne protège pas ;
- de ne pas ajouter de sel ni de sucre, et de garder le lait maternel ou un lait infantile (pas de lait de vache comme boisson principale avant 1 an) ;
- de ne pas donner de miel avant 1 an (risque de botulisme infantile) ni de fruits à coque entiers aux jeunes enfants (risque d'étouffement) ;
- d'adapter les textures à l'enfant et de proposer des petits morceaux fondants vers 8 à 10 mois, en restant à côté de lui pendant le repas.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.15

Identifiez le style parental alimentaire : a) « Je lui prépare des nuggets tous les soirs, c'est ce qu'il aime, je ne veux pas de cris. » b) « On mange à 19 h, il y a du poisson, des carottes et du pain ; il goûte, et s'il n'a plus faim, il peut sortir de table. » c) « Chez nous, chacun mange quand il rentre, il y a des plats dans le

congélateur. » d) « Pas de dessert tant que l'assiette n'est pas vide. »

Corrigé

a) Permissif (forte sensibilité, peu d'exigence). **b)** Démocratique (cadre et écoute : partage des responsabilités). **c)** Désengagé (pas de repas organisé ni d'accompagnement). **d)** Autoritaire (exigence sans écoute de la faim).

4.3.10 Les comportements alimentaires selon les âges de la vie

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : Synthèse M2 S3 §2 et §3 (p. 22 et 23) ; Synthèse M2 S3 §4 (p. 24)

Période	Comportements fréquents	Points d'attention en santé publique
Adolescence	Saut du petit-déjeuner, restauration rapide entre pairs, boissons sucrées et énergisantes, préoccupations corporelles, régimes	Apports en calcium, fer (adolescentes), vitamine D ; prévention des TCA ; littératie critique (réseaux sociaux)
Jeunes adultes	Premier logement, budget serré, repas sautés, plats préparés, livraisons	Compétences culinaires, précarité étudiante, restauration universitaire
Adultes actifs	Contraintes de temps, déjeuner pris rapidement ou au poste de travail, repas du soir copieux	Restauration d'entreprise, organisation, charge mentale du repas (souvent portée par les femmes)
Grossesse et allaitement	Envies, dégoûts, nausées, préoccupation pour la santé de l'enfant	Folates, iode, fer, prévention des toxi-infections (listériose, toxoplasmose), prise de poids adaptée
Personnes âgées	Baisse de l'appétit et de la soif, du goût et de l'odorat, troubles dentaires, isolement, repas simplifiés	Dénutrition, déshydratation, apports en protéines et en calcium, plaisir et convivialité

Attention – La charge mentale alimentaire

La planification, les courses, la cuisine et la gestion des préférences de chacun reposent encore majoritairement sur les **femmes** dans les familles françaises (enquêtes Emploi du temps de l'Insee). Un conseil nutritionnel qui ignore cette **charge mentale** risque d'ajouter une pression ; on privilégie des solutions qui **simplifient** (menus de la semaine, cuisine en avance, participation des enfants et des conjoints).

L'adolescent : autonomie, pairs et besoins de croissance

L'adolescence est une période de **croissance rapide** (pic de croissance, acquisition d'une grande partie de la masse osseuse), et aussi une période où le jeune **conquiert son autonomie** alimentaire : il mange de plus en plus hors de la famille, choisit ses achats, imite ses pairs et les modèles des réseaux sociaux (chapitre 3). Les comportements fréquents (tableau du début de la section) se comprennent à partir de ces deux réalités.

Ce que vit l'adolescent	Comportement alimentaire possible	Piste pour l'éducation
Besoin d'autonomie et refus de l'autorité	Rejet des conseils des adultes, de la cantine « des petits »	Faire choisir, faire cuisiner, faire enquêter plutôt qu'expliquer
Importance du groupe	Restauration rapide entre amis, boissons partagées	Proposer des alternatives conviviales et peu chères, ne pas disqualifier les choix du groupe
Transformation du corps, image de soi	Régimes, sauts de repas, compléments « pour la muscu »	Parler de force, d'énergie et de bien-être, jamais de poids ; repérer les signes d'alerte de TCA (4.3.13)

Ce que vit l'adolescent	Comportement alimentaire possible	Piste pour l'éducation
Décalage du sommeil	Pas de faim le matin, grignotage le soir	Aborder le sommeil et les écrans (4.3.3)
Argent de poche limité	Achats au prix, à la portion	Comparer coût et satiété (densité énergétique, 4.3.3)

Calcul détaillé – Le calcium d'une journée d'adolescent (Ciqual 2025)

Repère : la référence nutritionnelle en calcium est d'environ **1 150 mg par jour** de 11 à 17 ans (ANSES, références nutritionnelles, 2021).

Journée observée : 250 mL de lait demi-écrémé au petit-déjeuner (119 mg pour 100 g), un yaourt nature de 125 g au self (137 mg pour 100 g), 30 g d'emmental dans un sandwich (978 mg pour 100 g), 150 g de brocoli cuit (39,4 mg pour 100 g), 1,5 L d'eau du robinet (7,13 mg pour 100 g, valeur moyenne qui varie beaucoup selon les communes).

- Lait : 250 × 119 / 100 = **297,5 mg** ; yaourt : 125 × 137 / 100 = **171,3 mg** ; emmental : 30 × 978 / 100 = **293,4 mg**.
- Brocoli : 150 × 39,4 / 100 = **59,1 mg** ; eau : 1 500 × 7,13 / 100 = **107,0 mg**.
- Total : 297,5 + 171,3 + 293,4 + 59,1 + 107,0 = **928,2 mg**, soit 928,2 / 1 150 × 100 = **80,7 %** de la référence.
- Avec un second yaourt au goûter : 928,2 + 171,3 = **1 099,5 mg**, soit **95,6 %**.

Interprétation : même avec trois produits laitiers, la référence n'est pas tout à fait atteinte ; un adolescent qui saute le petit-déjeuner perd d'un coup près d'un tiers de cet apport. Le petit-déjeuner et le goûter sont donc des moments clés pour le calcium à cet âge.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.16

Une collégienne de 14 ans ne prend plus de petit-déjeuner ni de produit laitier « pour ne pas grossir » et déjeune d'une salade au self. a) Quels besoins de son âge sont menacés ? b) Quel risque de comportement faut-il envisager ? c) Que fait le diététicien qui intervient dans une action collective au collège ?

Corrigé

a) Le **calcium** (acquisition de la masse osseuse), l'**énergie** et les **protéines** nécessaires à la croissance, le **fer** (règles). **b)** Une **restriction** alimentaire motivée par le poids, qui peut être le début d'un **TCA** : il faut rester attentif aux autres signes (perte de poids, isolement, activité physique excessive, préoccupation constante). **c)** Il ne pose pas de diagnostic et ne donne pas de régime ; il signale la situation, avec discrétion, à l'infirmière scolaire ou au médecin, qui pourront orienter ; dans l'action collective, il porte des messages sur la croissance, la force et le plaisir, sans parler de poids (4.3.13).

Deux périodes de transition : la grossesse et l'entrée dans la vie étudiante

La grossesse modifie le comportement alimentaire : nausées et vomissements (surtout au premier trimestre), dégoûts (café, viande, odeurs de cuisson), envies (aliments salés, acides, sucrés), parfois **pica** (envie de substances non alimentaires comme la terre ou la glace, à signaler au médecin car elle peut accompagner une carence en fer). C'est aussi une période de grande **réceptivité** aux conseils : les futurs parents veulent « bien faire ». Les messages portent sur la sécurité alimentaire (listériose, toxoplasmose : chapitre 13 et BC1), les folates, l'iode, l'alcool zéro, et sur une prise de poids adaptée, sans régime restrictif.

L'entrée dans la vie étudiante ou professionnelle est une rupture : on quitte le cadre familial (socialisation secondaire, chapitre 3, section 3.3.2), on gère seul son budget, ses courses et ses horaires. Les comportements fréquents sont les repas sautés, les plats préparés, la restauration rapide, les livraisons, la consommation d'alcool en soirée, et parfois la **précarité alimentaire** (renoncer à des repas faute d'argent). Les leviers sont la

restauration universitaire, les épiceries solidaires étudiantes, les ateliers « cuisine petit budget » et le repérage des étudiants en difficulté par les services de santé étudiante.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.17

Pour chacune des deux périodes (grossesse, entrée dans la vie étudiante), citez deux comportements alimentaires fréquents et une action de santé publique adaptée, en indiquant le lieu où elle peut être menée.

Corrigé

Grossesse : nausées et dégoûts, envies ; inquiétude sur les aliments « autorisés ». Action : un atelier « manger pendant la grossesse » en PMI ou en maternité, lors des séances de préparation à la naissance, centré sur la sécurité alimentaire, le plaisir et les petits repas fractionnés en cas de nausées. **Entrée dans la vie étudiante** : repas sautés, restauration rapide et livraisons. Action : ateliers « cuisine petit budget » avec le service de santé étudiante et l'épicerie solidaire du campus, et promotion du restaurant universitaire.

Repérer la dénutrition de la personne âgée en santé publique

Chez la personne âgée, la baisse de l'appétit, de la soif, du goût et de l'odorat, les problèmes dentaires, l'isolement et la perte d'autonomie conduisent souvent à manger moins. Le chapitre 3 (section 3.4.9) montre comment préserver le plaisir et la convivialité ; ici, on rappelle comment **repérer** la dénutrition, pour orienter.

Définition – Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS, 2021)

Le diagnostic repose sur **au moins un critère phénotypique** et **au moins un critère étiologique**.

- **Critères phénotypiques** : perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois, ou d'au moins 10 % par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ; indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée (baisse de la force et de la masse musculaires).
- **Critères étiologiques** : réduction de la prise alimentaire d'au moins 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de deux semaines par rapport à l'habitude ou aux besoins ; absorption réduite ; situation d'agression (maladie aiguë, inflammation chronique).

Le diagnostic est posé par un professionnel de santé ; en action collective, on repère et on oriente.

Calcul détaillé – Une situation repérée lors d'un repas partagé (données fictives)

Mme D., 81 ans, 1,58 m, pesait 63 kg il y a un mois (64 kg habituellement) et pèse aujourd'hui 59,5 kg. Sa voisine indique qu'elle « mange la moitié de son assiette depuis dix jours ».

- Perte de poids en 1 mois : 63 − 59,5 = 3,5 kg, soit 3,5 / 63 × 100 = **5,6 %** : critère phénotypique **présent** (au moins 5 % en 1 mois).
- IMC : 59,5 / (1,58 × 1,58) = 59,5 / 2,4964 = **23,8 kg/m²** : supérieur à 22, critère absent.
- Prise alimentaire réduite de moitié depuis plus d'une semaine : critère étiologique **présent**.

Conclusion : un critère phénotypique et un critère étiologique sont réunis : il faut orienter rapidement Mme D. vers son médecin traitant, qui confirmera le diagnostic et sa sévérité. L'IMC « normal » ne doit pas rassurer : c'est la **perte de poids** qui alerte.

Attention – Pas de régime après 70 ans sans avis médical

Chez la personne âgée, les régimes restrictifs (sans sel, sans graisse, sans sucre) prescrits « par habitude » diminuent le plaisir et la quantité mangée ; ils augmentent le risque de dénutrition. En santé publique, on valorise l'enrichissement des repas, le fractionnement et la convivialité.

Handicap et comportement alimentaire : deux situations fréquentes

Le diététicien en santé publique intervient aussi dans des établissements et services pour personnes en situation de handicap (foyers, instituts médico-éducatifs, ESAT). Deux situations y sont fréquentes et modifient profondément le comportement alimentaire.

Situation	Ce que l'on observe	Adaptations
Troubles de la déglutition (dysphagie) : infirmité motrice cérébrale, maladies neurologiques, grand âge	Toux pendant les repas, repas très longs, refus de certains aliments, fausses routes, perte de poids	Textures adaptées décrites par le cadre international **IDDSI** (8 niveaux, de 0 « liquide fin » à 7 « normal ») ; position assise, calme, temps suffisant ; évaluation par l'orthophoniste et le médecin
Sélectivité alimentaire dans les troubles du spectre de l'autisme	Répertoire très restreint (quelques aliments seulement), refus selon la couleur, la texture, la marque ou l'emballage, besoin de routine	Respecter les aliments acceptés, introduire très progressivement des aliments proches (même couleur ou même texture), présentation séparée des composants, repas prévisibles ; travail avec l'équipe éducative et, si besoin, l'ergothérapeute

Attention – Ne pas confondre sélectivité et caprice

Chez une personne autiste, la sélectivité tient souvent à une **sensibilité sensorielle** particulière (textures, odeurs, bruits) et au besoin de **prévisibilité** : forcer ou « affamer pour qu'il mange » aggrave l'anxiété et le refus. Une sélectivité très marquée, avec perte de poids, carences ou dépendance à des compléments, peut relever d'un **ARFID** (4.5) et justifie une évaluation médicale.

Exemple – Élargir progressivement le répertoire d'un jeune de 12 ans (IME)

Aliments acceptés : pâtes nature, pain de mie, nuggets d'une marque précise, yaourt à la vanille, compote de pommes en gourde. L'équipe choisit, avec la famille, d'avancer **par petites marches** : pâtes nature avec un peu de beurre, puis avec du fromage râpé à côté ; compote de pommes en gourde, puis compote de pommes et poires de la même marque ; nuggets maison panés comme ceux de la marque. Chaque nouvel aliment est d'abord seulement **posé** sur la table, puis touché, senti, léché, goûté, sans obligation. Après six mois, le répertoire est passé de 5 à 9 aliments : 9 − 5 = 4 aliments nouveaux, soit une augmentation de 4 / 5 × 100 = **80 %**.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.18

Dans un foyer d'accueil médicalisé, une résidente tousse souvent pendant les repas et met plus d'une heure à manger ; elle a perdu 3 kg en deux mois (poids habituel 60 kg). a) Calculez le pourcentage de perte de poids. b) Quelle hypothèse faut-il envisager ? c) Quelles sont les limites du rôle du diététicien et à qui transmettre l'information ?

Corrigé

a) 3 / 60 × 100 = **5 %** en deux mois. **b)** Des **troubles de la déglutition** (toux, repas très longs), avec un risque de fausses routes et de **dénutrition** (perte de poids importante en peu de temps). **c)** Le diététicien ne pose pas le diagnostic ; il transmet ses observations au médecin et à l'équipe soignante, qui demanderont une évaluation (orthophoniste) ; la texture adaptée (niveau IDDSI) sera ensuite définie avec eux, et le diététicien veillera à l'apport en énergie et en protéines et au plaisir de manger.

La personne âgée : changements physiques, sociaux et psychiques

On parle souvent de « personne âgée » à partir de **60 ou 65 ans** selon les sources (OMS, Insee) ; la HAS retient **70 ans et plus** pour le diagnostic de la dénutrition (2021). L'âge de la retraite n'est pas un critère de santé : il a changé plusieurs fois depuis 2010.

Plan	Changements	Conséquences sur l'alimentation
Physique	Baisse de la vue (presbytie), de l'audition, du goût et de l'odorat ; mauvais état dentaire ; perte de muscle (sarcopénie), risque de chute ; digestion plus lente ; moindre sensation de soif	Repas moins attrayants, mastication difficile, déshydratation ; risque de **dénutrition**
Social	Retraite (revenus, activité), veuvage, éloignement des enfants, entrée en établissement (menus imposés, horaires collectifs)	Solitude, repas sautés ou simplifiés, perte de choix
Psychique	Difficulté à accepter le corps qui change, sentiment d'inutilité, dépression	Perte d'appétit ; dans les cas graves, **syndrome de glissement** : la personne refuse de s'alimenter et de se soigner, ce qui met sa vie en danger en quelques semaines ; c'est une urgence médicale

Lien diététique – Garder le plaisir et le choix

Les repas mixés doivent rester présentés de façon appétissante (formes, couleurs) ; on propose le choix entre deux plats, des collations enrichies, et on fait du repas un moment de lien.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.9 et 4.3.10 – L'enfant et les âges de la vie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Entre quels âges commence la diversification alimentaire ?
2. Que décide le parent et que décide l'enfant, selon Satter ?
3. Qu'ont montré Galloway et collaborateurs (2006) ?
4. Citez les quatre styles parentaux alimentaires.
5. Pourquoi ne pas donner de miel avant 1 an ?
6. Citez deux critères qui, réunis, permettent de diagnostiquer une dénutrition chez une personne de 70 ans et plus (HAS, 2021).

Corrigé – Point d'étape 4.3.9 et 4.3.10

1. Entre 4 mois révolus et 6 mois.
2. Le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien.
3. La pression pour finir une soupe fait manger moins et augmente les remarques négatives sur l'aliment.
4. Démocratique, autoritaire, permissif, désengagé.
5. Risque de botulisme infantile.
6. Au moins un critère phénotypique (par exemple une perte de poids d'au moins 5 % en un mois) et au moins un critère étiologique (par exemple une prise alimentaire réduite de moitié pendant plus d'une semaine).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.11 Observer et mesurer les comportements alimentaires

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : Synthèse M2 S3 §4 (p. 24)

Outil	Principe	Usage et limites
Rappel des 24 heures	Entretien sur tout ce qui a été consommé la veille	Précis mais une seule journée (variabilité) ; BC1, enquêtes nationales
Carnet ou journal alimentaire	Notation de tout ce qui est consommé pendant 3 à 7 jours	Modifie le comportement (on mange différemment quand on note) ; contraignant
Questionnaire de fréquence	Fréquence habituelle de consommation de groupes d'aliments	Rapide, adapté aux projets collectifs ; imprécis sur les quantités
Questionnaires de comportement	Restriction, désinhibition, émotions (TFEQ, DEBQ)	Outils de recherche ou de soin ; à manier avec prudence en collectif
Observation directe	Grille d'observation d'un repas ou d'un goûter	Comportements réels ; effet de la présence de l'observateur
Pesée des restes	Différence entre servi et consommé, en restauration collective	Objectif ; ne dit pas qui mange quoi

Exemple – Calcul détaillé : conformité aux repères à partir d'un questionnaire de fréquence

Un questionnaire auprès de 40 adultes d'une épicerie solidaire demande, pour la semaine précédente, le nombre de jours où ils ont mangé des légumes, et le nombre de fois où ils ont mangé des légumes secs.

- Légumes **tous les jours** (7 jours sur 7) : 14 personnes, soit 14 / 40 × 100 = **35 %**.
- Légumes secs **au moins 2 fois** dans la semaine : 11 personnes, soit 11 / 40 × 100 = **27,5 %**.
- Nombre moyen de prises de légumes secs : réponses 0 (×18), 1 (×11), 2 (×7), 3 (×3), 4 (×1). Total des prises : 0 × 18 + 1 × 11 + 2 × 7 + 3 × 3 + 4 × 1 = 0 + 11 + 14 + 9 + 4 = **38** ; moyenne : 38 / 40 = **0,95 fois par semaine** (le repère est d'au moins 2 fois).
- Vérification des effectifs : 18 + 11 + 7 + 3 + 1 = **40** ; au moins 2 fois : 7 + 3 + 1 = **11** . ✓ ✓

Interprétation : la consommation de légumes secs est très en dessous du repère, ce qui justifie un objectif spécifique ; la question porte sur une semaine (biais de mémoire limité) mais reste déclarative.

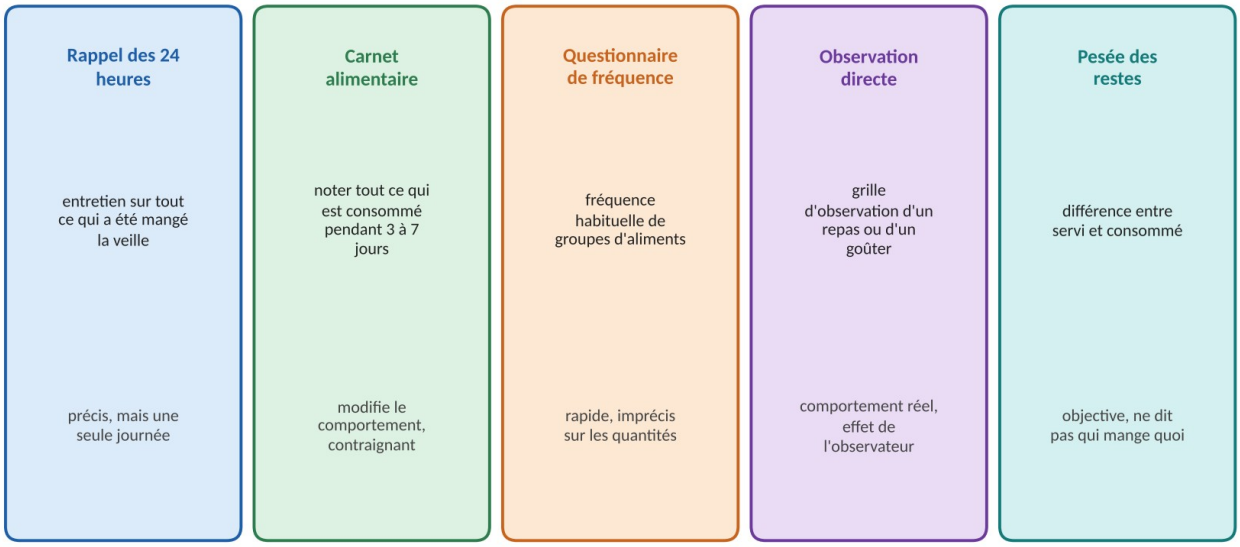


Figure 4.7 bis – Cinq outils pour observer et mesurer les comportements alimentaires

Comprendre le schéma – Figure 4.7 bis

1. Chaque colonne présente un outil : son **nom**, son **principe** (au milieu) et sa principale **limite** (en bas).
2. Les trois premiers outils (rappel des 24 heures, carnet, questionnaire de fréquence) sont **déclaratifs** : ils reposent sur ce que la personne dit, avec des biais de mémoire et de désirabilité sociale.
3. Les deux derniers (observation directe, pesée des restes) mesurent ce qui se passe **réellement**, mais ne disent pas pourquoi ni, pour la pesée, qui mange quoi.
4. On combine souvent un outil déclaratif et un outil d'observation pour croiser les résultats.

Construire une grille d'observation d'un repas

L'observation directe est l'outil le plus utile pour comprendre le **contexte** d'un repas (ambiance, durée, rôle des adultes), que les questionnaires saisissent mal. Une grille rend l'observation **systématique** et comparable d'un repas à l'autre ou d'un observateur à l'autre.

Méthode pas à pas – Construire et utiliser une grille d'observation

1. Définir la question : par exemple, « comment les adultes accompagnent-ils le goûter au centre de loisirs ? ».

2. Choisir des éléments observables, décrits sans interprétation : « l'adulte est assis à la table des enfants » plutôt que « l'adulte est disponible ».

3. Prévoir une modalité de réponse simple : oui ou non, nombre, durée en minutes.

4. Tester la grille sur un ou deux repas, à deux observateurs, et comparer : si les observateurs ne notent pas la même chose, reformuler les éléments.

5. Observer plusieurs repas (jours différents) pour limiter l'effet d'un jour particulier ; se faire discret pour limiter l'effet de l'observateur.

6. Traiter : pourcentage de repas où chaque élément est présent ; comparer avant et après une action.

Élément observé (exemple : goûter en centre de loisirs)	Réponse
Les enfants sont assis	Oui / Non
Un adulte est assis avec les enfants et goûte avec eux	Oui / Non
Durée du goûter	… minutes

Élément observé (exemple : goûter en centre de loisirs)	Réponse
L'eau est proposée	Oui / Non
Un aliment est imposé (« tu finis ») ou utilisé comme récompense	Oui / Non
Les enfants participent (servir, distribuer, ranger)	Oui / Non

Calcul détaillé – Accord entre deux observateurs (données fictives)

Deux stagiaires observent les mêmes 10 goûters avec la grille. Pour l'élément « un adulte est assis avec les enfants », ils notent la même réponse pour 8 goûters sur 10.

- Taux d'accord : 8 / 10 × 100 = **80 %**.
- Pour l'élément « un aliment est imposé ou utilisé comme récompense », ils ne sont d'accord que pour 6 goûters sur 10 : **60 %**. Cet élément regroupe deux comportements différents : on le sépare en deux éléments (« un aliment est imposé » ; « un aliment sert de récompense ») et l'on refait le test.

Lecture : un élément mal défini produit des résultats peu fiables ; tester la grille avant l'enquête évite de mesurer des impressions.

Les biais des enquêtes alimentaires

Biais	Explication	Comment le limiter
Sous-déclaration	On oublie ou on minimise ce que l'on a mangé (grignotage, boissons, sauces), surtout pour les aliments jugés « mauvais »	Relances (« et à boire ? »), photos de portions, rappel en plusieurs passages
Désirabilité sociale	On déclare ce qui paraît « bien » (plus de légumes, moins de sodas)	Questionnaire anonyme, questions neutres, enquêteur extérieur au groupe
Mémoire	Les souvenirs s'effacent vite, surtout pour les quantités	Période courte (la veille, la semaine précédente)
Modification du comportement	Le fait de noter ou d'être observé change ce que l'on mange	Plusieurs jours, discrétion de l'observateur, comparaison avec les jours non observés

Le rappel des 24 heures en pratique : la méthode des passages successifs

Le rappel des 24 heures est l'outil déclaratif le plus utilisé en entretien. Pour limiter les oublis, les grandes enquêtes (par exemple le Département de l'agriculture des États-Unis, avec sa méthode dite *Automated Multiple-Pass Method*) le conduisent en **plusieurs passages** sur la même journée.

Méthode pas à pas – Les cinq passages d'un rappel des 24 heures

1. Liste rapide : la personne cite librement tout ce qu'elle a mangé et bu la veille, de son lever à son coucher, sans être interrompue.

2. Aliments souvent oubliés : on relance par catégorie : boissons (dont alcool), sucreries, biscuits, fruits, pain, fromage, sauces, ce qui a été goûté en cuisinant.

3. Heure et occasion : pour chaque prise, on précise l'heure, le lieu et la compagnie (seul, en famille, devant un écran) ; cette étape fait souvent revenir des prises oubliées.

4. Détails : on précise chaque aliment (préparation, marque, matière grasse ajoutée) et la **quantité**, à l'aide de mesures ménagères, de photos de portions ou de vaisselle réelle.

5. Vérification finale : on relit la journée avec la personne, en lui demandant si quelque chose manque, par exemple entre deux prises éloignées.

Calcul détaillé – Ce que les relances font apparaître (données fictives)

Au premier passage, une personne déclare une journée de **1 450 kcal**. Les relances font apparaître : 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêlée du soir (environ 10 g chacune ; Ciqual 2025 : 900 kcal pour 100 g), un verre de 200 mL de cola sucré (10 g de sucres pour 100 g, 40,1 kcal pour 100 g, soit environ **80 kcal**), et un biscuit au chocolat d'environ **150 kcal** mangé en préparant le repas.

- Huile : 2 × 10 × 900 / 100 = **180 kcal**.
- Sucres du cola : 200 × 10 / 100 = **20 g**, soit environ quatre morceaux de sucre.
- Total corrigé : 1 450 + 180 + 80 + 150 = **1 860 kcal**, soit 410 kcal de plus, une hausse de 410 / 1 450 × 100 = **28,3 %**.
- Contrôle de plausibilité : le métabolisme de base de cette personne est estimé à 1 380 kcal (donnée fournie). Au premier passage, le rapport apport déclaré / métabolisme de base valait 1 450 / 1 380 = **1,05** ; après relances, 1 860 / 1 380 = **1,35**.

Interprétation : un rapport inférieur à environ 1,2 fait suspecter une sous-déclaration chez une personne qui garde un poids stable (seuils proposés par Goldberg et collaborateurs, 1991, qui varient selon le nombre de jours recueillis). Les relances ne sont donc pas un détail : sans elles, on aurait conclu à tort à une alimentation insuffisante.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.19

Lors d'un rappel des 24 heures, une adolescente cite seulement : « Rien le matin, un sandwich au self, des pâtes le soir. » a) Quelles relances faites-vous au deuxième passage ? b) Quelle question de l'étape 3 peut faire apparaître des prises oubliées ? c) Pourquoi faut-il rester neutre pendant tout le recueil ?

Corrigé

a) « Qu'avez-vous bu dans la journée, à la maison et dehors ? » ; « Avez-vous mangé quelque chose en sortant du collège, ou avec vos amis ? » ; « Y avait-il quelque chose avec les pâtes : sauce, fromage, beurre ? » ; « Avez-vous mangé un fruit, un yaourt, des biscuits ? ». **b)** « Que faisiez-vous entre la fin des cours et le dîner ? » : cette question sur le moment et le lieu fait souvent revenir un goûter ou un grignotage. **c)** Pour limiter la **désirabilité sociale** : une réaction (étonnement, conseil) pendant le recueil pousse la personne à cacher ou à embellir ce qu'elle mange ; les conseils viennent après, une fois le recueil terminé.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.11 – Observer et mesurer

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez cinq outils d'observation ou de mesure des comportements alimentaires.
2. Quelle est la principale limite du rappel des 24 heures ?
3. Pourquoi le carnet alimentaire modifie-t-il le comportement ?
4. Qu'apporte l'observation directe que les questionnaires n'apportent pas ?
5. Comment vérifier qu'une grille d'observation est fiable ?
6. Citez deux biais des enquêtes alimentaires déclaratives.

Corrigé – Point d'étape 4.3.11

1. Rappel des 24 heures, carnet alimentaire, questionnaire de fréquence, observation directe, pesée des restes (et questionnaires de comportement).
2. Il ne porte que sur une journée, qui peut ne pas être représentative.
3. Le fait de noter rend attentif à ce que l'on mange ; on mange souvent « mieux » ou moins les jours où l'on note.

4. Le contexte réel du repas : ambiance, durée, interactions, rôle des adultes.

5. En la testant à deux observateurs sur les mêmes repas et en calculant le taux d'accord ; on reformule les éléments sur lesquels ils ne sont pas d'accord.

6. Sous-déclaration, désirabilité sociale, biais de mémoire.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.12 Vers une alimentation durable : santé et environnement

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Définition – Alimentation durable (FAO, 2010)

Alimentation qui protège la biodiversité et les écosystèmes, est **acceptable culturellement**, **accessible**, **économiquement équitable et abordable**, **nutritionnellement sûre et saine**, et optimise l'usage des ressources naturelles et humaines. Elle concerne toute la chaîne : production, transformation, distribution, consommation, gaspillage.

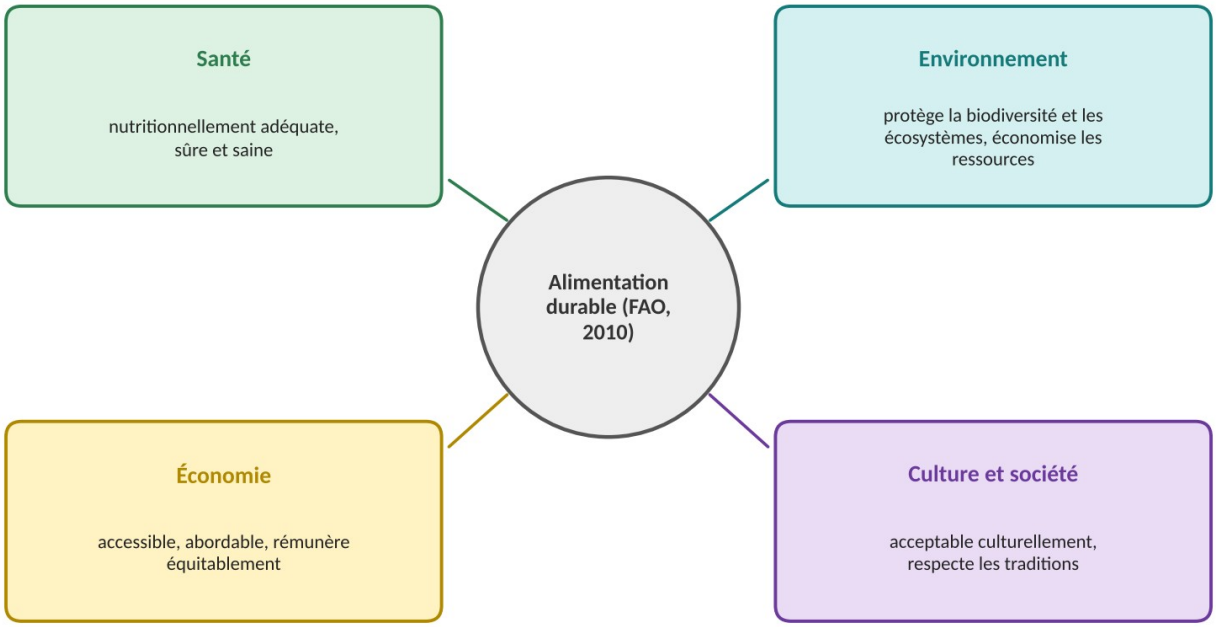


Figure 4.7 ter – Les quatre dimensions de l'alimentation durable (d'après la FAO, 2010)

Comprendre le schéma – Figure 4.7 ter

1. Au centre, l'**alimentation durable** telle que la définit la FAO (2010).

2. Santé : une alimentation nutritionnellement adéquate, sûre (sécurité sanitaire) et saine.

3. Environnement : elle protège la biodiversité et les écosystèmes et économise les ressources (eau, sols, énergie).

4. Économie : elle est accessible et abordable pour les consommateurs, et rémunère équitablement les

producteurs.

5. **Culture et société** : elle est acceptable culturellement et respecte les traditions.
6. Une action « durable » doit tenir les quatre dimensions ensemble : un panier bio trop cher pour les familles d'un quartier ne respecte pas la dimension économique ; un menu végétarien que personne ne mange ne respecte pas la dimension culturelle.

Le régime de santé planétaire

En 2019, la commission **EAT-Lancet** a proposé un « régime de santé planétaire » compatible avec la santé humaine et les limites de la planète pour 10 milliards d'habitants en 2050. Pour environ 2 500 kcal par jour, il comprend notamment : céréales complètes environ 230 g, légumes 300 g, fruits 200 g, produits laitiers 250 g, légumineuses environ 75 g (dont soja), fruits à coque 50 g, poisson environ 28 g, volaille environ 29 g, œufs 13 g, et seulement environ **14 g de viande rouge** par jour (soit environ 100 g par semaine). La mise à jour de la commission EAT-Lancet (*The Lancet*, octobre 2025) garde ces ordres de grandeur : au plus 98 g de viande rouge par semaine (14 g par jour), 203 g de volaille et 196 g de poisson par semaine, et au moins 125 g de légumineuses et fruits à coque par jour. En France, les repères de 2019 (limiter la viande à 500 g par semaine, privilégier la volaille, au moins 2 fois des légumes secs par semaine) et l'avis du HCSP de 2025 vont dans le même sens.

L'empreinte carbone de l'assiette

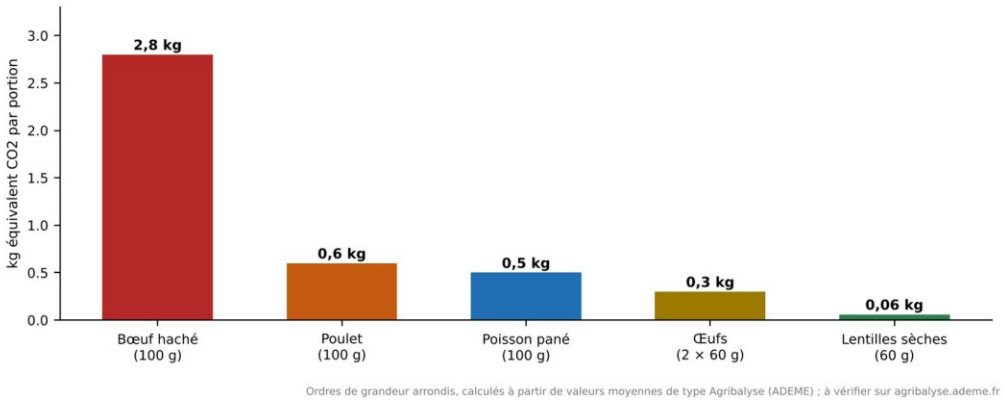


Figure 4.8 – Empreinte carbone de quelques sources de protéines (par portion)

Comprendre le schéma – Figure 4.8

1. Les valeurs sont des **ordres de grandeur** (base de données Agribalyse de l'ADEME, valeurs moyennes arrondies) ; elles varient selon le mode de production.
2. Une portion de **bœuf** émet environ **2,8 kg** équivalent CO2, soit près de **50 fois** plus qu'une portion de **lentilles** (0,06 kg) : 2,8 / 0,06 = 46,7.
3. La **volaille** (0,6 kg) et les **œufs** (0,3 kg) se situent à un niveau intermédiaire.
4. Remplacer une partie de la viande rouge par des légumineuses est donc à la fois **favorable à la santé**, **économique** (chapitre 2 : 0,16 € la portion de lentilles) et **favorable au climat** : c'est l'un des messages centraux de la SNANC 2025-2030.

Exemple – Calcul détaillé : l'empreinte d'une semaine de déjeuners

Une famille de 4 personnes mange au déjeuner, chaque semaine : bœuf haché 3 fois, poulet 2 fois, œufs 1 fois, lentilles 1 fois (portions de la figure 4.8).

- Par personne et par semaine : 3 × 2,8 + 2 × 0,6 + 1 × 0,3 + 1 × 0,06 = 8,4 + 1,2 + 0,3 + 0,06 = **9,96 kg** CO2e.
- Pour la famille : 9,96 × 4 = **39,84 kg** CO2e par semaine.
- **Scénario modifié** : bœuf 1 fois, poulet 2 fois, œufs 1 fois, lentilles ou pois chiches 3 fois : 2,8 + 1,2 + 0,3 + 3

× 0,06 = 2,8 + 1,2 + 0,3 + 0,18 = **4,48 kg** par personne ; famille : 4,48 × 4 = **17,92 kg**.

- **Réduction** : 39,84 − 17,92 = **21,92 kg** par semaine, soit 21,92 / 39,84 × 100 = **55 %** ; sur 52 semaines : 21,92 × 52 = **1 139,8 kg**, soit plus d'une tonne d'équivalent CO2 par an.
- **Effet sur le budget** (prix fictifs : bœuf 0,89 €, poulet 0,75 €, œufs 0,56 €, lentilles 0,16 € par portion) : avant : 3 × 0,89 + 2 × 0,75 + 0,56 + 0,16 = 2,67 + 1,50 + 0,56 + 0,16 = **4,89 €** par personne et par semaine ; après : 0,89 + 1,50 + 0,56 + 3 × 0,16 = 0,89 + 1,50 + 0,56 + 0,48 = **3,43 €** ; économie : 4,89 − 3,43 = **1,46 €** par personne et par semaine, soit 1,46 × 4 × 52 = **303,68 €** par an pour la famille.

Message pour un atelier : « Deux plats de légumes secs en plus par semaine : bon pour la santé, pour le porte- monnaie et pour la planète. »

Attention – Durable, mais accessible et sans culpabiliser

Les messages environnementaux ne doivent pas culpabiliser les familles modestes, dont l'empreinte globale est souvent plus faible, ni rendre l'alimentation durable synonyme de produits chers (bio, labels) : on valorise d'abord ce qui est **à la fois sain, durable et économique** (légumes secs, produits de saison, eau du robinet, anti-gaspillage).

Saison, local, labels : ce que fixe la loi EGalim

La loi EGalim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) a fixé des objectifs à la **restauration collective**. Depuis le 1er janvier 2022, les restaurants collectifs publics doivent servir au moins **50 % de produits durables et de qualité** (en valeur d'achat), dont au moins **20 % de produits issus de l'agriculture biologique**. Les produits « durables et de qualité » comprennent notamment les produits sous signe officiel de qualité (Label rouge, appellation d'origine, indication géographique), les produits de la mention « haute valeur environnementale » selon les conditions fixées par les textes, et les produits biologiques. La loi a aussi rendu obligatoire, en restauration scolaire, un **menu végétarien au moins une fois par semaine** (expérimentation en 2019, pérennisée par la loi Climat et résilience du 22 août 2021), et un **diagnostic du gaspillage alimentaire**.

Calcul détaillé – Le collège respecte-t-il les objectifs EGalim ? (données fictives)

Achats alimentaires de l'année : **180 000 €**, dont **72 000 €** de produits durables et de qualité, parmi lesquels **27 000 €** de produits biologiques.

- Part des produits durables et de qualité : 72 000 / 180 000 × 100 = **40,0 %** (objectif : 50 %).
- Part des produits biologiques : 27 000 / 180 000 × 100 = **15,0 %** (objectif : 20 %).
- Montants à atteindre : 50 % de 180 000 = **90 000 €** de produits durables, soit 90 000 − 72 000 = **18 000 €** de plus ; 20 % de 180 000 = **36 000 €** de produits bio, soit 36 000 − 27 000 = **9 000 €** de plus.

Piste : remplacer une partie de la viande par des légumineuses biologiques (bon marché) libère du budget pour acheter de la viande sous label ; la réduction du gaspillage libère aussi des marges.

Saison	Exemples de légumes	Exemples de fruits
Hiver	Chou, poireau, carotte, céleri, navet, endive, courge	Pomme, poire, agrumes (importés)
Printemps	Asperge, radis, petits pois, épinard, salade	Fraise (fin du printemps), rhubarbe
Été	Tomate, courgette, aubergine, poivron, haricot vert	Abricot, pêche, melon, cerise, prune
Automne	Courge, potiron, champignon, chou-fleur, betterave	Raisin, pomme, poire, figue

À vous de jouer – Exercice d'application 4.20

Un centre social veut organiser des « ateliers durables ». L'animatrice propose un atelier en janvier autour d'une salade de tomates, de courgettes et de fraises bio. a) Quelles dimensions de l'alimentation durable ne sont pas respectées ? b) Proposez une recette de saison, peu coûteuse et appréciée. c) Indiquez un message

qui ne culpabilise pas les familles.

Corrigé

a) Dimension **environnementale** : tomates, courgettes et fraises ne sont pas de saison en janvier (culture sous serre chauffée ou importation lointaine). Dimension **économique** : ces produits bio hors saison sont chers, peu accessibles aux familles. **b)** Une soupe de potiron et de carottes avec des lentilles corail, servie avec du pain et du fromage, puis une compote de pommes maison : de saison, peu chère, rassasiante. **c)** « Manger de saison, c'est meilleur et moins cher : les légumes d'hiver, en soupe ou en gratin, font des repas bons pour la santé, le porte-monnaie et la planète. »

Faire accepter les plats végétariens en restauration collective

Rendre obligatoire un menu végétarien hebdomadaire (voir ci-dessus) ne suffit pas : un plat que les convives ne prennent pas, ou laissent dans l'assiette, n'apporte rien à leur santé et augmente le gaspillage. L'acceptation dépend des **comportements** étudiés dans ce chapitre : habitudes, normes sociales, présentation, goût.

Levier	Ce que l'on sait	Application en restauration collective
Disponibilité	Dans des cafétérias universitaires de Cambridge, passer d'une option végétarienne sur quatre à deux sur quatre a augmenté les ventes de plats végétariens d'environ 40 à 80 % selon les sites, sans baisse de fréquentation (Garnett et collaborateurs, 2019)	Proposer régulièrement une option végétarienne, pas seulement le jour obligatoire
Nom et présentation	Regrouper les plats dans une rubrique « végétarienne » à part les fait moins choisir par les mangeurs de viande (Bacon et Krpan, 2018)	Nommer le plat par ce qu'il apporte en goût (« dahl de lentilles au lait de coco ») plutôt que par l'absence de viande (« plat sans viande ») ; l'intégrer à la carte normale
Familiarité	Un plat inconnu est d'abord refusé (néophobie, chapitre 3)	Commencer par des plats connus (lasagnes de légumes, chili sin carne, omelette, couscous de légumes et pois chiches) avant des recettes nouvelles
Goût et savoir-faire	Un plat végétarien fade ou sec est vite rejeté	Former les cuisiniers (épices, sauces, cuisson des légumineuses), faire goûter l'équipe avant la mise au menu
Normes sociales	On choisit ce que choisissent les autres	Faire goûter des portions de dégustation, associer les élèves (commission menus), afficher les plats préférés

Calcul détaillé – Un dahl de lentilles corail au riz pour un collégien (Ciqual 2025, une portion)

Ingrédients (poids crus) : lentilles corail sèches 50 g, riz blanc 60 g, tomates pelées égouttées 80 g, oignon 20 g, lait de coco 20 g, huile de colza 5 g.

- **Énergie** : 164,0 + 210,0 + 13,1 + 7,8 + 39,8 + 45,0 = **480 kcal**.
- **Protéines** : 13,85 + 4,21 + 0,72 + 0,22 + 0,39 + 0 = **19,4 g**, dont 13,85 / 19,39 × 100 = **71 %** apportés par les lentilles.
- **Fibres** : **10,1 g** ; **fer** : **5,4 mg** (fer non héminique, mieux absorbé avec un fruit riche en vitamine C au dessert).
- Comparaison avec un steak haché à 15 % de matières grasses (100 g cru) et 60 g de riz : 425 kcal, 24,4 g de protéines, 0,9 g de fibres, 3,8 mg de fer, 15,3 g de lipides (contre 10,1 g pour le dahl).

Interprétation : le dahl apporte un peu moins de protéines (19,4 g contre 24,4 g), mais une quantité

suffisante pour un plat principal, associée aux céréales (riz) pour la complémentarité (4.3.6) ; il apporte onze fois plus de fibres et moins de lipides. Un produit laitier au menu complète l'apport en protéines et en calcium.

Attention – Mesurer l'acceptation avant de conclure

Pour savoir si un plat végétarien « marche », on ne se fie pas aux impressions : on compte les plats pris (choix), on pèse les **restes** (4.3.11) et on recueille l'avis des convives (échelle hédonique, 4.3.16). Un plat moins pris la première semaine peut progresser avec l'habitude : on refait la mesure après trois ou quatre passages.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.21

Dans un lycée, le jour du menu végétarien, 180 élèves sur 520 inscrits (34,6 %) ne viennent pas à la cantine, contre 60 les autres jours. Le plat proposé est « Plat sans viande : galette de légumes ». a) Calculez le taux d'absence habituel et l'écart. b) Proposez trois leviers d'action. c) Indiquez deux indicateurs pour évaluer l'effet de vos actions.

Corrigé

a) Taux habituel : 60 / 520 × 100 = **11,5 %** ; le jour végétarien : 180 / 520 × 100 = **34,6 %** ; écart : 34,6 − 11,5 = **23,1 points**, soit 120 élèves de plus qui ne viennent pas. **b)** Renommer et rendre le plat appétissant (« galette croustillante de pois chiches, sauce yaourt au cumin ») ; proposer des plats familiers (chili sin carne, lasagnes de légumes) ; associer les élèves à une commission menus et organiser une dégustation ; former l'équipe de cuisine. **c)** Taux de fréquentation le jour végétarien ; poids des restes du plat principal par élève ; note moyenne à une échelle hédonique.

4.3.13 Les troubles du comportement alimentaire : comprendre pour prévenir et orienter

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Des troubles fréquents et graves

Les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont des troubles psychiatriques (4.3.3) qui débutent le plus souvent à l'**adolescence** ou chez le **jeune adulte**, touchent davantage les femmes mais aussi les hommes, et ont des conséquences somatiques, psychiques et sociales importantes ; l'anorexie mentale a l'un des taux de mortalité les plus élevés des troubles psychiatriques.

Trouble	Prévalence vie entière (ordres de grandeur)	Source
Anorexie mentale	Environ 0,9 % des femmes et 0,3 % des hommes	Hudson et coll., 2007 (États-Unis) ; HAS, 2010
Boulimie	Environ 1,5 % des femmes et 0,5 % des hommes	Hudson et coll., 2007 ; HAS, 2019
Hyperphagie boulimique	Environ 3,5 % des femmes et 2 % des hommes	Hudson et coll., 2007 ; HAS, 2019

Attention – Prudence avec les chiffres

Les prévalences varient selon les pays, les définitions (DSM-IV ou DSM-5) et les méthodes ; les formes « non

spécifiées » sont plus fréquentes que les formes typiques, et de nombreuses personnes ne sont jamais diagnostiquées. Retenez l'ordre de grandeur : **plusieurs pour cent** de la population sont concernés au cours de la vie, dont une majorité de jeunes.

Facteurs de risque et facteurs de protection

Facteurs de risque	Facteurs de protection
Régimes restrictifs et restriction cognitive (chapitre 4)	Repas familiaux réguliers et conviviaux
Insatisfaction corporelle, idéal de minceur intériorisé	Estime de soi, image corporelle positive
Moqueries sur le poids, stigmatisation	Environnement non stigmatisant
Pratique de sports à catégorie de poids ou esthétiques	Compétences psychosociales (gestion des émotions, pensée critique)
Exposition intensive aux contenus « minceur » des réseaux sociaux	Littératie médiatique, esprit critique
Perfectionnisme, anxiété, événements de vie difficiles	Soutien social, écoute, accès aux soins

Le rôle du diététicien en santé publique

- **Prévention universelle** : messages centrés sur la santé, le plaisir et les sensations plutôt que sur le poids ; pas de régimes, pas d'aliments « interdits » ; promotion d'une image corporelle positive ; littératie critique des réseaux (chapitre 5).
- **Prévention ciblée** : actions dans les clubs sportifs, les écoles de danse, les lycées, auprès des entraîneurs et des enseignants (repérage des signes d'alerte).
- **Repérage et orientation** : face à des signes d'alerte (perte de poids rapide, restriction sévère, vomissements, crises), en parler en privé, avec bienveillance, et orienter vers le médecin traitant, l'infirmière scolaire ou une structure spécialisée (annuaire de la Fédération française anorexie boulimie, FFAB) ; les professionnels de santé disposent d'outils de repérage comme le questionnaire **SCOFF** (5 questions), qui ne sert pas au diagnostic et n'est pas destiné à être utilisé en atelier collectif.
- **Éviter les effets indésirables** : une action « contre l'obésité » mal conçue peut favoriser des TCA (pesées publiques, objectifs de perte de poids chez les adolescents).

Exemple – Une action de prévention dans un club de gymnastique

Le diététicien intervient auprès des entraîneurs (formation : besoins des jeunes sportives, signes d'alerte, conduite à tenir, vocabulaire à éviter sur le poids et la silhouette), puis auprès des gymnastes de 12 à 16 ans (atelier « manger pour performer et grandir » : collations, hydratation, plaisir), et auprès des parents (réunion). Il n'organise aucune pesée et oriente individuellement, en lien avec le médecin du club, les jeunes chez qui des signes d'alerte sont repérés.

Signes d'alerte et conduite à tenir

Le diététicien qui intervient en milieu scolaire, sportif ou associatif peut être le premier adulte à remarquer des signes d'alerte. Il ne pose pas de diagnostic, mais il sait **quoi observer** et **comment réagir**.

Type de signe	Exemples
Physiques	Perte de poids rapide ou cassure de la courbe de croissance chez l'enfant ; fatigue, malaises, sensation de froid ; arrêt des règles ; variations de poids importantes
Alimentaires	Restriction sévère, évitement de familles entières d'aliments, repas sautés de façon répétée ; crises de « boulimie » (grandes quantités, perte de contrôle) ; vomissements, prise de laxatifs

Type de signe	Exemples
Comportementaux	Activité physique excessive et compulsive ; isolement au moment des repas ; rituels (couper les aliments en petits morceaux, compter) ; pesées fréquentes
Psychologiques	Peur intense de grossir ; préoccupation constante pour le poids, la silhouette, les calories ; perception déformée du corps ; anxiété, tristesse

Méthode pas à pas – Réagir face à des signes d'alerte chez un jeune

1. Ne pas en parler devant le groupe ; choisir un moment calme et individuel.

2. Exprimer son inquiétude en décrivant des faits, sans juger ni parler de poids : « J'ai remarqué que tu ne déjeunais plus avec les autres, je m'inquiète pour toi. »

3. Écouter sans chercher à convaincre ; ne pas donner de conseils diététiques pour « corriger ».

4. Orienter : infirmière ou médecin scolaire, médecin traitant, structures spécialisées (annuaire de la Fédération française anorexie boulimie, FFAB) ; informer les parents pour un mineur, avec l'infirmière.

5. Transmettre l'information seulement aux professionnels concernés, dans le respect du secret partagé (chapitre 6, section 6.3.4).

À noter – Orthorexie et « bigorexie » : des mots à manier avec prudence

- L'**orthorexie** désigne une préoccupation excessive pour une alimentation « saine » ou « pure », avec des règles de plus en plus strictes, de l'anxiété et un retentissement social. Le terme a été proposé par le médecin américain Steven Bratman (1997) ; ce n'est **pas** un diagnostic du DSM-5.
- La **dysmorphie musculaire** (parfois appelée « bigorexie ») est une préoccupation excessive pour un corps jugé pas assez musclé, avec entraînement compulsif, régimes hyperprotéinés et parfois produits dopants ; elle concerne surtout les jeunes hommes. Le DSM-5 la classe parmi les troubles de l'image du corps (dysmorphophobie).
- Ces notions aident à repérer des comportements à risque chez des publics sportifs ou très attentifs à leur alimentation, sans coller d'étiquette.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.22

Dans un club d'athlétisme, l'entraîneur vous signale qu'une coureuse de 16 ans a perdu beaucoup de poids depuis la rentrée, qu'elle s'entraîne seule en plus des séances et qu'elle ne mange plus avec le groupe lors des déplacements. a) Classez les signes observés. b) Rédigez la phrase que l'entraîneur peut lui dire. c) Indiquez à qui l'orienter et ce que l'entraîneur ne doit pas faire.

Corrigé

a) Signe **physique** : perte de poids importante ; signe **comportemental** : activité physique en plus et isolement au moment des repas. **b)** « J'ai remarqué que tu t'entraînes beaucoup en plus et que tu ne manges plus avec nous ; je tiens à toi et je m'inquiète. Est-ce qu'on peut en parler ? » **c)** L'orienter vers le médecin du club ou son médecin traitant, et prévenir ses parents (elle est mineure) ; il ne doit pas la peser, commenter son poids devant le groupe, lui interdire l'entraînement sans avis médical ni lui donner un « plan alimentaire ».

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.12 et 4.3.13 – Durabilité et TCA

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre dimensions de l'alimentation durable.

2. Quelle quantité de viande rouge le régime de santé planétaire (EAT-Lancet, 2019) prévoit-il environ par

jour ?

3. Quels objectifs d'achats la loi EGalim fixe-t-elle à la restauration collective publique ?
4. Citez trois signes d'alerte d'un TCA.
5. Que fait le diététicien de santé publique face à ces signes ?
6. L'orthorexie est-elle un diagnostic du DSM-5 ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.12 et 4.3.13

1. Santé, environnement, économie, culture et société.
2. Environ 14 g par jour, soit environ 100 g par semaine.
3. Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en valeur d'achat (depuis le 1er janvier 2022).
4. Par exemple : perte de poids rapide, évitement de familles d'aliments, vomissements, activité physique compulsive, isolement au moment des repas, peur intense de grossir.
5. Il en parle en privé, sans juger ni parler de poids, et oriente vers le médecin ou une structure spécialisée ; il ne pose pas de diagnostic.
6. Non : c'est une notion proposée par Steven Bratman (1997), pas un diagnostic.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.14 Les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S2 §5 et §6 (p. 18 et 19)

Les personnes en situation de précarité ne « mangent pas mal par manque de connaissances » : elles développent des **stratégies** pour faire face à des contraintes fortes (budget, logement, équipement, temps, stress).

Stratégie	Exemples et conséquences
Réduire la qualité pour préserver la quantité	Aliments denses en énergie et bon marché (féculents raffinés, produits gras et sucrés) ; moins de fruits, légumes, poisson
Prioriser les enfants	Les parents (souvent les mères) sautent des repas pour que les enfants mangent
Faire durer	Achats au jour le jour, plats qui « tiennent au corps », recours aux promotions
Recourir à l'aide alimentaire	Épiceries solidaires, colis, restaurants sociaux ; choix limité, parfois honte
Préserver des moments de plaisir	Achat d'aliments « plaisir » pour les enfants : besoin de normalité et de dignité, à respecter

Lien diététique – Ce que cela change pour l'action

Une action en milieu précaire part de ces stratégies, reconnaît les **compétences** des personnes (savoir faire durer un budget est une compétence) et respecte le besoin de **plaisir** et de **normalité** ; elle combine les conseils pratiques avec l'**accès** (épiceries solidaires, chèques, jardins) et la **dignité** (choisir ses produits, participer). Le droit à une alimentation suffisante et choisie est d'ailleurs rappelé par la loi EGalim (2018), qui

a défini la **lutte contre la précarité alimentaire** dans le Code de l'action sociale et des familles.

Construire un budget alimentaire hebdomadaire

Le **budget** est l'un des déterminants les plus puissants des pratiques alimentaires (4.3.4). Pour une famille qui dispose de peu de moyens, le diététicien ne se contente pas de donner des repères : il aide à **construire un budget réaliste**, qui part des menus de la famille et des prix qu'elle paie réellement. Cette démarche valorise une compétence (faire durer un budget) et évite les conseils impossibles à suivre.

Définition – Coefficient budgétaire de l'alimentation

Le **coefficient budgétaire** de l'alimentation est la part des dépenses de consommation d'un ménage consacrée à l'alimentation. En France, il est passé d'environ 35 % en 1960 à environ **20 %** en 2014, restauration comprise (Insee Première n° 1568, 2015). En 2025, les seuls produits alimentaires et boissons non alcoolisées pèsent 12,5 % de la dépense de consommation des ménages (Insee, 29 mai 2026). Il est plus élevé dans les ménages modestes : plus le revenu est faible, plus l'alimentation pèse lourd, et plus elle sert de **variable d'ajustement** quand le loyer ou l'énergie augmentent.

Méthode pas à pas – Cinq étapes pour construire le budget avec la famille

1. Partir des menus de la semaine : la famille indique ce qu'elle mange habituellement ; on construit avec elle une semaine de menus simples, appréciés, qui respectent les repères (fruits et légumes, féculents complets de temps en temps, légumes secs, produits laitiers).

2. Établir la liste de courses à partir des menus, en quantités (kg, litres, pièces), en tenant compte de ce qui reste dans les placards.

3. Relever les prix que la famille paie réellement (ticket de caisse, drive, marché) : un budget construit sur des prix « de catalogue » ne sert à rien.

4. Calculer le total, le coût par personne et par jour, et la répartition par groupe d'aliments.

5. Ajuster ensemble : repérer les postes où l'on peut économiser sans perdre en qualité (légumes secs, surgelés nature, produits de saison, marques de distributeur), et ceux qu'il faut préserver (fruits et légumes, produits laitiers pour les enfants).

Calcul détaillé – Le budget d'une semaine pour une famille de quatre personnes (prix fictifs, octobre 2026)

Liste de courses : pâtes 2 kg (2,80 €) ; riz 1 kg (1,90 €) ; lentilles vertes 1 kg (2,60 €) ; pois chiches secs 500 g (1,60 €) ; farine 1 kg (0,95 €) ; 7 baguettes (7,70 €) ; lait 6 L (6,30 €) ; 16 yaourts nature (3,80 €) ; fromage (4,90 €) ; 12 œufs (3,40 €) ; filets de poulet 1 kg (8,70 €) ; 4 boîtes de sardines (4,20 €) ; légumes frais 5 kg (9,50 €) ; légumes surgelés nature (4,40 €) ; fruits 4 kg (8,80 €) ; huile 1 L (2,40 €) ; beurre 250 g (2,40 €) ; divers (épices, sel, sucre, café : 3,00 €).

- **Total** : 79,35 € pour la semaine.
- **Par personne et par jour** : 79,35 / (4 × 7) = 79,35 / 28 = **2,83 €**.
- **Fruits et légumes** : 9,50 + 4,40 + 8,80 = 22,70 €, soit 22,70 / 79,35 × 100 = **28,6 %** du budget.
- **Féculents et pain** : 2,80 + 1,90 + 0,95 + 7,70 = 13,35 €, soit **16,8 %**.
- **Viande, poisson, œufs et légumes secs** : 2,60 + 1,60 + 3,40 + 8,70 + 4,20 = 20,50 €, soit **25,8 %**.
- **Produits laitiers** : 6,30 + 3,80 + 4,90 = 15,00 €, soit **18,9 %** ; **matières grasses** : 4,80 €, soit **6,0 %** ; **divers** : 3,00 €, soit **3,8 %**.
- Vérification : 22,70 + 13,35 + 20,50 + 15,00 + 4,80 + 3,00 = **79,35 €** ✓ (la somme des pourcentages fait 99,9 % à cause des arrondis).
- **Par mois** : 79,35 × 52 / 12 = **343,85 €**.

Interprétation : avec moins de 3 € par personne et par jour, la famille peut manger varié, à condition de cuisiner les produits de base. Les fruits et légumes représentent plus du quart du budget : c'est un poste à **protéger**, en jouant sur la saison, le marché de fin de journée et les surgelés nature.

Comparer le prix des sources de protéines

Le prix au kilo est trompeur : un aliment bon marché peut contenir peu de protéines, et inversement. Pour comparer des sources de protéines, on calcule le **coût de 10 g de protéines**.

Calcul détaillé – Le coût de 10 g de protéines (Ciqual 2025, prix fictifs de la liste ci-dessus)

Formule : coût de 10 g de protéines = prix payé × 10 / quantité de protéines achetée (en g).

- **Lentilles vertes sèches** (25,1 g de protéines pour 100 g) : 1 000 g × 25,1 / 100 = 251 g de protéines ; 2,60 × 10 / 251 = **0,10 €**.
- **Pois chiches secs** (20,5 g pour 100 g) : 500 × 20,5 / 100 = 102,5 g ; 1,60 × 10 / 102,5 = **0,16 €**.
- **Filet de poulet cru** (23,4 g pour 100 g) : 1 000 × 23,4 / 100 = 234 g ; 8,70 × 10 / 234 = **0,37 €**.
- **Œufs** (12,8 g pour 100 g ; 12 œufs ≈ 600 g sans coquille) : 600 × 12,8 / 100 = 76,8 g ; 3,40 × 10 / 76,8 = **0,44 €**.
- **Sardines à l'huile égouttées** (23,3 g pour 100 g ; 4 boîtes de 95 g égouttés = 380 g) : 380 × 23,3 / 100 = 88,5 g ; 4,20 × 10 / 88,5 = **0,47 €**.

Interprétation : les légumes secs fournissent des protéines **trois à quatre fois moins chères** que le poulet, et apportent en plus des fibres et du fer. Les sardines, plus chères par gramme de protéines, gardent un intérêt pour leurs acides gras oméga-3 et leur vitamine D : le choix ne se fait pas sur le seul prix.

Attention – Ce que le budget ne dit pas

Un budget calculé ne tient compte ni du **temps** de préparation, ni de l'**équipement** (une famille hébergée à l'hôtel n'a souvent qu'une plaque ou un micro-ondes), ni de l'**énergie** (une cuisson de légumes secs de 45 minutes a un coût), ni des **goûts** des enfants. On vérifie toujours ces contraintes (4.3.4) avant de proposer une liste. Les prix d'un exemple sont **fictifs** ou datés : en atelier, on les remplace par ceux relevés avec les participants.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.23

Une mère seule avec deux enfants dispose de 60 € par semaine pour l'alimentation. a) Calculez le budget par personne et par jour. b) Elle achète chaque semaine 1,5 kg de steaks hachés à 9,80 €/kg (protéines : 18 g pour 100 g, valeur fictive arrondie). Calculez le coût de 10 g de protéines et comparez avec les lentilles du calcul ci-dessus. c) Proposez deux ajustements qui respectent les goûts de la famille.

Corrigé

a) 60 / (3 × 7) = 60 / 21 = **2,86 €** par personne et par jour. **b)** Coût : 1,5 × 9,80 = 14,70 € ; protéines : 1 500 × 18 / 100 = 270 g ; 14,70 × 10 / 270 = **0,54 €** pour 10 g, soit plus de cinq fois le coût des lentilles (0,10 €). Les steaks hachés représentent 14,70 / 60 × 100 = **24,5 %** du budget. **c)** Garder les steaks hachés deux fois par semaine (les enfants les aiment) et préparer un jour un hachis parmentier où la moitié de la viande est remplacée par des lentilles ; prévoir un plat d'œufs (omelette aux pommes de terre) ; utiliser l'économie pour acheter des fruits de saison pour les goûters.

Précarité, pauvreté et aide alimentaire : les repères

Définition – Précarité (Joseph Wresinski, 1987)

Selon le rapport du fondateur d'ATD Quart Monde au Conseil économique et social (publié au *Journal officiel* en 1987), la précarité est « l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux ». Quand elle touche plusieurs domaines et dure, elle conduit à la **grande pauvreté**.

La pauvreté a plusieurs visages : **monétaire** (niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian : 1 337 € par mois en 2024, voir le chapitre 3), **en conditions de vie** (retards de paiement, restrictions, logement difficile), mais aussi manque de **capacités** (savoirs, langue, réseau), fragilité **familiale** (familles monoparentales ou nombreuses) et renoncement aux **soins**.

- **Aide alimentaire** : le programme européen d'aide aux plus démunis (PEAD) est créé en **1987** pour distribuer les surplus agricoles ; il est remplacé par le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD, 2014-2020), puis intégré au **Fonds social européen plus** (FSE+, 2021-2027). En France, elle passe par des associations comme les **Restos du Cœur** (créés en 1985), le Secours populaire, la Croix-Rouge et les banques alimentaires. Depuis 2018 (loi EGalim), le Code de l'action sociale et des familles parle de **lutte contre la précarité alimentaire**, qui vise aussi la dignité et le choix ; le programme « **Mieux manger pour tous** » finance depuis 2023 des produits frais et de qualité.
- **Pauvreté et obésité** : l'obésité est plus fréquente dans les milieux modestes. Les causes sont multiples : prix (les calories des aliments gras et sucrés coûtent moins cher), manque d'équipement ou de temps pour cuisiner, stress, offre du quartier, moins d'activité physique encadrée. Il ne s'agit pas d'un « choix » ou d'une « culture du plaisir » propre à ces familles : on parle d'**inégalités sociales de santé**.

4.3.15 Les pratiques alimentaires religieuses en détail

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Connaître les principales règles alimentaires religieuses permet de **respecter** les participants et d'**adapter** recettes et menus, sans jamais supposer qu'une personne pratique du fait de son origine : on **demande** (fiche-outil O4.1).

Religion	Règles alimentaires principales	Conséquences pratiques
Islam	Interdiction du porc et de ses dérivés (gélatine de porc, saindoux), de l'alcool (y compris en cuisine) ; viande halal (abattage rituel) pour les pratiquants ; jeûne du Ramadan (de l'aube au coucher du soleil, pendant un mois lunaire)	Recettes sans porc ni alcool ; vérifier les étiquettes (gélatine, arômes) ; viande halal ou plat végétarien ; adaptation des horaires pendant le Ramadan (repas de rupture équilibré, hydratation)
Judaïsme	Règles de la cacheroute : animaux autorisés (ruminants aux sabots fendus, poissons à nageoires et écailles), interdiction du porc et des fruits de mer, abattage rituel, séparation du lait et de la viande (ustensiles distincts) ; jeûnes (Kippour) ; Pâque (pas de pain levé)	Plats végétariens ou poissons autorisés ; ne pas mélanger viande et produits laitiers ; en collectivité, repas casher fournis par des prestataires agréés
Christianisme	Selon les traditions : abstinence de viande le vendredi (surtout pendant le Carême chez les catholiques pratiquants) ; jeûnes plus nombreux chez les orthodoxes (périodes sans produits animaux)	Proposer du poisson ou un plat végétarien le vendredi si demandé ; adapter pendant les jeûnes orthodoxes
Hindouisme	Respect de la vache (pas de bœuf) ; végétarisme fréquent ; parfois exclusion des œufs, de l'ail et de l'oignon selon les courants	Plats végétariens ; vérifier les ingrédients
Bouddhisme	Végétarisme fréquent mais non obligatoire selon les écoles	Proposer une option végétarienne

Religion	Règles alimentaires principales	Conséquences pratiques
Sikhisme, jaïnisme	Viande abattue rituellement interdite chez les sikhs ; végétarisme strict, parfois sans légumes-racines, chez les jaïns	S'informer auprès des personnes

Attention – Laïcité et restauration collective

En France, la **laïcité** n'oblige pas la restauration collective publique à proposer des menus confessionnels, mais rien ne l'interdit ; de nombreuses collectivités proposent un **plat de substitution** les jours où du porc est servi, ou une option **végétarienne** quotidienne, qui convient au plus grand nombre. Pour un atelier, la solution la plus simple et la plus inclusive est souvent une recette **végétarienne ou à base de poisson ou de volaille**, sans alcool ni porc, présentée sans référence religieuse.

Anticiper le calendrier des fêtes et des jeûnes

Une action d'éducation ou un menu de restauration collective se planifient des mois à l'avance (voir aussi la méthode « Préparer un atelier interculturel respectueux » au chapitre 3). Consulter un **calendrier des fêtes religieuses** de l'année évite de programmer un atelier cuisine en plein jeûne, ou un repas à thème le jour d'une fête importante pour une partie des convives.

Fête ou période	Tradition	Pratiques alimentaires associées	Conséquence pour l'organisation
Ramadan, puis Aïd el-Fitr	Islam	Jeûne de l'aube au coucher du soleil pendant un mois ; rupture du jeûne (dattes, eau, soupe) ; pâtisseries à l'Aïd	Pas d'atelier dégustation en journée ; ateliers possibles en soirée autour de la rupture du jeûne
Aïd el-Kébir (Aïd al-Adha)	Islam	Sacrifice d'un mouton, repas familiaux	Absences possibles ; ne pas fixer d'évaluation ce jour-là
Carême, puis Pâques	Christianisme	Abstinence de viande certains jours, parfois jeûne ; repas festif à Pâques	Proposer poisson ou plat végétarien le vendredi si demandé
Pessah (Pâque juive)	Judaïsme	Pain azyme (matsa), aucun produit levé pendant huit jours	Prévoir une alternative au pain et aux féculents levés
Yom Kippour	Judaïsme	Jeûne complet d'environ 25 heures	Pas de repas collectif ce jour-là pour les personnes concernées
Diwali	Hindouisme, sikhisme, jaïnisme	Confiseries et plats festifs, souvent végétariens	Occasion de découvrir des recettes, en respectant les interdits
Nouvel An lunaire	Chine, Vietnam, Corée	Repas familiaux, raviolis, gâteaux de riz	Thème possible d'atelier interculturel

Calcul détaillé – Pourquoi la date du Ramadan avance chaque année

Le calendrier musulman est **lunaire** : douze mois lunaires durent environ **354,4 jours**, contre **365,25 jours** pour l'année solaire.

- Décalage annuel : 365,25 − 354,4 = **10,9 jours** environ ; le Ramadan commence donc environ **11 jours plus tôt** chaque année.
- Retour à la même saison : 365,25 / 10,9 ≈ **33,5 ans**.
- Exemple : le Ramadan a commencé vers le 18 février 2026 ; on peut prévoir un début vers le **7 ou 8 février 2027**, puis vers la fin janvier 2028. En 2030, il commencera **deux fois** dans la même année civile (début janvier et fin décembre).

Interprétation : la date exacte dépend de l'observation de la lune et n'est confirmée que quelques jours avant ; pour planifier, on retient une fourchette de plus ou moins deux jours. La durée du jeûne dépend de la saison : environ 12 à 13 heures en février en France métropolitaine, mais 17 à 19 heures lorsque le Ramadan

tombait en juin (années 2015 à 2018).

Méthode pas à pas – Conseiller une personne qui jeûne pendant le Ramadan

1. Ne pas juger le choix de jeûner : on part de la pratique de la personne et on cherche à la rendre la plus sûre possible.

2. Repérer les situations à risque : diabète (surtout traité par insuline ou sulfamides), maladie rénale, grossesse et allaitement, personne âgée fragile, enfant, sportif à fort entraînement. Le jeûne n'est pas une obligation religieuse pour les personnes malades ; la décision se prend avec le **médecin**, et les recommandations internationales (IDF-DAR, 2021) classent le risque des personnes diabétiques.

3. Structurer les prises de la nuit : une rupture du jeûne légère (eau, dattes, soupe), un vrai repas, une collation en soirée et un repas avant l'aube (**shour**) qu'il ne faut pas sauter.

4. Penser à l'hydratation : boire régulièrement entre le coucher et le lever du soleil, plutôt qu'une grande quantité d'un coup ; limiter le café et le thé très sucré.

5. Limiter les excès : fritures et pâtisseries très sucrées de la rupture du jeûne, repas trop copieux et tardif qui gêne le sommeil.

Calcul détaillé – Répartir 2 400 kcal sur la nuit pour un lycéen qui jeûne (repères indicatifs)

Répartition proposée : rupture du jeûne 15 %, repas du soir 40 %, collation de soirée 10 %, shour 35 %.

- Rupture du jeûne : 2 400 × 15 / 100 = **360 kcal** (un grand verre d'eau, 3 dattes, un bol de chorba aux lentilles).
- Repas du soir : 2 400 × 40 / 100 = **960 kcal** (plat complet avec légumes, féculent et viande ou légumineuses, pain, fruit).
- Collation de soirée : 2 400 × 10 / 100 = **240 kcal** (yaourt, fruit, quelques amandes).
- Shour : 2 400 × 35 / 100 = **840 kcal** (pain complet, fromage ou œufs, flocons d'avoine au lait, fruit, eau).
- Vérification : 360 + 960 + 240 + 840 = **2 400 kcal** ✓.
- Hydratation : pour boire 1,5 L entre 18 h et 6 h, il faut environ 1 500 / 250 = **6 verres** de 250 mL, soit un verre toutes les deux heures de veille.

Interprétation : le shour, riche en féculents complets, en protéines et en eau, aide à tenir la journée ; le sauter oblige à un jeûne plus long et favorise la fatigue, les maux de tête et la baisse d'attention en cours.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.24

Une association de quartier prévoit un cycle de six ateliers cuisine le mercredi à 14 h, du 27 janvier au 3 mars 2027, avec dégustation. La moitié des participantes pratiquent le Ramadan. a) Que risque-t-il de se passer ? b) Proposez deux solutions. c) Pourquoi faut-il vérifier la date exacte quelques jours avant ?

Corrigé

a) Le Ramadan devrait commencer vers le 7 ou 8 février 2027 : quatre ateliers sur six tomberaient en période de jeûne ; les participantes concernées ne pourraient pas goûter, se sentiraient exclues ou ne viendraient pas. **b)** Décaler le cycle (par exemple après l'Aïd el-Fitr, vers mi-mars 2027) ; ou garder la période mais placer les ateliers en fin d'après-midi, avec des recettes « à emporter » pour la rupture du jeûne, et un atelier sur le thème « un Ramadan équilibré » construit avec les participantes. **c)** Le début du mois dépend de l'observation de la lune : la date annoncée à l'avance peut varier d'un jour ou deux.

4.3.16 La dégustation et l'analyse sensorielle au service de l'éducation

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Le goût est un apprentissage (4.4.1) ; l'**analyse sensorielle** fournit des méthodes simples pour faire découvrir les aliments, développer le vocabulaire et évaluer l'acceptation d'une recette (lien avec la compétence C3.2 et la fiche F9).

Méthode	Principe	Usage en atelier
Épreuve descriptive	Décrire l'aspect, l'odeur, la texture, les saveurs (sucré, salé, acide, amer, umami) et les arômes	Éducation sensorielle, vocabulaire, plaisir
Échelle hédonique	Noter son appréciation (de 1 « je n'aime pas du tout » à 5 « j'aime beaucoup », ou smileys)	Évaluer l'acceptation d'une recette
Test triangulaire	Trois échantillons dont deux identiques : trouver l'intrus	Montrer qu'on ne perçoit pas toujours une réduction de sel ou de sucre
Classement	Classer des échantillons (du moins au plus sucré)	Prendre conscience des teneurs (yaourts, jus)

Exemple – Calcul détaillé : acceptation d'une recette de légumineuses (échelle hédonique en 5 points)

Vingt participants goûtent un houmous de pois chiches maison. Notes : 5 (×6), 4 (×7), 3 (×4), 2 (×2), 1 (×1).

- Vérification : 6 + 7 + 4 + 2 + 1 = **20** . ✓
- Somme des notes : 5 × 6 + 4 × 7 + 3 × 4 + 2 × 2 + 1 × 1 = 30 + 28 + 12 + 4 + 1 = **75** ; moyenne : 75 / 20 = **3,75 / 5**.
- **Taux d'acceptation** (notes 4 et 5) : (6 + 7) / 20 × 100 = **65 %** ; rejet (notes 1 et 2) : 3 / 20 = **15 %**.
- Médiane (valeurs classées : 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5) : moyenne des 10e et 11e valeurs = (4 + 4) / 2 = **4**.

Interprétation : recette bien acceptée ; on peut l'intégrer au livret ; les remarques des personnes ayant mis 1 ou 2 (« trop d'ail », « texture pâteuse ») servent à l'ajuster.

Exemple – Calcul détaillé : un test triangulaire sur la réduction du sel

Pour montrer qu'une soupe moins salée reste appréciée, on présente à 24 participants trois verrines, dont deux identiques (soupe habituelle) et une avec 30 % de sel en moins. Par hasard, la probabilité de trouver l'intrus est de 1 sur 3 : sur 24 personnes, on attend donc 24 / 3 = **8** bonnes réponses dues au seul hasard. Résultat : **10** personnes trouvent l'intrus, soit 10 / 24 × 100 = **41,7 %**, à peine plus que le hasard (33,3 %). Pour conclure à une différence perçue avec 24 participants, il faudrait au moins **13** bonnes réponses (seuil des tables de l'analyse sensorielle, norme ISO 4120, risque de 5 %). **Conclusion** : la réduction de 30 % du sel n'est pas perçue par la majorité : un argument concret pour cuisiner moins salé.

4.3.17 Repères sur quelques cultures culinaires

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Connaître les grandes lignes de quelques cultures culinaires présentes en France aide à **valoriser** les savoir-faire des participants et à construire l'équilibre **à partir** de leurs plats (chapitre 3, interculturalité). Ces repères sont des **tendances générales** : chaque famille a ses propres pratiques, qu'on découvre en l'écoutant.

Cuisine	Aliments et plats de base	Atouts nutritionnels	Points de vigilance et adaptations
Maghreb	Semoule, pain, légumes (couscous, tajines), pois chiches, lentilles (chorba, harira), épices, huile d'olive	Légumes et légumineuses très présents, épices permettant de saler moins	Pâtisseries très sucrées lors des fêtes, thé très sucré, fritures ; garder la richesse en légumes et légumineuses
Afrique de l'Ouest	Riz, mil, manioc, igname, plantain ; sauces (arachide, tomate, feuilles), poisson, gombo	Légumes-feuilles, poisson, plats complets	Sauces riches en huile, cubes de bouillon salés, boissons sucrées ; réduire les cubes, mesurer l'huile, garder les légumes-feuilles
Turquie	Boulgour, pain, yaourt, légumes farcis, lentilles (mercimek), huile d'olive	Produits laitiers fermentés, légumes, céréales	Pâtisseries au sirop, pain blanc en grande quantité
Asie du Sud (Inde, Sri Lanka, Pakistan)	Riz, galettes (chapati), lentilles (dal), légumes au curry, yaourt, épices	Végétarisme fréquent, légumineuses quotidiennes	Ghee et fritures, desserts sucrés ; risque de diabète élevé dans ces populations : vigilance sur les quantités de riz blanc
Asie de l'Est et du Sud- Est	Riz, nouilles, légumes sautés, soja (tofu), poisson, bouillons	Peu de produits laitiers mais beaucoup de légumes, tofu	Sauces très salées (soja, poisson), apports en calcium à surveiller
Antilles, Guyane, Réunion	Riz, légumineuses (pois rouges, lentilles), racines (igname, dachine), poisson, fruits tropicaux, cari	Légumineuses et fruits	Boissons sucrées et sirops, fritures (accras), sel ; prévalence élevée du diabète et de l'obésité en outre-mer
Europe de l'Est	Pommes de terre, chou, betterave, céréales (sarrasin), produits laitiers fermentés, charcuteries	Légumes de garde, fermentés	Charcuteries et sel ; garder les soupes de légumes

Exemple – Adapter un plat traditionnel sans le dénaturer : le mafé

Recette familiale pour 6 : 1 kg de bœuf, 250 g de pâte d'arachide, 2 cubes de bouillon, 10 cL d'huile, 500 g de légumes, 600 g de riz blanc (cru). Propositions construites **avec** la participante : 600 g de viande et 400 g de pois chiches (cuits) au lieu de 1 kg de viande ; 1 cube au lieu de 2 (épices et oignon pour le goût) ; 4 cL d'huile (la pâte d'arachide apporte déjà des lipides) ; 900 g de légumes (carottes, chou, patate douce) ; riz en partie complet.

- **Sel** : un cube de bouillon contient environ 4 à 5 g de sel (selon les marques, à lire sur l'étiquette) ; passer de 2 à 1 cube réduit d'environ 4,5 g le sel du plat, soit 4,5 / 6 = **0,75 g** par portion.
- **Huile** : de 10 à 4 cL = 6 cL en moins ≈ 54 g d'huile (densité ≈ 0,9) ≈ 54 × 9 = **486 kcal** en moins pour le plat, soit 486 / 6 = **81 kcal** par portion.
- **Légumes** : de 500 à 900 g, soit de 83 à **150 g** par portion.

Principe : on garde le **nom**, le **goût** et la **fonction sociale** du plat (repas de fête, transmission) ; on ajuste les quantités, sans « interdire » ; la participante reste maîtresse de sa recette.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.14 à 4.3.17 – Précarité, religions, dégustation, cultures

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité.
2. Que fait-on avant d'adapter une recette aux pratiques religieuses d'un groupe ?
3. La laïcité oblige-t-elle une cantine publique à proposer des menus confessionnels ?
4. Comment calcule-t-on le taux d'acceptation d'une recette avec une échelle hédonique ?
5. Dans un test triangulaire, quelle est la probabilité de trouver l'intrus par hasard ?
6. Citez deux principes pour adapter un plat traditionnel sans le dénaturer.

Corrigé – Point d'étape 4.3.14 à 4.3.17

1. Réduire la qualité pour préserver la quantité ; prioriser les enfants ; faire durer ; recourir à l'aide alimentaire ; préserver des moments de plaisir.
2. On demande aux participants ce qu'ils mangent et ne mangent pas (fiche O4.1), sans supposer une pratique à partir de l'origine.
3. Non, mais elle ne l'interdit pas ; beaucoup de collectivités proposent un plat de substitution ou une option végétarienne.
4. Nombre de notes 4 et 5 divisé par le nombre de participants, multiplié par 100.
5. Une chance sur trois (33,3 %).
6. Garder le nom, le goût et la fonction sociale du plat ; ajuster les quantités (huile, sel, viande, légumes) avec la personne, sans interdire.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.18 Fil rouge : les pratiques alimentaires des familles des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a pris en compte

- **Rôles de l'acte alimentaire** : pour les familles, le repas est d'abord un moment de **générosité** et de **plaisir** partagé ; Inès a donc choisi des plats copieux et conviviaux (parmentier, crumble) plutôt que des « petites portions diététiques ».
- **Pratiques religieuses** : 7 familles sur 12 mangent halal ; les recettes des ateliers sont **sans porc** et sans alcool, la viande éventuelle est achetée halal ; l'atelier 5 a été placé hors période de Ramadan, et une fiche « Ramadan équilibré » a été demandée par les familles pour l'année suivante.
- **Régulation** : lors de l'atelier goûters, les parents ont découvert l'**échelle de la faim** pour aider les enfants à distinguer faim et envie.
- **Syncrétisme** : les recettes du monde (tiep, chorba, dal) ont été adaptées avec des légumes de saison achetés au marché.
- **Évolutions** : plusieurs familles utilisent des plateformes de livraison le week-end ; Inès a proposé des recettes « aussi rapides qu'une livraison » (moins de 20 minutes).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : rythmes, enfants et durabilité aux Tilleuls

- **Rythmes** : au questionnaire, 21 parents sur 48 (43,8 %) déclarent que leurs enfants ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 2 jours par semaine d'école ; le goûter est souvent pris devant un écran. L'atelier 4 « goûters et boissons » a intégré un temps sur le **petit-déjeuner rapide** (bol de lait, pain, fruit : 0,55 € par enfant).
- **Partage des responsabilités** : lors de l'atelier parents-enfants, Inès a présenté le modèle de Satter ; plusieurs parents ont témoigné d'un soulagement (« Je n'ai plus à me battre pour qu'il finisse »).
- **Exposition répétée** : le centre de loisirs du centre social a proposé une fois par semaine, pendant 8 semaines, un légume « découverte » au goûter (carotte, chou-fleur, radis) : 9 enfants sur 25 goûtaient la 1re semaine (36 %), 18 sur 25 la 8e (72 %).
- **Durabilité** : l'atelier « repas complet petit budget » a comparé le parmentier de lentilles (0,68 € la portion,

environ 0,04 kg CO2e pour 40 g de lentilles) à un hachis parmentier au bœuf (environ 1,20 € la portion, environ 2 kg CO2e pour 75 g de bœuf, ordre de grandeur) : le message « bon pour la santé, le porte-monnaie et la planète » a été retenu par le groupe comme slogan du livret.

4.3.19 Six cas guidés pour s'entraîner à l'analyse d'un comportement alimentaire

Module · Référentiel et guide : voir 4.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Ces six cas reprennent les notions du chapitre dans l'ordre attendu par le jury : décrire la situation avec des chiffres, l'expliquer avec les notions du cours, puis proposer une action argumentée qui respecte le public. Essayez de répondre avant de lire chaque corrigé.

Cas guidé 1 – « Manger sans culpabilité » dans une association de quartier (données fictives)

Une association de quartier propose un groupe de parole à des femmes de 30 à 60 ans. L'animatrice sollicite un diététicien car les échanges tournent souvent autour des régimes. Un questionnaire anonyme est rempli par les **18 participantes**.

- « J'ai déjà fait au moins trois régimes » : 12 ; « je me sens coupable après avoir mangé certains aliments » : 11 ; « après un écart, je saute le repas suivant » : 8 ; « je mange quand je suis fatiguée ou contrariée » : 14.
- Verbatims : « Le pain, je n'y touche plus, et puis un soir je mange toute la baguette. » ; « Depuis trente ans, je suis au régime, et j'ai pris 15 kilos. » ; « Le soir, quand les enfants sont couchés, c'est mon moment, avec le chocolat. »

Questions – Cas guidé 1

1. Calculez le pourcentage de participantes concernées par chaque réponse.

2. Analysez la situation avec le cercle de la restriction cognitive et les styles alimentaires.

3. Proposez le déroulement d'une séance de 1 h 30 qui ne parle pas de poids.

4. Indiquez les précautions à prendre et les signes qui justifieraient une orientation.

Corrigé – Cas guidé 1

1. Au moins trois régimes : 12 / 18 = **66,7 %** ; culpabilité : 11 / 18 = **61,1 %** ; repas sauté après un écart : 8 / 18 = **44,4 %** ; manger sous l'effet de la fatigue ou de la contrariété : 14 / 18 = **77,8 %**.

2. Les deux tiers des participantes ont une longue histoire de régimes : c'est le terrain de la **restriction cognitive** (Herman et Polivy, 1975). Les verbatims montrent le cycle complet : interdit (le pain), **désinhibition** (« toute la baguette »), **culpabilité** (61,1 %), compensation (44,4 % sautent un repas), puis reprise de poids (« 15 kilos en trente ans de régime »). Le style **émotionnel** est aussi très présent (77,8 %) : le chocolat du soir est un moment de récompense et de détente, à respecter.

3. Accueil et règles du groupe (bienveillance, confidentialité) : 10 min. Photolangage « ce que manger représente pour moi » : 20 min. Présentation du cercle de la restriction à partir de leurs propres phrases, sans jugement : 15 min. Dégustation en pleine conscience d'un carré de chocolat et d'un morceau de pain, avec l'échelle de la faim et de la satiété : 25 min. Échange : « que pourrais-je essayer cette semaine ? » (un seul petit pas, choisi par chacune) : 15 min. Clôture : 5 min.

4. Ne pas peser, ne pas parler de poids ni de calories, ne pas présenter d'aliment « interdit » ; respecter le rythme de chacune ; ne pas faire de la dégustation une nouvelle règle. Orienter individuellement, en lien avec le médecin traitant, une participante qui décrit des crises fréquentes avec perte de contrôle, des vomissements, une détresse importante ou une perte de poids rapide (signes possibles de TCA).

Cas guidé 2 – Le goûter de l'accueil périscolaire (données fictives)

Un accueil périscolaire reçoit 28 enfants de 6 à 10 ans quatre soirs par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi), 36 semaines par an. Le goûter est fourni par la commune pour 0,45 € par enfant. Une stagiaire a observé **12 goûters** avec une grille.

- Enfants assis : 5 goûters ; un adulte assis avec les enfants : 2 ; eau proposée : 4 ; goûter composé uniquement de biscuits industriels : 9. Durée moyenne : 8 minutes.
- Les animateurs disent : « On n'a pas le temps, il faut lancer les activités. » ; « Les enfants préfèrent les biscuits, au moins ils mangent. »

Questions – Cas guidé 2

1. Calculez le pourcentage de goûters pour chaque élément observé et le budget annuel du goûter.

2. Analysez la situation avec les rythmes alimentaires et le partage des responsabilités.

3. Proposez un goûter type au même coût et deux changements d'organisation.

4. Proposez deux indicateurs pour évaluer le changement.

Corrigé – Cas guidé 2

1. Enfants assis : 5 / 12 = **41,7 %** ; adulte assis : 2 / 12 = **16,7 %** ; eau proposée : 4 / 12 = **33,3 %** ; biscuits seuls : 9 / 12 = **75,0 %**. Budget annuel : 36 semaines × 4 soirs = 144 soirs ; 28 × 0,45 × 144 = **1 814,40 €**.

2. Le goûter est une vraie prise chez l'enfant (10 à 15 % de l'énergie de la journée) qui comble le long écart entre le déjeuner et le dîner ; pris debout en 8 minutes, composé de biscuits seuls, il ressemble à du **grignotage** plutôt qu'à un repas : peu rassasiant, il prépare le grignotage de fin de journée. Le **partage des responsabilités** n'est pas respecté côté adulte : le « quoi » (offre variée), le « où » (assis) et l'ambiance (adulte présent) relèvent des animateurs. L'argument « au moins ils mangent » confond quantité et qualité.

3. Goûter type : 40 g de pain (0,18 €), 10 g de chocolat noir (0,08 €) et une demi-pomme ou une clémentine (0,18 €), avec de l'eau : **0,44 €**, dans le budget de 0,45 €. On peut alterner avec un produit laitier (yaourt, fromage) et un fruit. Organisation : un goûter assis de 20 minutes avec un animateur par table qui goûte avec les enfants ; les enfants distribuent et rangent à tour de rôle (participation).

4. Part des goûters où les enfants sont assis et où un adulte goûte avec eux (même grille, 12 goûters observés au trimestre suivant) ; part des goûters composés d'au moins deux groupes d'aliments dont un fruit ou un produit laitier (relevé des achats).

Cas guidé 3 – Le restaurant d'un établissement et service d'aide par le travail (données fictives)

Un ESAT emploie **60 travailleurs** en situation de handicap (handicap intellectuel ou psychique pour la plupart), qui déjeunent au self de l'établissement. La directrice s'inquiète de la prise de poids de plusieurs travailleurs depuis l'arrivée d'un traitement médicamenteux, de grignotages pendant les pauses et de repas pris très vite. Un questionnaire en version « facile à lire et à comprendre » (FALC) a été rempli avec l'aide des moniteurs.

- « Je finis toujours mon assiette » : 27 ; « je mange en moins de 10 minutes » : 21 ; « je m'achète des gâteaux ou des chips pour les pauses » : 33 ; « je fais mes courses seul » : 18 ; « j'aimerais apprendre à cuisiner » : 41.
- Un moniteur : « Certains prennent trois desserts, ils ne savent pas s'arrêter. » Une infirmière : « Plusieurs traitements augmentent l'appétit. »

Questions – Cas guidé 3

1. Calculez le pourcentage de travailleurs concernés par chaque réponse.

2. Identifiez les déterminants du comportement alimentaire de ce public, en citant au moins quatre familles.

3. Proposez trois actions adaptées (environnement du self, compétences, pauses).

4. Indiquez deux précautions éthiques et l'adaptation des supports de communication.

Corrigé – Cas guidé 3

1. Finir son assiette : 27 / 60 = **45,0 %** ; manger en moins de 10 minutes : 21 / 60 = **35,0 %** ; achats de gâteaux ou de chips pour les pauses : 33 / 60 = **55,0 %** ; courses seul : 18 / 60 = **30,0 %** ; souhait d'apprendre à cuisiner : 41 / 60 = **68,3 %**.

2. Biologiques : traitements qui augmentent l'appétit (avis de l'infirmière). **Cognitifs** : difficulté à repérer la satiété ou à anticiper, besoin de supports adaptés (FALC). **Environnementaux** : self en libre-service avec plusieurs desserts accessibles, distributeur ou commerce proche pour les pauses, repas pris très vite (35,0 %). **Sociaux** : habitude de « finir l'assiette » (45,0 %), normes du groupe. **Psychologiques** : plaisir et récompense dans une journée de travail, ennui pendant les pauses. **Économiques** : petit budget, achats d'aliments bon marché et denses en énergie.

3. Self : un seul dessert sur le plateau, fruit en libre accès, portions adaptées avec possibilité de se resservir en légumes ; une durée de repas d'au moins 30 minutes, avec des moniteurs qui mangent à table. Compétences : un atelier cuisine mensuel avec recettes en images, en lien avec l'autonomie (68,3 % le souhaitent), et une sortie « courses » accompagnée. Pauses : une collation proposée par l'ESAT (fruit, pain, laitage) et une fontaine à eau, plutôt que des achats non prévus.

4. Ne jamais stigmatiser le poids ni faire de pesée collective ; respecter les choix et l'autonomie des travailleurs, qui sont des adultes ; travailler avec l'équipe médicale pour les effets des traitements, sans donner de conseils individuels de régime. Supports : FALC (phrases courtes, pictogrammes, photos des aliments et des portions), consignes testées avec quelques travailleurs, participation des travailleurs à la conception.

Cas guidé 4 – Les internes d'un lycée agricole (données fictives)

L'infirmière d'un lycée agricole signale des malaises en cours le matin. Un questionnaire est rempli par les **96 internes** de 15 à 18 ans.

- « Je saute le petit-déjeuner au moins trois jours par semaine » : 38 ; « je me couche après minuit au moins trois soirs par semaine » : 41 ; « je grignote dans ma chambre le soir (gâteaux, chips, sodas) » : 57 ; « je n'aime pas ce qui est servi au self le soir » : 22.
- Le petit-déjeuner est servi de 6 h 45 à 7 h 15 ; les cours commencent à 8 h ; les jeunes achètent leurs provisions le dimanche soir avant de rentrer à l'internat.
- Verbatims : « À 6 h 45, je n'ai pas faim. » ; « Le soir, on se retrouve dans une chambre avec des gâteaux, c'est notre moment. »

Questions – Cas guidé 4

1. Calculez le pourcentage d'internes concernés par chaque réponse.

2. Analysez la situation avec les rythmes alimentaires, la régulation et les déterminants.

3. Proposez trois actions complémentaires, dont au moins une qui agit sur l'environnement.

4. Proposez deux indicateurs d'évaluation.

Corrigé – Cas guidé 4

1. Petit-déjeuner sauté : 38 / 96 = **39,6 %** ; coucher après minuit : 41 / 96 = **42,7 %** ; grignotage le soir : 57 / 96 = **59,4 %** ; repas du soir peu apprécié : 22 / 96 = **22,9 %**.

2. Un enchaînement classique des **rythmes** (4.3.8) : repas du soir peu mangé, **grignotage** tardif dans la chambre, coucher tardif et **manque de sommeil** (qui augmente la faim et l'envie d'aliments sucrés), absence de faim à 6 h 45, petit-déjeuner sauté, puis malaises et baisse d'attention en matinée. Les **déterminants** sont surtout environnementaux et sociaux : horaires de l'internat, offre du self le soir, provisions achetées le dimanche, et un rôle **social** fort du grignotage (« notre moment »), qu'il faut respecter.

3. Environnement : ouvrir le petit-déjeuner jusqu'à 7 h 40 ou proposer un petit-déjeuner « à emporter » (pain, fromage, fruit) à prendre avant 10 h ; associer les internes à la commission menus du soir. Éducation : un atelier « soirée entre internes » où ils préparent des collations conviviales et moins coûteuses (popcorn maison, compotes, fruits, pain d'épices). Partenariat : intervention de l'infirmière sur le sommeil et les écrans, sans discours moralisateur.

4. Part des internes qui prennent quelque chose avant 10 h (questionnaire avant et après) ; nombre de passages à l'infirmerie pour malaise le matin ; fréquentation du self le soir.

Cas guidé 5 – Les achats d'une épicerie solidaire (données fictives)

Une épicerie solidaire accueille **25 foyers** ; ils paient 10 à 30 % du prix habituel des produits. La responsable a analysé un mois d'achats : total **1 640 €** (prix payés). Répartition : fruits et légumes 197 € ; féculents 262 € ; viande, poisson, œufs et légumes secs 328 € ; produits laitiers 230 € ; produits sucrés et boissons sucrées 394 € ; matières grasses 82 € ; hygiène et divers 147 €.

- Les fruits et légumes frais arrivent irrégulièrement et s'abîment vite ; plusieurs familles sont hébergées à l'hôtel, avec une seule plaque électrique.
- Verbatims : « Les gâteaux, ça fait plaisir aux enfants, on ne peut pas tout leur refuser. » ; « Les lentilles, je ne sais pas les cuisiner. »

Questions – Cas guidé 5

1. Vérifiez le total, puis calculez la part de chaque poste et la dépense moyenne par foyer et par mois.

2. Comparez la part des fruits et légumes avec celle du budget de la famille présenté en 4.3.14 (28,6 %) et expliquez l'écart.

3. Proposez deux actions qui respectent la dignité des familles.

Corrigé – Cas guidé 5

1. Total : 197 + 262 + 328 + 230 + 394 + 82 + 147 = **1 640 €** ✓. Parts : fruits et légumes 197 / 1 640 × 100 = **12,0 %** ; féculents **16,0 %** ; viande, poisson, œufs et légumes secs **20,0 %** ; produits laitiers **14,0 %** ; produits sucrés et boissons sucrées **24,0 %** ; matières grasses **5,0 %** ; hygiène et divers **9,0 %**. Dépense moyenne : 1 640 / 25 = **65,60 €** par foyer et par mois.

2. Les fruits et légumes représentent 12,0 % des achats, contre 28,6 % dans le budget construit avec une famille, soit moins de la moitié. Explications : **offre** irrégulière et périssable (déterminant environnemental), **équipement** limité (une plaque, pas de four ni de réfrigérateur à l'hôtel), manque de **savoir-faire** (« je ne sais pas les cuisiner »), et rôle **affectif** des produits sucrés : faire plaisir aux enfants malgré la précarité (4.3.14). Ce n'est pas un manque de connaissances.

3. Un atelier « cuisine à une seule plaque » avec des légumes surgelés et des légumes secs en conserve (déjà cuits), avec dégustation et recettes à emporter ; un travail avec l'épicerie sur l'**offre** (surgelés nature, conserves de légumes, fruits à prix symbolique placés à l'entrée). On ne retire pas les produits sucrés des rayons et on ne commente pas les paniers individuels : les familles choisissent.

Cas guidé 6 – Une réunion de parents en protection maternelle et infantile (données fictives)

La puéricultrice d'un centre de PMI organise une réunion sur l'alimentation des enfants de 1 à 3 ans. Elle a

interrogé **30 parents** avant la réunion.

- « Je force mon enfant à finir son assiette » : 13 ; « je promets le dessert s'il mange ses légumes » : 17 ; « je prépare un autre plat quand il refuse » : 9 ; « j'ai commencé la diversification avant 4 mois » : 4.
- Verbatims : « Il ne mange rien, je suis épuisée. » ; « Chez sa grand-mère, il mange tout. »

Questions – Cas guidé 6

1. Calculez le pourcentage de parents concernés par chaque pratique.

2. Analysez ces pratiques avec le partage des responsabilités (Satter) et les styles parentaux.

3. Rédigez trois messages pour la réunion, positifs et sans jugement.

Corrigé – Cas guidé 6

1. Forcer à finir : 13 / 30 = **43,3 %** ; dessert en récompense : 17 / 30 = **56,7 %** ; autre plat préparé : 9 / 30 = **30,0 %** ; diversification avant 4 mois : 4 / 30 = **13,3 %**.

2. Forcer à finir et promettre le dessert relèvent d'un style **contrôlant** : le parent décide à la place de l'enfant de **combien** il mange, ce qui, selon le **partage des responsabilités** (4.3.9), revient à l'enfant ; la récompense par le dessert augmente l'attrait du dessert et diminue celui du légume (études de Birch, 4.3.9). Préparer un autre plat relève d'un style **permissif** : l'enfant décide du menu, ce qui revient au parent. La diversification avant 4 mois ne suit pas les repères actuels (entre 4 et 6 mois). La remarque sur la grand-mère montre que le **contexte** (calme, absence de pression, modèle des autres convives) compte beaucoup. Les parents épuisés ont surtout besoin d'être rassurés : la sélectivité est fréquente et souvent transitoire à cet âge.

3. « Vous choisissez quoi, quand et où ; votre enfant choisit combien : vous pouvez lui faire confiance. » ; « Un légume refusé aujourd'hui peut être accepté après plusieurs présentations : continuez à le proposer, sans forcer et sans récompense. » ; « Mangez avec lui, à table, sans écran : il apprend en vous regardant. »

4.4 Approfondissements

4.4.1 Le goût : un apprentissage

Les préférences innées sont limitées (attrait pour le sucré, l'umami et le salé ; rejet initial de l'amer et de l'acide). La plupart des goûts sont **appris** : dès la vie fœtale (les arômes du liquide amniotique), par l'allaitement (le lait maternel transmet des arômes de l'alimentation de la mère), puis par l'exposition répétée, l'imitation et le contexte émotionnel. Les **aversions conditionnées** (un aliment associé à une maladie digestive) peuvent durer toute la vie. L'éducation sensorielle (classes du goût, Semaine du goût) s'appuie sur cette plasticité.

Nous ne percevons pas tous les goûts de la même façon

Le goût au sens courant est en réalité la **flaveur** : l'ensemble des sensations perçues en bouche, qui associe les **saveurs** (perçues par la langue), les **arômes** (perçus par le nez, par voie rétronasale), la **texture**, la température et les sensations dites trigéminales (piquant du piment, fraîcheur de la menthe, pétillant). Cette perception varie d'une personne à l'autre, pour des raisons biologiques et pas seulement par « caprice ».

Composante	Organe et mécanisme	Ce qu'il faut savoir pour l'éducation
Saveurs (sucré, salé, acide, amer, umami)	Cellules des bourgeons du goût, sur la langue, le palais, le pharynx ; récepteurs spécifiques (environ vingt-cinq récepteurs différents de l'amer chez l'humain)	La « carte de la langue » (le sucré à la pointe, l'amer au fond) est une **idée fausse** : chaque zone perçoit toutes les saveurs

Composante	Organe et mécanisme	Ce qu'il faut savoir pour l'éducation
Arômes	Muqueuse olfactive, atteinte par l'arrière de la bouche quand on mâche et avale (rétro-olfaction)	La plus grande part de ce que l'on appelle « goût » vient de l'odorat : avec le nez pincé, on distingue mal une pomme d'une poire
Texture	Récepteurs du toucher dans la bouche	Une texture refusée (grumeaux, filandreux, gluant) est une cause fréquente de rejet chez l'enfant
Sensations trigéminales	Nerf trijumeau (piquant, frais, astringent)	Elles varient beaucoup selon l'habitude (tolérance au piment)

Définition – Goûteurs et non-goûteurs

La sensibilité à certaines molécules amères (la **PTC** et le **PROP**, proches de composés présents dans les choux, le brocoli, les endives) dépend en grande partie d'un gène (TAS2R38). On distingue des **non-goûteurs**, qui perçoivent peu ou pas cette amertume (environ un quart à un tiers des personnes d'origine européenne, beaucoup moins dans d'autres populations), des goûteurs moyens et des **super-goûteurs**, décrits par Linda Bartoshuk dans les années 1990, très sensibles à l'amer et souvent à l'intensité des saveurs en général.

Lien diététique – Ce que cela change en pratique

- Un enfant qui refuse les choux ou les endives n'est pas forcément « difficile » : il peut percevoir une amertume réelle, plus forte que celle que perçoit l'adulte. On propose des préparations qui atténuent l'amertume (gratin, purée mélangée, association avec un ingrédient doux), et on continue l'**exposition répétée** (chapitre 3, 3.4.1).
- Avec l'âge, l'**odorat** diminue souvent nettement après 60 à 70 ans ; des médicaments, le tabac, certaines maladies ou traitements (chimiothérapie) modifient aussi le goût. Une personne âgée qui trouve que « tout a le même goût » mange moins : on relève les plats avec des herbes, des épices douces, des sauces, en jouant sur les couleurs et les textures, plutôt qu'en ajoutant du sel ou du sucre (lien avec la dénutrition, 4.3.10).
- L'**habitude** déplace les seuils : une personne qui réduit progressivement le sel ou le sucre trouve, après quelques semaines, les produits habituels trop salés ou trop sucrés.

Calcul détaillé – Préparer une gamme de solutions sucrées pour un atelier « classement »

On veut faire classer quatre solutions de saccharose à 0, 10, 20 et 40 g par litre, à 12 participants, chacun goûtant 20 mL de chaque solution.

- Volume nécessaire par solution : 12 × 20 = **240 mL** ; on prépare **250 mL** de chaque.
- Sucre à peser : 0,250 × 0 = **0 g** ; 0,250 × 10 = **2,5 g** ; 0,250 × 20 = **5 g** ; 0,250 × 40 = **10 g**.
- Total de sucre : 0 + 2,5 + 5 + 10 = **17,5 g**, soit environ 3 à 4 morceaux de sucre de 5 g.
- Comparaison : un cola sucré contient 10 g de sucres pour 100 g (Ciqual 2025), soit environ **100 g par litre**, c'est-à-dire 100 / 40 = **2,5 fois** la solution la plus sucrée de l'atelier.

Interprétation : la solution à 40 g par litre paraît déjà très sucrée à la plupart des participants ; la comparaison avec le cola rend concret le niveau de sucre auquel on s'habitue, sans discours culpabilisant.

Exemple – L'expérience du nez pincé

En atelier, chaque participant goûte, les yeux fermés et le nez pincé, un petit morceau de pomme, puis de poire, puis d'oignon cru. Beaucoup ne savent pas les distinguer, ou trouvent seulement « un peu sucré ». Dès qu'ils relâchent le nez, l'arôme arrive et l'aliment est reconnu. L'expérience montre en deux minutes que l'odorat fait l'essentiel du goût, et explique pourquoi un rhume ou le vieillissement diminuent l'envie de

manger.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.25

Une animatrice d'EHPAD signale que les résidents « salent tout » et se plaignent que « les repas n'ont pas de goût ». a) Proposez deux explications liées à la perception. b) Proposez trois adaptations des plats qui ne passent pas par le sel. c) Pourquoi ne faut-il pas supprimer la salière sans en parler avec les résidents ?

Corrigé

a) Diminution de l'**odorat** avec l'âge (les arômes, qui font l'essentiel du goût, sont moins perçus) ; effet de certains **médicaments** ou d'une bouche sèche qui modifient la perception des saveurs ; on peut ajouter des plats peu relevés ou des textures monotones (mixé). **b)** Herbes fraîches et aromates (persil, ciboulette, ail, échalote), épices douces (cumin, curry doux, paprika), jus de citron ou vinaigre, sauces maison, contrastes de textures et de couleurs dans l'assiette. **c)** Pour une personne âgée, le plaisir de manger est un rempart contre la **dénutrition** ; supprimer le sel sans explication réduit l'appétit et la confiance ; la limitation du sel se discute avec le médecin selon la situation (insuffisance cardiaque, hypertension), et se fait progressivement.

4.4.2 Manger en pleine conscience et approches non restrictives

Des approches comme l'**alimentation intuitive** (Tribole et Resch, 1995) ou l'approche du **GROS** (Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids) proposent de **réhabiliter les sensations** alimentaires (faim, rassasiement, plaisir) plutôt que de prescrire des régimes. Le guide du BTS cite ces approches (approche bio-psycho-sensorielle, thérapie d'acceptation et d'engagement, pleine conscience) parmi les ressources de la prise en charge. En santé publique, elles inspirent des ateliers de **dégustation en pleine conscience** (manger lentement, décrire, repérer le rassasiement).

4.4.3 La dimension sociale du repas et la santé

Le repas partagé est associé à une meilleure qualité de l'alimentation chez l'enfant (repas familiaux réguliers) et à de meilleurs apports chez la personne âgée (facilitation sociale). À l'inverse, l'**isolement** est un facteur de risque de dénutrition. Les actions de santé publique peuvent donc viser le **contexte** du repas (convivialité, horaires, lieu), et pas seulement son contenu.

4.4.4 Le gaspillage alimentaire

En France, en 2023, les déchets alimentaires représentent **9,7 millions de tonnes** sur toute la chaîne, dont **3,8 millions de tonnes** de parties comestibles, c'est-à-dire de gaspillage, soit environ 55 kg par habitant ; les ménages, à domicile, en produisent la plus grande part (SDES, 30 octobre 2025 ; méthode européenne, non comparable à l'ancienne estimation de l'ADEME de 2016, environ 10 millions de tonnes sur un champ plus large). La loi **Garot** (2016) a interdit la destruction d'invendus consommables par les grandes surfaces et organisé le don aux associations ; la loi **EGalim** (2018) et la loi **AGEC** (2020) ont étendu les obligations (diagnostic anti-gaspillage en restauration collective, don des excédents). En éducation, la lutte contre le gaspillage relie nutrition, budget et environnement : bien conserver, comprendre les dates (DLC « à consommer jusqu'au » ; DDM « à consommer de préférence avant »), cuisiner les restes, adapter les portions.

4.4.5 Alimentation et ultra-transformation : comprendre le débat

La classification **NOVA** (Monteiro, Brésil) classe les aliments selon leur degré de transformation : 1. bruts ou peu transformés ; 2. ingrédients culinaires (huile, sucre, sel) ; 3. aliments transformés (conserves, fromages, pain artisanal) ; 4. **ultra-transformés** (formulations industrielles contenant des ingrédients peu utilisés en cuisine : arômes, émulsifiants, édulcorants, protéines isolées). Des études de cohorte, dont NutriNet-Santé, associent une

consommation élevée d'aliments ultra-transformés à un risque accru d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de mortalité, mais la causalité et les mécanismes restent discutés. Les repères de 2019 recommandent de **privilégier les aliments peu transformés** et de **limiter** les aliments ultra-transformés, en complément du Nutri-Score (qui mesure la qualité nutritionnelle, pas le degré de transformation).

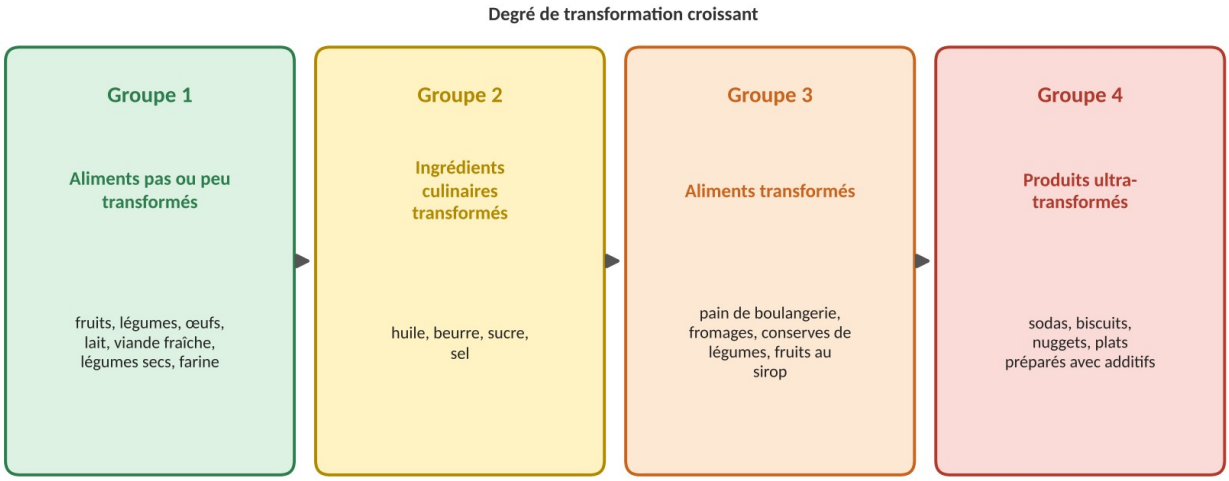


Figure 4.8 bis – La classification NOVA des aliments selon leur degré de transformation

Comprendre le schéma – Figure 4.8 bis

1. La classification NOVA, proposée par l'équipe de Carlos Monteiro (université de São Paulo), range les aliments en **quatre groupes**, de gauche à droite selon le degré de transformation.
2. **Groupe 1** : aliments pas ou peu transformés (fruits, légumes, œufs, lait, viande fraîche, légumes secs, farine).
3. **Groupe 2** : ingrédients culinaires transformés, utilisés pour cuisiner (huile, beurre, sucre, sel).
4. **Groupe 3** : aliments transformés, obtenus en ajoutant des ingrédients du groupe 2 à des aliments du groupe 1 (pain de boulangerie, fromages, conserves de légumes, fruits au sirop).
5. **Groupe 4** : produits ultra-transformés, formulations industrielles contenant des substances peu ou pas utilisées en cuisine (arômes, émulsifiants, édulcorants, protéines isolées).
6. La classification porte sur la **transformation**, pas sur la composition nutritionnelle : elle complète le Nutri-Score, elle ne le remplace pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.26

Classez dans les groupes NOVA : a) une compote de pommes « pomme, sucre » ; b) un yaourt nature ; c) une boisson aromatisée « zéro sucre » avec édulcorants ; d) un pain de mie avec émulsifiants ; e) des flocons d'avoine ; f) du beurre. Indiquez ensuite le produit de remplacement simple que vous proposeriez pour c) et d).

Corrigé

a) Groupe 3 (fruit et sucre ajouté). **b)** Groupe 1 (lait fermenté, sans autre ingrédient), parfois classé en groupe 3 selon les auteurs. **c)** Groupe 4. **d)** Groupe 4. **e)** Groupe 1. **f)** Groupe 2. Remplacements : pour c), de l'eau, plate ou gazeuse, avec quelques rondelles d'agrume ; pour d), du pain de boulangerie (groupe 3), en tranches congelées pour le garder.

4.4.6 Nouveaux aliments et acceptabilité : insectes et substituts végétaux

La transition vers une alimentation plus durable (4.3.12) passe par des aliments nouveaux ou peu familiers : insectes, produits à base de protéines végétales texturées, et demain peut-être d'autres sources. Leur succès ne dépend pas seulement de leur composition : il dépend de **comportements** étudiés dans ce chapitre (néophobie, dégoût, normes culturelles, prix, goût).

Définition – Le dégoût

Le **dégoût** est une émotion de rejet face à un aliment perçu comme contaminant ou offensant, souvent en raison de son **origine** ou de son idée plutôt que de son goût (Rozin et Fallon, 1987). Il se distingue du simple « je n'aime pas » : une personne dégoûtée refuse même de goûter, ou rejette un plat qui a seulement touché l'aliment. En France, les insectes provoquent souvent du dégoût, alors qu'environ deux milliards de personnes dans le monde en consomment de façon traditionnelle (FAO, 2013).

Aliment	Cadre et situation	Freins observés	Leviers
Insectes	« Nouveaux aliments » selon le règlement européen 2015/2283 : autorisation nécessaire ; autorisés notamment le ténébrion meunier séché (2021), le criquet migrateur (2021), le grillon domestique (2022) et le petit ténébrion (2023) ; étiquetage d'un risque d'allergie croisée avec les crustacés et les acariens	Dégoût, absence de tradition, prix élevé	Formes « invisibles » (farine dans des biscuits) ; dégustation volontaire, jamais imposée ; curiosité chez les enfants
Substituts végétaux (galettes, émincés, haché végétal)	Produits transformés à base de soja, de blé ou de pois ; les décrets français de 2022 et 2024 ont été annulés après l'arrêt de la Cour de justice de l'UE (4 octobre 2024) ; un règlement européen réservant « steak », « bacon » ou « foie » aux produits carnés (mais pas « burger » ni « saucisse ») a été voté par le Parlement européen le 16 juin 2026 et attendait l'accord formel des États	Goût et texture jugés décevants par certains, prix, image de produit ultra-transformé	Utilisation dans des recettes familières (bolognaise, burgers) ; comparaison des étiquettes
Légumineuses « brutes »	Aliment traditionnel, recommandé au moins deux fois par semaine (Santé publique France, 2019)	Temps de cuisson, inconfort digestif, image « vieillotte »	Conserves déjà cuites, recettes du monde (dahl, houmous, chili)

Calcul détaillé – Une galette végétale, un steak haché et des lentilles (Ciqual 2025, pour 100 g)

- **Galette blé et soja végane** : 215 kcal ; 16 g de protéines ; 11 g de lipides ; 6,0 g de fibres ; **1,3 g de sel** ; 3,3 mg de fer.
- **Steak haché à 15 % de matières grasses, cru** : 215 kcal ; 20,2 g de protéines ; 14,8 g de lipides ; 0 g de fibres ; 0,1 g de sel (avant salage) ; 2,64 mg de fer (en partie héminique, mieux absorbé).
- **Lentilles vertes cuites** : 125 kcal ; 10,1 g de protéines ; 0,58 g de lipides ; 8,45 g de fibres ; 0,015 g de sel ; 2,45 mg de fer. Pour une portion de 150 g : 150 × 10,1 / 100 = **15,2 g** de protéines et 150 × 8,45 / 100 = **12,7 g** de fibres.

- Sel de la galette : 1,3 / 0,1 = **13 fois** plus que la viande crue ; une galette de 100 g apporte 1,3 / 5 × 100 = **26 %** de la limite de 5 g de sel par jour conseillée par l'OMS.

Interprétation : la galette végétale apporte des fibres et des protéines, mais elle est salée et transformée ; elle peut aider une famille à réduire la viande, sans être « meilleure » par nature. Les légumineuses cuisinées restent l'option la plus intéressante pour la santé et le budget (4.3.14).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.27

Un animateur de centre de loisirs veut organiser une « dégustation d'insectes » pour des enfants de 8 à 10 ans, en disant aux parents que « c'est l'aliment du futur ». a) Quelles réactions des enfants faut-il prévoir ? b) Quelles précautions sont indispensables ? c) Comment présenter l'activité de façon honnête ?

Corrigé

a) Curiosité chez certains, **dégoût** et refus chez d'autres, effet de groupe (moqueries ou défis). **b)** Informer les parents et recueillir leur accord ; vérifier les **allergies** (crustacés, acariens, risque d'allergie croisée) ; utiliser des produits autorisés et étiquetés ; laisser chaque enfant libre de goûter ou non, sans pression ni défi. **c)** Présenter une découverte culturelle (pays où les insectes sont consommés, intérêt environnemental discuté), sans promettre que ce sera « l'aliment du futur » : la question est encore débattue et dépendra des goûts, des prix et des choix collectifs.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.4 – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles sont les préférences gustatives innées du nouveau-né ?
2. Pourquoi un enfant non-goûteur et un enfant super-goûteur ne réagissent-ils pas de la même façon aux endives ?
3. Citez deux approches non restrictives de l'alimentation.
4. Pourquoi le repas partagé est-il un enjeu de santé chez la personne âgée ?
5. Distinguez DLC et DDM.
6. Que classe la classification NOVA, et quelle est sa principale limite ?
7. Qu'est-ce que le dégoût, et en quoi diffère-t-il du simple « je n'aime pas » ?
8. Pourquoi une galette végétale n'est-elle pas forcément « meilleure » qu'un plat de lentilles ?

Corrigé – Point d'étape 4.4

1. Attrait pour le sucré, l'umami et le salé ; rejet initial de l'amer et de l'acide.
2. Le super-goûteur perçoit beaucoup plus l'amertume de certaines molécules présentes dans les endives et les choux (sensibilité au PROP liée au gène TAS2R38) : son refus n'est pas un caprice.
3. L'alimentation intuitive, l'approche du GROS, la pleine conscience (au choix).
4. L'isolement est un facteur de risque de dénutrition ; manger avec d'autres augmente les apports (facilitation sociale) et le plaisir.
5. DLC : « à consommer jusqu'au », pour les denrées périssables, à ne pas dépasser ; DDM : « à consommer de préférence avant », le produit reste consommable après la date, avec une possible perte de qualité.
6. Le degré de transformation des aliments (4 groupes) ; elle ne tient pas compte de la composition nutritionnelle et la frontière entre groupes est parfois discutée.
7. Une émotion de rejet liée à l'origine ou à l'idée de l'aliment (Rozin et Fallon, 1987), qui fait refuser même de goûter.
8. Elle est transformée et salée (1,3 g de sel pour 100 g dans Ciqual 2025) ; les lentilles cuisinées apportent

plus de fibres, presque pas de sel, et coûtent moins cher.

4.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La régulation neuro-hormonale en détail

L'hypothalamus (noyau arqué) contient deux populations de neurones : les neurones **NPY/AgRP** (orexigènes, stimulés par la ghréline) et les neurones **POMC/CART** (anorexigènes, stimulés par la leptine et l'insuline). La **leptine**, proportionnelle à la masse grasse, signale les réserves à long terme ; dans l'obésité, on observe une **résistance à la leptine**. Les analogues du **GLP-1** (sémaglutide), utilisés dans le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité, agissent sur la satiété et la vidange gastrique ; leur diffusion récente modifie la prise en charge de l'obésité et pose de nouvelles questions nutritionnelles (perte de masse musculaire, accompagnement diététique).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Restriction cognitive : mesure et débats

La restriction cognitive se mesure par des questionnaires validés (*Three-Factor Eating Questionnaire* de Stunkard et Messick, 1985 : restriction, désinhibition, faim ; *Dutch Eating Behaviour Questionnaire*). Les travaux distinguent une restriction **rigide** (règles strictes, associée à la désinhibition et à la prise de poids) et une restriction **flexible** (ajustements souples, moins délétère). Ces nuances invitent à ne pas condamner toute attention portée à l'alimentation, mais à prévenir la rigidité.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le « mangeur pluriel » et l'individualisation

Les sociologues décrivent un mangeur **pluriel**, dont les pratiques varient selon les contextes (semaine/week-end, seul/en famille, travail/domicile), et une tension entre **individualisation** (choix personnels, régimes, préférences) et maintien du **repas commun** comme norme. En France, les enquêtes comparatives (Fischler et Masson, *Manger : Français, Européens et Américains face à l'alimentation*, 2008) montrent un attachement plus fort qu'ailleurs au repas partagé et au plaisir, considérés comme protecteurs.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La sélectivité alimentaire et l'ARFID

La **sélectivité alimentaire** (*picky eating*) est fréquente chez le jeune enfant et généralement transitoire. Elle se distingue du **trouble de restriction ou d'évitement de l'ingestion des aliments** (ARFID, DSM-5, 2013), qui associe un évitement important (sensoriel, peur d'avaler, manque d'intérêt) à des conséquences : perte de poids ou cassure de la courbe de croissance, carences, dépendance à des compléments, retentissement social. L'ARFID relève d'une prise en charge pluridisciplinaire ; en santé publique, on repère et on oriente.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les habitudes : automatisme et environnement

En psychologie, une **habitude** est un comportement déclenché automatiquement par un **contexte** (lieu, heure, émotion), après de nombreuses répétitions (Wood et Neal, 2007). Une étude de Lally et coll. (2010) a montré que l'automatisme d'un nouveau comportement de santé s'installe en moyenne en **66 jours**, avec une grande variabilité (18 à 254 jours). Conséquences : associer le nouveau comportement à un contexte stable (« un fruit au goûter, chaque jour à 16 h 30 »), tolérer les oublis, et modifier l'environnement qui déclenche les anciennes habitudes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – « Aimer » et « vouloir » : deux systèmes distincts

Les travaux de Kent Berridge (université du Michigan, depuis les années 1990) distinguent deux composantes de la récompense alimentaire. L'**appréciation** (*liking*) est le plaisir ressenti en mangeant ; elle dépend de petites zones du cerveau et des systèmes opioïdes et endocannabinoïdes. Le **désir** (*wanting*) est la motivation à obtenir l'aliment ; il dépend surtout de la **dopamine** et peut être déclenché par des indices de l'environnement (odeur, emballage, publicité, heure habituelle). Les deux sont en général liés, mais peuvent se dissocier : on peut « vouloir » intensément un aliment que l'on n'apprécie plus beaucoup une fois en bouche. Cette distinction éclaire l'**externalité** (4.3.3), le rôle des indices dans le grignotage, et le débat sur l'« addiction alimentaire » (4.3.3) : c'est le désir, plus que le plaisir, qui peut s'emballer. Pour l'éducation, elle invite à travailler sur l'environnement et les indices, et à réhabiliter le plaisir de la dégustation plutôt qu'à le combattre.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Définir un aliment « hyperpalatable » : les critères de Fazzino (2019)

Tera Fazzino et collaborateurs (revue *Obesity*, 2019) ont proposé une définition chiffrée des aliments **hyperpalatables**, dont les combinaisons de nutriments seraient particulièrement attirantes. Un aliment l'est s'il remplit au moins un critère : **gras et sodium** (lipides > 25 % de l'énergie et sodium ≥ 0,30 % du poids) ; **gras et sucres** (lipides > 20 % et sucres simples > 20 % de l'énergie) ; **glucides et sodium** (glucides > 40 % de l'énergie et sodium ≥ 0,20 % du poids). Les auteurs ont estimé qu'environ 62 % des aliments d'une base américaine remplissaient au moins un critère.

Application (Ciqual 2025, pour 100 g ; sodium = sel / 2,5) :

- Chips (532 kcal ; 32,7 g de lipides ; 1,35 g de sel) : lipides 32,7 × 9 / 532 × 100 = **55,3 %** de l'énergie ; sodium 1,35 / 2,5 = **0,54 g**, soit 0,54 % du poids : critère « gras et sodium » rempli.
- Petit beurre (450 kcal ; 13,3 g de lipides ; 22 g de sucres ; 73,4 g de glucides ; 1,04 g de sel) : lipides **26,6 %** ; sucres 22 × 4 / 450 × 100 = **19,6 %** ; glucides **65,2 %** ; sodium **0,42 %** : critères « gras et sodium » et « glucides et sodium » remplis ; le critère « gras et sucres » est manqué de peu.
- Céréales chocolatées pour petit-déjeuner (393 kcal ; 5,1 g de lipides ; 22,5 g de sucres ; 0,3 g de sel) : lipides **11,7 %**, sucres **22,9 %**, sodium **0,12 %** : aucun critère, bien qu'elles soient très sucrées.
- Lentilles vertes cuites : lipides **4,2 %**, sodium **0,006 %** : aucun critère.

Limites : les seuils ont été choisis à partir de la littérature et non à partir de la réponse réelle des mangeurs ; la définition ne prend en compte ni la texture, ni les arômes, ni la densité énergétique, ni le prix ; un même aliment peut changer de catégorie selon la recette. Elle est utile pour décrire une offre alimentaire (part des produits hyperpalatables dans un distributeur), pas pour juger un mangeur.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'effet de la taille des portions

Dans une étude de laboratoire, Barbara Rolls et collaborateurs (2002) ont servi à des adultes, au déjeuner, un plat de macaronis au fromage en portions de 500, 625, 750 ou 1 000 g, sur quatre jours différents. Avec la plus grande portion, les participants ont consommé environ **30 % d'énergie en plus** qu'avec la plus petite, sans se déclarer plus rassasiés, et sans compenser ensuite. L'effet s'observe chez les personnes de poids normal comme en surpoids, chez l'enfant dès 5 ans environ, et pour de nombreux aliments. Exemple de calcul (données fictives) : une personne qui mange 500 kcal de ce plat avec la petite portion en mangerait environ 500 × 1,30 = **650 kcal** avec la grande. Ce résultat appuie les actions sur l'**environnement** (taille des assiettes et des contenants, portions servies en restauration collective, emballages individuels) plutôt que les seuls conseils de « volonté », et rejoint la notion d'**externalité** (4.3.3).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Décrire des profils alimentaires

En épidémiologie nutritionnelle, on ne s'intéresse pas seulement aux aliments pris un par un : on recherche des **profils** (ou *dietary patterns*) qui regroupent les aliments consommés ensemble. Deux familles de méthodes existent (Hu, 2002) : des méthodes **a priori**, qui comparent l'alimentation à un score construit à

partir des recommandations (par exemple le score d'adéquation au PNNS), et des méthodes **a posteriori**, qui font émerger les profils des données (analyse en composantes principales, classification). Les études retrouvent souvent un profil « prudent » (fruits, légumes, légumineuses, poisson, céréales complètes) et un profil « occidental » (viandes rouges et transformées, produits raffinés, boissons sucrées, desserts). Exemple fictif : une classification des réponses de 400 adultes fait apparaître trois groupes de 152, 128 et 120 personnes, soit **38 %**, **32 %** et **30 %**. **Limites** : les profils dépendent de la population étudiée, des aliments retenus et des choix de l'analyste (nombre de groupes, noms donnés aux profils) ; un profil décrit une association, pas une cause. Pour le diététicien en santé publique, ces profils aident à cibler une action (par exemple un groupe de jeunes adultes au profil « occidental » et au budget serré).

4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Restriction et consultation

Une patiente consulte pour « perdre 5 kg avant l'été » et suit déjà des règles strictes. Le diététicien repère la **restriction cognitive** et l'insatisfaction corporelle, évite de prescrire un régime, travaille les sensations alimentaires et oriente si des signes de TCA apparaissent.

Situation bc2 – Menus et pratiques des convives

En restauration collective, le diététicien intègre les pratiques des convives : menu végétarien hebdomadaire (EGalim), alternatives sans porc, repas adaptés pendant le Ramadan dans un foyer de jeunes travailleurs, en garantissant l'équilibre nutritionnel.

Situation bc3 – Atelier « faim et envie » pour des adultes

Dans un centre social, un atelier de dégustation en pleine conscience permet de repérer la faim, le rassasiement et le plaisir ; il prévient la restriction et l'alimentation émotionnelle, sans parler de poids.

Situation bc3 – Accompagner les jeunes végétariens

Un lycée constate une hausse des demandes de repas végétariens ; le diététicien conçoit une action d'information sur l'équilibre végétarien (fer, B12 pour les végétaliens) et un atelier de recettes à base de légumineuses, en respectant les choix des élèves.

Situation bc2 – Collation matinale à l'école

Une école distribue une collation à 10 h (jus et biscuits). Le diététicien rappelle l'avis de l'AFSSA (2004), propose de déplacer l'effort sur le petit-déjeuner (petits-déjeuners pédagogiques en classe) et de réserver une collation (fruit, pain, produit laitier) aux enfants n'ayant pas déjeuné.

Situation bc3 – Alimentation durable en centre social

Un centre social veut des « ateliers durables ». Le diététicien conçoit des recettes de saison, à base de légumes secs, avec un calcul du coût et de l'empreinte carbone par portion, et un module anti-gaspillage (dates, restes), sans culpabiliser les familles.

4.6.1 Préparer l'oral : défendre une analyse de comportement alimentaire

À l'épreuve, le jury demande souvent de **justifier** un choix : pourquoi cette action plutôt qu'une autre, pourquoi ne pas avoir proposé de régime, pourquoi parler de plaisir. Les réponses s'appuient sur les notions du chapitre et sur des sources datées.

À l'oral – Trois questions fréquentes du jury et des éléments de réponse

- **« Pourquoi n'avez-vous pas parlé de poids dans votre atelier ? »** Parce que les messages centrés sur le poids favorisent la restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975), la stigmatisation et, chez les jeunes, les TCA ; l'objectif de santé est atteint par le plaisir, les sensations, la régularité et l'environnement.
- **« Votre public dit ne pas avoir le temps de cuisiner : que proposez-vous ? »** Partir de la contrainte (déterminant environnemental) : cuisine en avance, recettes de moins de 20 minutes, produits bruts surgelés ou en conserve ; agir aussi sur l'environnement (restauration collective, offre près du travail).
- **« Comment savez-vous que votre recette sera acceptée ? »** Par une dégustation avec une échelle hédonique et le calcul d'un taux d'acceptation (notes 4 et 5), en tenant compte des pratiques recueillies (fiche O4.1).

Point d'étape – Vrai ou faux ? Quinze affirmations à justifier

1. Le rassasiement se produit après le repas et détermine le délai jusqu'au repas suivant.
2. La restriction cognitive consiste à manger selon des règles plutôt que selon ses sensations.
3. Selon Satter, l'enfant décide de ce qu'il mange.
4. La néophobie est maximale entre 2 et 6 ans.
5. Une collation à 10 h est recommandée pour tous les enfants de l'école élémentaire.
6. Un végétalien doit prendre un supplément de vitamine B12.
7. Le Nutri-Score mesure le degré de transformation d'un aliment.
8. Le diététicien de santé publique peut utiliser le questionnaire SCOFF en atelier collectif pour dépister les TCA.
9. Les aliments denses en énergie apportent les calories les moins chères.
10. La laïcité interdit à une cantine publique de proposer un plat sans porc.
11. Retarder l'introduction de l'œuf protège le bébé des allergies.
12. Le syncrétisme culinaire est la combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes.
13. Une portion plus grande fait manger davantage sans augmenter beaucoup la satiété.
14. Les distributeurs automatiques payants d'aliments sont autorisés dans les collèges.
15. Le dîner doit apporter au moins 40 % de l'énergie de la journée.

Corrigé – Vrai ou faux

1. Faux : le rassasiement se produit **pendant** le repas et conduit à l'arrêter ; c'est la satiété qui suit le repas. 2. Vrai (Herman et Polivy, 1975). 3. Faux : le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien. 4. Vrai. 5. Faux : elle n'est pas recommandée pour les enfants qui ont pris un petit-déjeuner (AFSSA, 2004). 6. Vrai : la vitamine B12 n'est présente en quantité utile que dans les produits animaux. 7. Faux : il mesure la qualité nutritionnelle ; c'est la classification NOVA qui décrit la transformation. 8. Faux : c'est un outil de repérage individuel réservé aux professionnels de santé dans une relation de soin. 9. Vrai (Drewnowski et Darmon, 2005). 10. Faux : la laïcité n'oblige pas à proposer des menus confessionnels, mais ne l'interdit pas ; beaucoup de communes proposent un plat de substitution. 11. Faux : les allergènes s'introduisent sans retard entre 4 et 6 mois (HCSP, 2020 ; Santé publique France, 2021). 12. Vrai. 13. Vrai (travaux de Barbara Rolls). 14. Faux : ils sont interdits dans les établissements scolaires depuis 2005 (loi du 9 août 2004). 15. Faux : la fourchette usuelle est de 25 à 30 %, et ce n'est pas une norme stricte.

4.6.2 Préparer l'atelier culinaire : lire le contexte imposé avec les notions du chapitre

Au temps 2 de l'épreuve E5, vous animez un **atelier culinaire dans un contexte imposé**. Le jury observe si vos choix (recette, organisation, messages) sont **adaptés au public**. Les notions de ce chapitre servent à lire le contexte : qui sont les participants, ce qu'ils mangent, ce qui compte pour eux, ce qui les freine. La conception d'un atelier interculturel est présentée au chapitre 3 ; on se concentre ici sur l'**analyse des comportements** qui justifie les choix.

Méthode pas à pas – Six questions pour lire un contexte imposé

1. Quel âge et quel stade ? Âge, autonomie, développement (4.3.9, 4.3.10) : un enfant de 4 ans ne manipule pas un couteau ; un adolescent cherche l'autonomie et l'image de soi.

2. Quels rôles de l'acte alimentaire comptent pour ce public ? Plaisir, convivialité, identité, santé (4.3.1) : pour des adolescents, partager et « faire comme les autres » ; pour une personne âgée isolée, le lien social.

3. Quelles pratiques ? Religieuses, culturelles, végétariennes, allergies (4.3.6, 4.3.15) : à vérifier dans le sujet ou à prévoir sous forme de variantes.

4. Quels déterminants pèsent le plus ? Budget, temps, équipement, compétences culinaires (4.3.4) : la recette doit pouvoir être refaite chez soi avec le matériel disponible.

5. Quelles régulations ou dérégulations repérer ? Grignotage, repas sautés, restriction (4.3.3, 4.3.8) : ils orientent le message (par exemple la collation prévue plutôt que le grignotage).

6. Comment saurai-je que l'atelier a plu ? Dégustation, échelle hédonique, question ouverte en fin d'atelier (4.3.16).

Exemple – Un contexte imposé analysé

Contexte : atelier de 2 heures pour 8 adolescents de 14 à 16 ans hébergés dans un foyer de l'Aide sociale à l'enfance ; budget de 25 € ; cuisine équipée d'un four ; les éducateurs signalent des repas sautés, beaucoup de commandes de pizzas et de kebabs le week-end, et deux jeunes qui ne mangent pas de porc.

Question	Ce que l'on repère	Décision
Âge, stade	Adolescents qui veulent de l'autonomie	Les jeunes choisissent leurs garnitures et réalisent tout eux-mêmes
Rôles	Plaisir, partage, identité (« manger comme les copains »)	Une recette qu'ils connaissent et aiment : la pizza
Pratiques	Deux jeunes ne mangent pas de porc	Garnitures sans porc pour tous (thon, légumes, mozzarella), pas de produit à part qui stigmatise
Déterminants	Faible budget, envie de rapidité, livraisons	Pâte rapide sans repos long, montrer que c'est moins cher qu'une livraison
Dérégulations	Repas sautés, commandes le week-end	Message : « une pizza maison en 30 minutes, c'est un vrai repas » ; pas de discours sur le poids
Évaluation	Plaisir et envie de refaire	Échelle hédonique en smileys et question « Que referais-tu chez toi ? »

Calcul détaillé – Le coût de l'atelier (prix fictifs, octobre 2026)

Pizza maison et salade de fruits pour 8 : farine 500 g (0,48 €), levure (0,30 €), huile 3 cL (0,07 €), coulis de tomate 500 g (1,20 €), mozzarella 250 g (1,90 €), légumes (poivrons, champignons, oignon : 3,10 €), 2 boîtes

de thon (3,00 €), fruits 1 kg (2,40 €), 8 yaourts nature (1,90 €).

- Total : 0,48 + 0,30 + 0,07 + 1,20 + 1,90 + 3,10 + 3,00 + 2,40 + 1,90 = **14,35 €**.
- Par participant : 14,35 / 8 = **1,79 €**.
- Reste sur le budget : 25 − 14,35 = **10,65 €**, qui peut servir à acheter des boîtes pour que chaque jeune emporte une part, ou des épices pour le foyer.

Interprétation : une pizza livrée coûte couramment entre 10 et 15 € : le repas complet de l'atelier revient à moins de 2 € par jeune. Cet écart est un argument concret et non culpabilisant, qui parle aux adolescents.

À l'oral – Justifier ses choix en une minute

« J'ai choisi la pizza parce que c'est un plat que les jeunes aiment et commandent souvent : partir de leurs pratiques favorise leur participation et l'envie de refaire. Les garnitures sont sans porc pour que tout le monde mange la même chose, sans mettre personne à part. Les jeunes réalisent tout eux-mêmes, car à cet âge l'autonomie compte. Mon message porte sur le plaisir, la rapidité et le coût, pas sur le poids, pour éviter de favoriser la restriction. J'évalue l'atelier par une échelle hédonique et une question sur ce qu'ils referaient chez eux. »

À vous de jouer – Exercice d'application 4.28

Contexte imposé : atelier de 2 heures pour 6 résidents d'une résidence autonomie (78 à 90 ans), dont deux portent un appareil dentaire et une personne a perdu l'appétit depuis son veuvage ; budget de 18 € ; cuisine avec plaques et four. a) Repérez, pour au moins quatre des six questions de la méthode, ce qui compte dans ce contexte. b) Proposez une recette et justifiez-la. c) Calculez le budget disponible par participant.

Corrigé

a) Âge : personnes âgées, risque de **dénutrition**, baisse du goût et de l'odorat (4.3.10). Rôles : **lien social** et plaisir avant tout (repas partagé contre l'isolement). Déterminants : appareils dentaires (textures tendres), habitudes culinaires anciennes, petit budget. Dérégulation : perte d'appétit liée au deuil (prises alimentaires réduites). Évaluation : plaisir, quantités mangées, envie de revenir. **b)** Un parmentier de poisson enrichi (purée au lait et au fromage râpé, poisson émietté), suivi d'une compote maison : texture tendre, recette connue, enrichi en protéines, parfumé (muscade, persil) ; préparé ensemble et mangé à table ensemble. **c)** 18 / 6 = **3,00 €** par participant.

4.6.3 Dix questions d'entretien pour s'entraîner

À l'entretien de l'épreuve E5, le jury part de votre dossier ou de votre atelier pour vérifier que vous **maîtrisez les notions** et que vous savez les **relier à une situation**. Entraînez-vous à répondre à voix haute en 1 minute à chaque question, puis comparez avec les éléments de réponse.

À l'oral – Dix questions et les éléments attendus

1. « Quelle différence faites-vous entre rassasiement et satiété ? » Le rassasiement met fin au repas, pendant la prise ; la satiété est l'absence de faim après le repas, qui détermine le délai jusqu'au repas suivant (4.3.3). Exemple : une boisson sucrée rassasie peu.

2. « Qu'est-ce que la restriction cognitive, et pourquoi en parler dans une action collective ? » Un contrôle mental de l'alimentation qui ne tient plus compte des sensations, avec un cycle de désinhibition et de culpabilité (Herman et Polivy, 1975) ; une action qui prescrit des interdits peut l'aggraver.

3. « Citez trois déterminants de l'alimentation de votre public et dites sur lequel votre action agit. » Un déterminant individuel, un social, un environnemental (4.3.4), puis préciser le niveau du modèle socio-

écologique visé par l'action.

4. « Comment avez-vous pris en compte les pratiques religieuses ? » On a **demandé** aux participants, sans supposer ; recette de base acceptable par tous, variantes à part, vérification des ingrédients cachés, calendrier (4.3.15).

5. « Pourquoi ne pas avoir donné de liste d'aliments interdits ? » Parce que l'interdit augmente l'attrait (études de Fisher et Birch) et la restriction ; on préfère l'ajout, le remplacement et le plaisir.

6. « Comment savez-vous que votre recette a plu ? » Échelle hédonique, calcul d'un taux d'acceptation, remarques recueillies, quantité de restes (4.3.11, 4.3.16).

7. « Un parent vous dit que son enfant refuse tous les légumes. Que lui répondez-vous ? » La néophobie est normale entre 2 et 10 ans ; exposition répétée sans pression, modèle de l'adulte, partage des responsabilités (4.3.9) ; orientation si la sélectivité s'accompagne de perte de poids.

8. « Qu'est-ce qu'une alimentation durable ? » Une alimentation qui protège la santé et l'environnement, accessible, culturellement acceptable et économiquement juste (FAO, 2010) ; les quatre dimensions vont ensemble (4.3.12).

9. « Quelle est la limite de votre rôle face à une personne qui présente peut-être un TCA ? » Le diététicien ne diagnostique pas en action collective ; il repère, écoute et oriente vers le médecin, avec discrétion (4.3.13).

10. « Vos chiffres viennent d'où ? » Citer la source, l'année et la méthode (Ciqual 2025, enquête Insee, avis ANSES, données recueillies auprès du public), et préciser quand une donnée est fictive ou ancienne.

Méthode pas à pas – Construire une réponse orale en trois temps

1. Définir la notion en une phrase, avec le mot exact.

2. Illustrer par un élément de votre stage ou de votre atelier (un chiffre, une phrase d'un participant, une décision).

3. Justifier : relier la notion au choix que vous avez fait, et citer une source datée si possible.

Exemple : « La néophobie est la peur de goûter un aliment nouveau. Au relais petite enfance, plusieurs parents nous ont dit que leur enfant refusait les légumes verts. C'est pour cela que nous avons proposé des dégustations répétées sans obligation, comme le recommandent les études sur l'exposition répétée. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.6 – Préparer l'épreuve

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six questions pour lire un contexte imposé d'atelier culinaire.
2. Quels sont les trois temps d'une réponse orale bien construite ?
3. Pourquoi faut-il préciser qu'une donnée est fictive ?
4. Dans le contexte du foyer de l'ASE (4.6.2), pourquoi les garnitures sont-elles sans porc pour tous ?

Corrigé – Point d'étape 4.6

1. Quel âge et quel stade ? Quels rôles de l'acte alimentaire ? Quelles pratiques ? Quels déterminants ? Quelles régulations ou dérégulations ? Comment évaluer ?
2. Définir, illustrer, justifier.
3. Par honnêteté scientifique : le jury doit pouvoir distinguer une donnée réelle et sourcée d'un exemple construit pour l'exercice.
4. Pour que tous les jeunes mangent le même plat, sans mettre à part ceux qui ne mangent pas de porc.

4.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Comportement et régulation

- **Rôles de l'acte alimentaire** : biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique.
- **Comportement alimentaire** : ensemble des conduites (choix, prises, rythmes, quantités, contexte) ; **besoin** (physiologique) ≠ **envie** ; **oralité** ; **pulsion**.
- **Faim** (avant, ghréline) → **rassasiement** (pendant, CCK, distension, rassasiement sensoriel spécifique) → **satiété** (après, GLP-1, PYY, insuline, leptine).
- Régulation **homéostatique** (hypothalamus) et **hédonique** (récompense, dopamine), influencée par les facteurs **cognitifs** et **environnementaux**.
- Dérégulations : **restriction cognitive** (Herman et Polivy, 1975 ; cercle vicieux), alimentation **émotionnelle**, **externalité**, grignotage, compulsions ; **TCA** : repérer et orienter (BC1).

À retenir – Pratiques

- Modèle français : 3 repas, à table, en commun ; part de l'alimentation dans la consommation : 35 % (1960) → 20 % (2014) ; hausse du hors-foyer, du snacking, des plats préparés.
- **Syncrétisme culinaire** : combinaison de cultures culinaires.
- 2020 : **2 %** de végétariens, pescétariens et végétaliens ; **24 %** de flexitariens (Ifop pour FranceAgriMer).
- Végétalisme : **supplémentation en vitamine B12 obligatoire** ; vigilance sur fer, calcium, iode, zinc, oméga-3.
- Accompagner : comprendre, respecter, partir de l'existant, préserver le plaisir, sécuriser, orienter.

À retenir – Compléments : rythmes, enfance, mesure, durabilité

- **Rythmes** : repas, collation (prévue), grignotage (sans faim) ; répartition indicative : petit-déjeuner 20-25 %, déjeuner 35-40 %, goûter 10-15 %, dîner 25-30 % ; régularité ; chrononutrition.
- **Enfant** : diversification entre 4 et 6 mois ; néophobie 2-6 ans ; 8 à 15 expositions ; partage des responsabilités (Satter) : le parent décide quoi, quand, où ; l'enfant si et combien.
- **Âges de la vie** : adolescence (petit-déjeuner, boissons, TCA), grossesse, personnes âgées (dénutrition) ; charge mentale alimentaire.
- **Mesure** : rappel de 24 h, carnet, fréquence, observation, pesée des restes.
- **Durabilité** : définition FAO (2010) ; EAT-Lancet (2019 ; mise à jour 2025) : environ 14 g de viande rouge par jour ; bœuf ≈ 50 fois l'empreinte des lentilles par portion ; gaspillage ≈ 3,8 millions de tonnes de parties comestibles en 2023 (SDES, 2025) ; NOVA et ultra-transformation.

4.8 Entraînement

4.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Le rassasiement :

a) survient pendant le repas **b)** conduit à l'arrêt de la prise alimentaire **c)** correspond à l'absence de faim entre deux repas **d)** est influencé par la distension gastrique

QCM 2 – La ghréline est :

a) une hormone orexigène sécrétée par l'estomac **b)** une hormone sécrétée par le tissu adipeux **c)** augmentée avant les repas **d)** une hormone de satiété

QCM 3 – La leptine :

a) est sécrétée par le tissu adipeux **b)** informe sur les réserves énergétiques à long terme **c)** stimule la faim **d)** fait l'objet d'une résistance dans l'obésité

QCM 4 – La restriction cognitive :

a) consiste à manger selon ses sensations **b)** remplace les sensations par des règles mentales **c)** peut favoriser des « craquages »

d) a été décrite par Herman et Polivy

QCM 5 – L'externalité désigne le fait de :

a) manger en réponse à des signaux extérieurs **b)** manger seulement hors du domicile **c)** écouter ses signaux de faim **d)** manger en réponse à la portion servie

QCM 6 – Le rassasiement sensoriel spécifique explique :

a) qu'on ait encore de la place pour le dessert **b)** que le plaisir diminue pour un aliment consommé **c)** l'anorexie mentale **d)** l'intérêt de la variété

QCM 7 – En 2020, la part des Français se déclarant flexitariens est d'environ :

a) 2 % **b)** 8 % **c)** 24 % **d)** 50 %

QCM 8 – Chez une personne végétalienne, il est indispensable de supplémenter en :

a) vitamine C **b)** vitamine B12 **c)** sodium **d)** glucides

QCM 9 – Le syncrétisme culinaire est :

a) la combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes **b)** un régime d'exclusion **c)** un trouble du comportement alimentaire **d)** un résultat de la mondialisation et des migrations

QCM 10 – Face à un participant d'atelier présentant des signes d'anorexie, le diététicien :

a) établit le diagnostic **b)** propose un régime hypercalorique **c)** en parle avec discrétion et oriente vers un professionnel **d)** l'expose devant le groupe pour l'aider

QCM 11 – Les préférences gustatives innées concernent :

a) le sucré **b)** l'amer (attirance) **c)** le salé et l'umami **d)** les légumes verts

QCM 12 – La part de l'alimentation dans la consommation des ménages est passée de :

a) 35 % à 20 % entre 1960 et 2014 **b)** 10 % à 30 % **c)** 50 % à 45 % **d)** elle est restée stable

QCM 13 – Un environnement obésogène se caractérise par :

a) des portions de grande taille **b)** une offre abondante d'aliments très palatables **c)** des déplacements actifs **d)** un marketing omniprésent

QCM 14 – Un régime sans gluten sans diagnostic de maladie cœliaque :

a) est recommandé pour tous **b)** n'a pas de bénéfice démontré et peut coûter plus cher **c)** relève de la prévention quaternaire si on le déconseille **d)** est obligatoire en restauration collective

QCM 15 – Le repas gastronomique des Français :

a) est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2010 **b)** est un plan national de nutrition **c)** illustre la dimension culturelle de l'acte alimentaire **d)** a été supprimé

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**
>
> **1. a, b, d** (c définit la satiété). 2. **a, c**. 3. **a, b, d**. 4. **b, c, d**. 5. **a, d**. 6. **a, b, d**. 7. **c**. 8. **b**. 9. **a, d**. 10. **c**. 11. **a, c** (l'amer est initialement rejeté). 12. **a** (Insee, 2015). 13. **a, b, d**. 14. **b, c**. 15. **a, c**.

QCM 16 – Selon le modèle de Satter, l'enfant décide :

a) de ce qui est proposé **b)** s'il mange **c)** de la quantité qu'il mange **d)** de l'heure des repas

QCM 17 – Une collation se distingue du grignotage car elle :

a) est prévue **b)** répond à une faim **c)** est prise devant un écran **d)** est structurée

QCM 18 – Le régime de santé planétaire (EAT-Lancet, 2019) prévoit environ, par jour :

a) 14 g de viande rouge **b)** 150 g de viande rouge **c)** 75 g de légumineuses **d)** 300 g de légumes

QCM 19 – La DDM (date de durabilité minimale) signifie :

a) « à consommer jusqu'au » **b)** « à consommer de préférence avant » **c)** que le produit peut encore être consommé après la date **d)** que le produit est dangereux après la date

QCM 20 – La classification NOVA :

a) classe les aliments selon leur degré de transformation **b)** est identique au Nutri-Score **c)** comporte 4 groupes **d)** a été proposée au Brésil

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. b, c. 17. **a, b, d**. 18. **a, c, d**. 19. **b, c**. 20. **a, c, d**.

4.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : faim, rassasiement, satiété

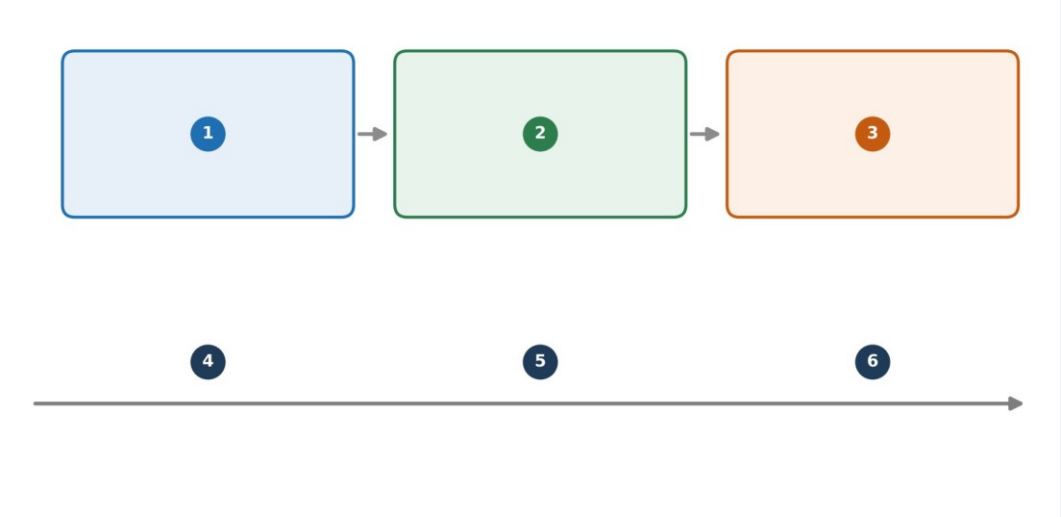


Figure 4.9 – Schéma à légender

Légendez les cases 1 à 3 (notion, moment, hormones) et les repères 4 à 6.

Corrigé

1. Faim (ghréline, estomac vide). 2. **Rassasiement** (CCK, distension gastrique, rassasiement sensoriel spécifique). 3. **Satiété** (GLP-1, PYY, insuline, leptine). 4. **Avant le repas**. 5. **Pendant le repas**. 6. **Entre deux repas**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la restriction cognitive

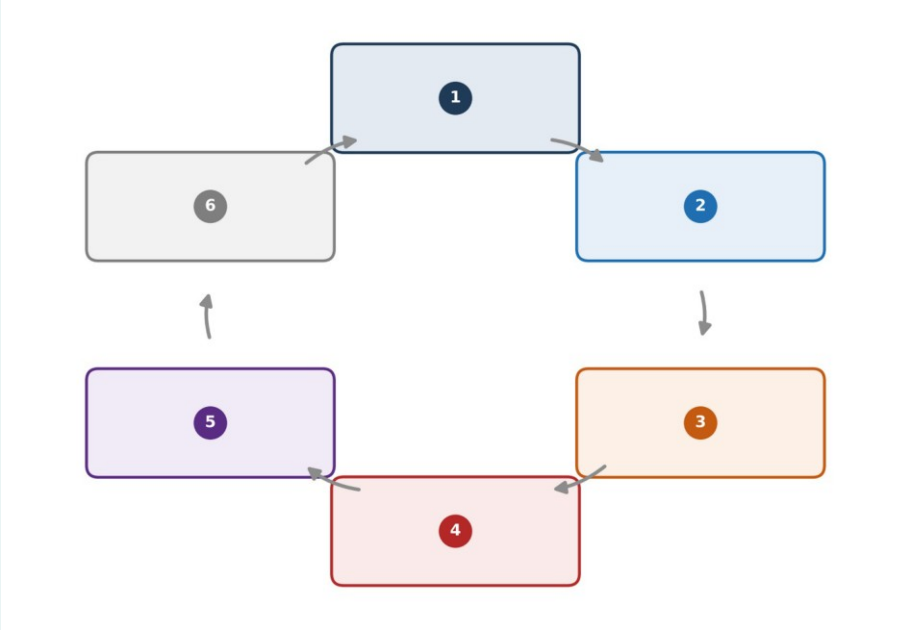


Figure 4.10 – Schéma à légender

Légendez les étapes 1 à 6 du cercle vicieux et proposez deux messages de prévention.

Corrigé

1. Insatisfaction corporelle / volonté de maigrir. 2. Restriction cognitive. 3. Frustration, faim, envies. 4. Perte de contrôle (craquage). 5. Culpabilité, baisse de l'estime de soi. 6. Reprise de poids, nouveaux régimes. **Messages** : « Aucun aliment n'est interdit : c'est la fréquence et la quantité qui comptent » ; « Écoutez votre faim et votre rassasiement : mangez lentement et savourez ».

À vous de jouer – Exercice 3 – Rôles de l'acte alimentaire

Pour chaque situation, identifiez le ou les rôles en jeu : a) le couscous du dimanche chez la grand-mère ; b) une boisson de récupération après un match ; c) une tablette de chocolat après une rupture amoureuse ; d) le repas de Noël ; e) le choix d'un produit en promotion.

Corrigé

a) Social, culturel et identitaire, hédonique. b) Biologique. c) Psychologique (réconfort), hédonique. d) Social, culturel (fête), hédonique. e) Économique.

À vous de jouer – Exercice 4 – Analyser un comportement

M. B., 45 ans, chauffeur routier, mange au volant, grignote quand il s'ennuie, saute le petit-déjeuner et mange beaucoup le soir. Identifiez les dérégulations et les déterminants, puis proposez trois conseils réalistes.

Corrigé

Dérégulations : grignotage et alimentation émotionnelle (ennui) ; externalité (manger par habitude au volant) ; déstructuration des prises (petit-déjeuner sauté, excès le soir). **Déterminants** : conditions de travail (horaires, sédentarité, offre des aires d'autoroute), solitude, temps. **Conseils** : préparer une glacière avec un repas et des collations prévues (fruits, fruits à coque, produits laitiers) ; faire de vraies pauses repas hors du camion ; prendre une collation le matin s'il n'a pas faim au réveil ; boire de l'eau à portée de main pour limiter

le grignotage d'ennui.

À vous de jouer – Exercice 5 – Sécuriser une pratique végétalienne

Une étudiante devient végétalienne. Listez les nutriments à surveiller et des sources végétales pour chacun.

Corrigé

- **Vitamine B12** : aucune source végétale fiable → **supplément obligatoire**.
- **Protéines** : légumineuses, soja (tofu, tempeh), céréales, fruits à coque ; associer légumineuses et céréales.
- **Fer** : légumineuses, céréales complètes, tofu, graines ; avec un aliment riche en vitamine C ; éviter le thé au repas.
- **Calcium** : boissons végétales enrichies, tofu au calcium, eaux minérales riches en calcium, choux, amandes.
- **Vitamine D** : exposition solaire, aliments enrichis, supplémentation selon avis médical.
- **Iode** : sel iodé (en quantité modérée), algues avec prudence.
- **Oméga-3** : huile de colza, noix, graines de lin ; éventuellement huile d'algues.
- **Zinc** : légumineuses, céréales complètes, graines.

À vous de jouer – Exercice 6 – Adapter un atelier pendant le Ramadan

Un atelier hebdomadaire a lieu à 17 h dans un centre social dont plusieurs participantes jeûnent. Proposez des adaptations.

Corrigé

Décaler l'atelier en soirée (rupture du jeûne) ou proposer une séance sans dégustation sur place avec préparation à emporter ; thème « rupture du jeûne équilibrée » (dattes et eau, soupe de légumes et de lentilles, plat complet, fruits) ; conseils d'hydratation entre le coucher et le lever du soleil ; prise en compte de la fatigue ; respect total des choix de chacune (certaines ne jeûnent pas).

À vous de jouer – Exercice 7 – Interpréter des données d'évolution

La part de l'alimentation dans la consommation des ménages est passée de 35 % en 1960 à 20 % en 2014. Calculez la baisse en points et en pourcentage, et proposez deux explications.

Corrigé

Baisse en points : 35 − 20 = **15 points**. Baisse relative : 15 / 35 × 100 = **42,9 %**. Explications : hausse des revenus plus rapide que celle des dépenses alimentaires (loi d'Engel : la part de l'alimentation diminue quand le revenu augmente) ; développement d'autres postes (logement, transports, loisirs, communication) ; baisse relative des prix agricoles. Cette moyenne masque des écarts : la part de l'alimentation reste plus élevée chez les ménages modestes.

À vous de jouer – Exercice 8 – Concevoir une activité de pleine conscience

Rédigez le déroulé d'une dégustation en pleine conscience de 15 minutes avec un carré de chocolat ou un quartier d'orange.

Corrigé

1. Installation au calme, sans écran (1 min). 2. Observer l'aliment : couleur, forme, brillance (2 min). 3. Le sentir, noter les odeurs (2 min). 4. Le mettre en bouche sans croquer, sentir la texture et les saveurs qui évoluent (3 min). 5. Mâcher lentement, avaler, noter l'arrière-goût (3 min). 6. Évaluer son envie d'un deuxième morceau sur une échelle de 0 à 10 (1 min). 7. Échanges : qu'avez-vous remarqué ? qu'est-ce qui change quand on mange lentement ? (3 min).

À vous de jouer – Exercice 9 – Échelle de la faim

Construisez une échelle de la faim de 0 à 10 utilisable avec des enfants (mots et pictogrammes) et expliquez comment l'utiliser.

Corrigé

0 : « J'ai très faim, j'ai mal au ventre » ; 2 : « J'ai faim » ; 4 : « J'ai un petit creux » ; 5 : « Je n'ai ni faim ni plus faim » ; 7 : « Je n'ai plus faim, c'est bien » ; 9 : « J'ai trop mangé, le ventre est lourd » ; 10 : « Je me sens mal ». Avec des visages dessinés et un ventre qui se remplit. **Utilisation** : avant le goûter et en fin de repas, l'enfant montre sa position ; on l'aide à commencer à manger vers 2-4 et à s'arrêter vers 7, sans obligation de finir.

À vous de jouer – Exercice 10 – Choisir des recettes compatibles

Un atelier réunit : une famille végétarienne, deux familles mangeant halal, un enfant allergique à l'arachide. Proposez un menu commun et justifiez.

Corrigé

Entrée : salade de lentilles, carottes et persil ; plat : curry de pois chiches et légumes de saison au lait de coco avec riz ; dessert : compote de pommes à la cannelle et biscuits maison sans arachide. **Justification** : plat végétarien (convient à tous, sans question de viande halal) ; aucun ingrédient à base d'arachide et vérification des étiquettes (traces) ; légumineuses + céréales (complémentarité protéique) ; coût faible ; plaisir et convivialité.

4.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi le plaisir doit-il être intégré à l'éducation nutritionnelle ?

Corrigé

Parce que le plaisir est un rôle central de l'acte alimentaire, qu'il participe à la régulation (rassasiement sensoriel), à la convivialité et à l'adhésion aux conseils ; un message qui le supprime favorise la restriction cognitive et l'abandon. Le modèle français, qui associe plaisir et repas partagé, est considéré comme protecteur.

À vous de jouer – Question 2

Les régimes restrictifs sont-ils une solution de santé publique à l'obésité ?

Corrigé

Non : ils exposent à la restriction cognitive, à l'effet yo-yo, à des carences et à des TCA, et ne modifient pas l'environnement obésogène ni les déterminants sociaux. La santé publique privilégie l'action sur l'environnement (offre, prix, marketing), la promotion d'une alimentation favorable et du plaisir, l'activité physique, et la non-stigmatisation ; la prise en charge individuelle de l'obésité relève du soin, coordonné par le médecin.

À vous de jouer – Question 3

Comment concilier respect des pratiques alimentaires et recommandations nutritionnelles ?

Corrigé

En distinguant ce qui relève du **choix** de la personne (végétarisme, religion, culture), que l'on respecte, et ce qui relève de la **sécurité** nutritionnelle (B12 chez le végétalien, protéines chez la personne âgée), que l'on garantit ; en adaptant les repères à la pratique (sources de fer végétales, plats halal équilibrés) et en négociant des changements compatibles.

4.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – La résidence étudiante

Une résidence universitaire de 300 étudiants : nombreux repas sautés, livraisons de repas le soir, régimes « healthy » vus sur les réseaux, quelques étudiants végétaliens, budget serré, kitchenettes avec deux plaques et un micro-ondes.

1. Identifiez les rôles de l'acte alimentaire négligés et les dérégulations possibles.
2. Analysez les déterminants.
3. Proposez un cycle de 3 ateliers.
4. Comment aborder le végétalisme sans jugement ?
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation.

Corrigé

1. Rôles négligés : **social** (repas seuls), **biologique** (repas sautés) ; dérégulations : déstructuration des prises, grignotage, restriction cognitive liée aux régimes « healthy », externalité (livraisons).
2. Déterminants : budget, équipement limité, temps, rythme des études, isolement, influence des réseaux sociaux, offre de livraison.
3. Atelier 1 « Cuisiner en kitchenette » (deux plaques, micro-ondes : bowls complets en 15 min). Atelier 2 « Manger avec plaisir, sans régime » (sensations, pleine conscience, décryptage des contenus des réseaux). Atelier 3 « Repas partagé végétal et économique » (légumineuses, batch cooking, convivialité).
4. Respecter le choix ; informer sur la B12 et les nutriments à surveiller ; proposer des recettes végétaliennes complètes ; orienter vers le service de santé universitaire si besoin.
5. Proportion d'étudiants déclarant sauter un repas par jour (avant/après) ; nombre de participants et satisfaction ; nombre de recettes refaites déclarées.

4.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Quelle différence entre rassasiement et satiété ? »

Corrigé

Le rassasiement se développe pendant le repas et conduit à l'arrêter ; la satiété est l'absence de faim après le repas, jusqu'au repas suivant.

Mise en situation – MSE 2

Une participante dit : « Je ne mange plus de pain, ça fait grossir. »

Corrigé

Je l'écoute, je reconnais son objectif, j'explique que le pain (surtout complet) est un féculent recommandé et rassasiant, que c'est la quantité et ce qu'on y ajoute qui comptent, et je l'alerte doucement sur le risque de « craquage » lié aux interdits.

Mise en situation – MSE 3

Un parent s'inquiète : son enfant de 3 ans refuse tous les légumes.

Corrigé

Je le rassure : la néophobie est normale à cet âge ; je conseille de proposer régulièrement les légumes sans forcer ni récompenser, de les manger soi-même devant l'enfant, de varier les présentations et de l'impliquer dans la préparation.

Mise en situation – MSE 4

Un élève végétalien de 16 ans demande si son alimentation est « saine ».

Corrigé

Je respecte son choix et vérifie les points essentiels : supplément de vitamine B12 indispensable, sources de protéines, calcium, fer, iode ; je l'encourage à en parler à son médecin pour un suivi, compte tenu de sa croissance.

Mise en situation – MSE 5

Qu'est-ce que l'oralité alimentaire ?

Corrigé

L'ensemble des fonctions de la bouche liées à l'alimentation (succion, déglutition, mastication, goût), qui se construit de la vie fœtale à l'enfance ; certains enfants présentent des troubles de l'oralité nécessitant une prise en charge spécialisée.

Mise en situation – MSE 6

Un participant explique qu'il mange « pour se calmer ».

Corrigé

C'est de l'alimentation émotionnelle ; sans juger, je propose de repérer les situations déclenchantes et d'autres réponses possibles (marcher, respirer, appeler quelqu'un), et j'oriente vers un professionnel si la souffrance est importante.

Mise en situation – MSE 7

Pourquoi proposer des repas partagés à des personnes âgées ?

Corrigé

Parce que la convivialité stimule l'appétit (facilitation sociale), réduit l'isolement et prévient la dénutrition ; le rôle social de l'acte alimentaire est un levier de santé.

Mise en situation – MSE 8

Une collègue veut supprimer les desserts dans un atelier pour des enfants.

Corrigé

Je propose plutôt des desserts maison peu sucrés et des fruits ; supprimer les desserts les rend plus désirables et ignore le rôle hédonique ; on peut travailler la quantité et la qualité sans interdiction.

Mise en situation – MSE 9

Un participant suit un jeûne intermittent vu sur internet et demande votre avis.

Corrigé

J'explique que les preuves de supériorité à long terme sont limitées, que la pratique peut convenir à certains mais présente des risques (restriction, craquages) et des contre-indications (diabète traité, grossesse, TCA, adolescence) ; je l'invite à en parler à son médecin s'il a une pathologie.

Mise en situation – MSE 10

Comment tenez-vous compte des pratiques halal dans un atelier ?

Corrigé

Je recueille les pratiques à l'inscription, je propose des recettes sans porc ni alcool, j'achète la viande halal si nécessaire ou je privilégie des plats végétariens qui conviennent à tous, et je vérifie les ingrédients cachés (gélatine, arômes).

Mise en situation – MSE 11

Donnez un exemple de syncrétisme culinaire.

Corrigé

Un couscous aux légumes de saison français, une pizza aux légumes du marché et épices orientales, des galettes de sarrasin garnies à la façon d'un taco.

Mise en situation – MSE 12

Pourquoi ne pas obliger un enfant à finir son assiette ?

Corrigé

Parce que cela l'habitue à ignorer son rassasiement et favorise l'externalité ; mieux vaut servir de petites portions et permettre de se resservir.

4.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Répartition de l'énergie

Une personne âgée consomme 1 500 kcal : petit-déjeuner 450 kcal, déjeuner 600 kcal, goûter 0, dîner 300 kcal, prises nocturnes 150 kcal. Calculez les parts et proposez des ajustements pour prévenir la dénutrition.

Corrigé

Total : 450 + 600 + 0 + 300 + 150 = **1 500** . Parts : petit-déjeuner **30 %** ; déjeuner **40 %** ; goûter **0 %** ; dîner **20** ✓ % ; nuit **10 %.** Ajustements : ajouter un goûter enrichi (laitage, pain, fruit : environ 250 kcal), enrichir le dîner (fromage râpé, œuf), conserver le petit-déjeuner copieux (atout), vérifier le jeûne nocturne (moins de 12 heures recommandées en institution) ; objectif : augmenter l'apport total (pesée régulière, avis médical).

À vous de jouer – Exercice 12 – Exposition répétée

Une crèche veut faire accepter les lentilles. Elles sont proposées 3 fois par semaine sous des formes variées. Combien de semaines pour 12 expositions ? Résultats : 20 enfants ; acceptation à la 1re exposition 4, à la 6e 9, à la 12e 15. Calculez les taux et commentez.

Corrigé

12 / 3 = **4 semaines**. Taux : 4 / 20 = **20 %** ; 9 / 20 = **45 %** ; 15 / 20 = **75 %.** L'acceptation progresse avec la répétition, sans pression ; il reste 25 % d'enfants qui refusent : poursuivre, varier les présentations (purée, soupe, galettes), associer les parents.

À vous de jouer – Exercice 13 – Empreinte carbone et coût

Une cantine sert 400 repas par jour, 4 jours par semaine, avec un plat de bœuf (100 g) une fois par semaine. Elle le remplace par un chili de haricots rouges (portion de haricots secs : 60 g, environ 0,07 kg CO2e). Calculez la réduction d'émissions sur une année scolaire de 36 semaines (bœuf : 2,8 kg CO2e par portion).

Corrigé

Réduction par repas : 2,8 − 0,07 = **2,73 kg** CO2e. Par semaine : 2,73 × 400 = **1 092 kg**. Sur 36 semaines : 1 092 × 36 = **39 312 kg**, soit environ **39,3 tonnes** d'équivalent CO2 (ordre de grandeur). Le plat végétarien hebdomadaire est d'ailleurs obligatoire en restauration scolaire (loi EGalim, puis loi Climat et résilience) ;

condition de réussite : une recette appréciée (chapitre 4, annale 3).

À vous de jouer – Exercice 14 – Questionnaire de fréquence

Sur 50 lycéens, nombre de jours avec petit-déjeuner la semaine d'école précédente (5 jours) : 0 jour : 9 ; 1-2 jours : 8 ; 3-4 jours : 12 ; 5 jours : 21. Calculez les pourcentages, la part de lycéens prenant un petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 si 7 des 12 lycéens de la classe « 3-4 jours » en prennent 4, et commentez.

Corrigé

Vérification : 9 + 8 + 12 + 21 = **50** . 0 jour **18 %** ; 1-2 jours **16 %** ; 3-4 jours **24 %** ; 5 jours **42 %**. Au moins 4 jours ✓ : 21 + 7 = **28** ; 28 / 50 × 100 = **56 %**. Plus d'un lycéen sur six ne prend jamais de petit-déjeuner les jours d'école : action prioritaire (petit-déjeuner rapide, à emporter, horaires du bus).

À vous de jouer – Exercice 15 – Anti-gaspillage

Une famille jette chaque semaine 1,2 kg d'aliments (pain, fruits abîmés, restes) d'une valeur moyenne de 3,50 €/kg. Calculez la perte annuelle en kg et en euros et proposez 4 gestes.

Corrigé

1,2 × 52 = **62,4 kg** par an ; 62,4 × 3,50 = **218,40 €** par an. Gestes : liste de courses et menus de la semaine ; rangement (premier entré, premier sorti) ; comprendre DLC et DDM ; recettes de restes (pain perdu, compote, soupe, gratin) ; congeler les portions en trop.

4.8.7 Exercices d'approfondissement

À vous de jouer – Exercice 16 – Adapter une recette aux pratiques religieuses

Une recette de quiche lorraine (lardons, crème, lait, œufs, pâte au beurre) doit être proposée à un groupe comprenant des personnes musulmanes, juives pratiquantes et végétariennes. Proposez une adaptation unique.

Corrigé

Quiche aux poireaux et fromage de chèvre (sans viande) : convient aux personnes musulmanes et végétariennes ; pour les personnes juives pratiquantes, plat lacté sans viande, donc compatible avec la séparation lait/viande (sous réserve des exigences de cacheroute des ustensiles et des produits, à discuter avec elles) ; vérifier l'absence de gélatine ou d'alcool dans les ingrédients ; signaler les allergènes (lait, œufs, gluten).

À vous de jouer – Exercice 17 – Repérer et orienter

Lors d'un atelier avec des lycéennes, l'une d'elles dit ne manger « qu'une pomme le midi » et a beaucoup maigri selon son amie. Décrivez votre conduite, en distinguant ce que vous faites et ce que vous ne faites pas.

Corrigé

Je fais : je ne commente pas devant le groupe ; je parle avec elle en privé, avec bienveillance, sans jugement ni diagnostic (« J'ai entendu que tu manges peu le midi, comment ça va pour toi ? ») ; j'informe l'infirmière

scolaire, dans le respect de la confidentialité et des règles de l'établissement ; je lui indique les ressources. **Je ne fais pas** : peser, donner un régime « pour reprendre du poids », poser un diagnostic de TCA, en parler à la classe, faire remplir un questionnaire de repérage en public.

4.9 Glossaire

Terme	Définition
Alimentation émotionnelle	Prise alimentaire en réponse à des émotions plutôt qu'à la faim
ARFID	Trouble de restriction ou d'évitement de l'ingestion des aliments, sans préoccupation pour le poids
Besoin	Nécessité physiologique d'apports en énergie, eau et nutriments
Comportement alimentaire	Ensemble des conduites vis-à-vis de l'alimentation (choix, prises, rythmes, quantités, contexte)
Environnement obésogène	Environnement favorisant l'excès d'apports et la sédentarité
Externalité	Prise alimentaire guidée par des signaux extérieurs
Faim	Sensation physiologique poussant à manger
Flexitarisme	Réduction volontaire de la consommation de viande sans l'exclure
Ghréline	Hormone gastrique orexigène
Leptine	Hormone du tissu adipeux signalant les réserves énergétiques
Oralité	Fonctions de la bouche (succion, déglutition, mastication, goût, langage)
Pulsion	Poussée interne peu contrôlée vers la prise alimentaire
Rassasiement	Processus conduisant à l'arrêt de la prise pendant le repas
Rassasiement sensoriel spécifique	Baisse du plaisir pour un aliment consommé, sans baisse pour les autres
Restriction cognitive	Contrôle de l'alimentation par des règles mentales plutôt que par les sensations
Satiété	Absence de faim après le repas, jusqu'au suivant
Syncrétisme culinaire	Combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes
Troubles du comportement alimentaire (TCA)	Troubles psychiatriques : anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique, ARFID
Végétalisme / véganisme	Exclusion de tous les produits animaux (véganisme : mode de vie)
Végétarisme	Exclusion de la viande et du poisson
Alimentation durable	Alimentation saine, accessible, culturellement acceptable et respectueuse des écosystèmes (FAO, 2010)
Chrononutrition	Étude des liens entre horaires des prises alimentaires, rythmes biologiques et santé
Collation	Prise alimentaire prévue, entre deux repas, répondant à une faim
DDM / DLC	Date de durabilité minimale (« de préférence avant ») / date limite de consommation (« jusqu'au »)
Diversification	Introduction progressive d'aliments autres que le lait chez le nourrisson
Exposition répétée	Présentation répétée d'un aliment pour favoriser son acceptation
Habitude	Comportement automatique déclenché par un contexte

Terme	Définition
NOVA	Classification des aliments selon le degré de transformation (4 groupes)
Partage des responsabilités	Modèle de Satter : le parent décide quoi, quand, où ; l'enfant si et combien
Rythme alimentaire	Nombre, horaires et régularité des prises alimentaires

4.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Rôles de l'acte alimentaire, sociologie	[1] Poulain ; [2] Fischler et Masson ; [3] UNESCO
Régulation	[4] Blundell ; [5] Collège des enseignants de nutrition
Dérégulations, TCA	[6] Herman et Polivy ; [7] HAS anorexie ; [8] HAS boulimie et hyperphagie
Évolution des pratiques	[9] Insee 2015 ; [10] CNA avis 90
Pratiques actuelles	[11] FranceAgriMer/Ifop 2020 ; [12] ANSES ; [13] Santé publique France repères 2019 ; [14] HCSP 2025
Approches non restrictives	[15] GROS ; [16] Tribole et Resch

4.12 Bibliographie numérotée

1. Poulain J.-P. *Sociologies de l'alimentation*. Paris, PUF, 2002 (rééd. 2017).
2. Fischler C., Masson E. *Manger : Français, Européens et Américains face à l'alimentation*. Paris, Odile Jacob, 2008.
3. UNESCO. « Le repas gastronomique des Français », inscription au patrimoine culturel immatériel, 2010.
4. Blundell J. E. et coll. « Appetite control: methodological aspects of the evaluation of foods ». *Obesity Reviews*, 2010, 11 (3), p. 251-270.
5. Collège des enseignants de nutrition. *Nutrition* (référentiel). Elsevier Masson, dernière édition.
6. Herman C. P., Polivy J. « Anxiety, restraint, and eating behavior ». *Journal of Abnormal Psychology*, 1975, 84 (6), p. 666-672.
7. HAS. *Anorexie mentale : prise en charge*. Recommandation de bonne pratique, 2010.
8. HAS. *Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge*. Recommandation de bonne pratique, juin 2019.
9. Larochette B., Sanchez-Gonzalez J. « Cinquante ans de consommation alimentaire : une croissance modérée, mais de profonds changements ». *Insee Première*, n° 1568, octobre 2015.
10. Conseil national de l'alimentation. *Nouveaux comportements alimentaires*. Avis n° 90, 2022.
11. FranceAgriMer, Ifop. *Végétariens et flexitariens en France en 2020*. 2021.
12. ANSES. *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. 2016.
13. Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. 2019.
14. Haut Conseil de la santé publique. *Recommandations pour l'élaboration du 5e PNNS*. Juin 2025.
15. Apfeldorfer G., Zermati J.-P. *Maigrir sans régime*. Paris, Odile Jacob (approche du GROS).
16. Tribole E., Resch E. *Intuitive Eating*. New York, St Martin's Press, 1995 (rééd.).
17. Schachter S. « Obesity and eating ». *Science*, 1968, 161, p. 751-756.

18. AFSSA. *Avis relatif à la collation matinale à l'école*. 23 janvier 2004.

19. Santé publique France. *Pas à pas, votre enfant mange comme un grand* et recommandations sur la diversification alimentaire. 2021.

20. Satter E. *Child of Mine: Feeding with Love and Good Sense*. Bull Publishing, éd. révisée 2000.

21. Willett W. et coll. « Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 447-492 ; mise à jour : Rockström J. et coll., *The Lancet*, octobre 2025.

22. ADEME. *Agribalyse* (base de données d'impacts environnementaux des aliments), *agribalyse.ademe.fr*.

23. ADEME. *État des lieux des masses de gaspillages alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne alimentaire*. 2016. SDES. *Déchets alimentaires en France et dans l'Union européenne en 2023*. 30 octobre 2025.

24. Monteiro C. A. et coll. « Ultra-processed foods: what they are and how to identify them ». *Public Health Nutrition*, 2019, 22 (5), p. 936-941.

25. Lally P. et coll. « How are habits formed: modelling habit formation in the real world ». *European Journal of Social Psychology*, 2010, 40 (6), p. 998-1009.

26. FAO. *Sustainable Diets and Biodiversity*. Rome, 2012 (actes du symposium de 2010).

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 4.2.2)

27. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.